Hospital General de Agudos Dr. José María Ramos Mejía

Del Lazareto San Roque al Hospital Ramos Mejía

Historia del hospital y sus servicios

1868–2026

Del Lazareto San Roque al Hospital Ramos Mejía

Historia del hospital y sus servicios

1868–2026

1.ª ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2026.
Libro digital, EPUB. Archivo digital: descarga.
ISBN en trámite.

Editores: Nicolás Alonso – Martín Sívori.

Todos los derechos reservados.
© 2026.
Primera edición en formato digital: julio de 2026.

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del "*Copyright*", y bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

Inscripción Ley 11.723 en trámite.
ISBN edición digital (ePub): en trámite.

Fotografía de tapa: Argentina, Archivo General de la Nación, Departamento Documentos Fotográficos (AR_AGN_DDF/Consulta_INV: 11558_A).

BORRADOR – NO DEFINITIVO

Índice

Prefacio viii

1 El origen del Lazareto San Roque 1

2 La gran epidemia de fiebre amarilla 5

3 Del Lazareto al Hospital San Roque 9

4 El camino hacia la modernidad 12

5 Transformaciones arquitectónicas 15

6 Alimentación 20

7 Alergia 22

8 Anatomía Patológica 24

9 Anestesiología 29

10 Área Programática de Salud 31

11 Cardiología 35

12 Cirugía Cardiovascular 40

13 Cirugía General 42

14 Cirugía Plástica 49

15 Clínica Médica 51

16 Consultorios Externos 58

17 Dermatología 60

BORRADOR — NO DEFINITIVO

18 Diagnóstico por Imágenes **64**

19 Endocrinología **67**

20 Enfermería **70**

21 Farmacia **74**

22 Gastroenterología **77**

23 Geriatría **80**

24 Gestión Administrativa **82**

25 Ginecología y Obstetricia **84**

26 Hematología **89**

27 Hemoterapia **92**

28 Infectología **95**

29 Instrumentación Quirúrgica **97**

30 Kinesiología **100**

31 Laboratorio Central **102**

32 Nefrología **106**

33 Neonatología **108**

34 Neumotisiología **110**

35 Neurocirugía **112**

36 Neurología **115**

37 Nutrición **118**

38 Odontología **119**

39 Oftalmología **121**

40 Oncología y Radioterapia **122**

41 Ortopedia y Traumatología **124**

BORRADOR — NO DEFINITIVO

42 Otorrinolaringología **126**

43 Pediatría **129**

44 Promoción y Protección de la Salud **132**

45 Psiquiatría y Salud Mental **134**

46 Reumatología **137**

47 Servicio Social **139**

48 Terapia Intensiva **141**

49 Urología **143**

50 Premios Nobeles que trabajaron en nuestro Hospital **145**

51 Facultad de Ciencias Médicas UBA **147**

52 Asociaciones y Organizaciones Gremiales **149**

53 Revistas y Órganos Científicos de Difusión: Jornadas Científicas **152**

54 El Arte y Nuestro Hospital **154**

55 Política y Nuestro Hospital **159**

56 La Literatura y Nuestro Hospital **160**

57 El Tango y Nuestro Hospital **162**

58 La Comisión de la Memoria y los Desaparecidos **167**

59 Directores y Vice en la Historia **168**

Bibliografía **170**

BORRADOR - NO DEFINITIVO

"Lo humano es como una soga, en tránsito, un puente entre aquello de lo que provenimos y aquello que iremos."

Friedrich Nietzsche (1844–1900)

"Uno es lo que hace con lo que hicieron de él."

Jean-Paul Sartre (1905–1980)

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Esta obra está dedicada a los centenares de miles de seres humanos del equipo de salud que entregaron sus vidas al servicio del prójimo en nuestro querido Hospital a lo largo de su extensa historia, siendo anónimos héroes de la salud pública.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Prefacio

Es difícil resumir más de 150 años de historia de nuestro querido Hospital. Queremos que se les haga menos difícil y achicar la distancia entre ustedes y nuestro "Ramos". El "Ramos", orgullo de nuestras vidas profesionales: por nuestros pasillos caminaron otras y otros que hasta el día de hoy no tenían un testimonio escrito de la larga y rica historia para la Medicina argentina.

Desde su concepción, los editores sabíamos que iba a ser una historia incompletamente contada, con una cantidad de información faltante importante, con personas que merecían ser nombradas y no lo iban a estar. El paso del tiempo (casi dos siglos) y la falta de documentos escritos de muchas áreas del Hospital (total o parcialmente), por algún momento nos hizo dudar de la ejecución de esta obra. No queríamos pecar de injustos. Sin embargo, prevaleció el peso de todo lo realizado. Algún tipo de documentación física u oral nos permitió de alguna manera reconstruir el entramado de tantas décadas transcurridas, y además el legado de haber entendido que correspondía a esta generación realizarla, porque si no el paso del tiempo iba a generar mayores heridas del olvido. Otro factor lo constituyó el valor intrínseco de esta obra para toda la comunidad médica y no médica: el haber recogido esta información y dejarla por escrito para las generaciones futuras. Nuestro Hospital ha sido uno de los mayores crisoles donde se generó la Medicina argentina de los siglos XIX y XX. Así, forzosamente, esta búsqueda de material histórico fue menos abundante en los primeros setenta años de vida de nuestra Institución, pero aun así el objetivo de este texto era recuperar esos años y asociarlos a relatos de colegas contemporáneos de las últimas décadas, aunque provinieran de la tradición oral. Necesariamente van a quedar trabajadores de salud sin nombrar, y "huecos" de la rica historia por nombrar. Pero es que la falta de registro historiográfico, sin ya el relato de sus actores en forma física, hizo muy difícil la tarea de rendirles el debido homenaje con nombre y apellido. Vaya a esos héroes anónimos también nuestro homenaje y estas palabras. Se observará que, sobre todo en las primeras décadas de nuestra historia hospitalaria, las mismas personas cumplían funciones en varias especialidades o instituciones, justamente dimensionando la tarea ciclópea que les tocó desarrollar

para generar el conocimiento técnico en las áreas que se estaban desarrollando en la Medicina y que luego iban a tener independencia propia en las décadas siguientes. A ellos también nuestro gran reconocimiento. La historia de nuestro Hospital va a ser contada hasta principios del siglo XXI, justamente para evitar incurrir sobre la contemporaneidad, que tanto afecta la objetividad historiográfica.

Observarán cómo, a partir de los Servicios de Cirugía General y Clínica Médica, con el correr de las décadas en el siglo XX fueron desprendiéndose las diferentes especialidades que, a medida que avanzaba el conocimiento médico, se justificaba crear. Y nuestro Hospital fue cuna de muchísimas de ellas.

La historia de nuestro Hospital desde sus comienzos está íntimamente ligada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue el primer Hospital asociado a la docencia en la formación de los futuros médicos de la UBA. Por ello, hemos decidido como editores que en cada capítulo referente a la historia de cada Servicio sea relatada la relación que ha tenido con nuestra Facultad de Medicina de la UBA. También es digno de destacar que, a partir de un hecho lamentable como fue el cierre por la Dictadura Militar en 1978 del Hospital Rawson —cuna de conocimiento médico internacional—, muchos de los colegas de sus diferentes servicios pasaron a formar parte de nuestro Hospital, enriqueciendo aún más la plantilla de personal de salud ya existente con su experiencia y conocimientos.

También la historia de nuestro Hospital estuvo signada por la atención a catástrofes sociales: en el siglo XIX ante las epidemias de cólera y fiebre amarilla (su razón fundacional); en el siglo XX en la atención a los atentados terroristas de las embajadas de Israel; y ya en el siglo XXI, el atentado terrorista de la AMIA, las tragedias de Cromañón y la de la Estación de tren de Once, y las pandemias por el virus Influenza H1N1 y el SARS-CoV-2. Los editores hemos decidido explícitamente no contar los últimos años con detalle, por ser muy recientes, por ser contemporáneos a los acontecimientos luctuosos, y para dejar que el tiempo decante y esta parte de la historia contemporánea sea escrita por las generaciones que nos sucedan; a pesar de que nos ha golpeado fuertemente y ha cambiado muchas de nuestras costumbres y formas de atender pacientes, la organización interna, etc.

Aun así, el objetivo final es estar orgullosos de nuestra historia y del legado que nos hacen a las actuales generaciones. Que se relate la historia de su rol fundamental en la salud pública no significa que sean menos importantes los otros miembros del personal de salud que a lo largo de más de 150 años han permitido el funcionamiento del hospital, y que también hacen a su historia y a su gloria, como los que pertenecen a las diferentes ramas de la medicina (emergentólogos, odontólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, obstétricas, kinesiólogos, bioquímicos, hemoterapeutas, instrumen-

tadoras, etc.), al personal de enfermería, técnicos (imágenes, esterilización, anatomía patológica, odontología, hemoterapia, laboratorio central, hematología, etc.), administrativos (en todas las áreas de recursos humanos, compras, arancelamiento, turnos, facturación, admisión e ingresos, personal de archivos y recepción, de mantenimiento, de alimentación, de limpieza y maestranza, de librería y ropería), a los ayudantes de quirófanos y a todas aquellas personas que han permitido el funcionamiento del Hospital, y que no nombramos y son fundamentales para el normal funcionamiento del hospital. A ellos, y también por ellos y para ellos, se escribe esta historia, para reconocerlos en su arduo trabajo y el legado que nos entregan.

Los autores explícitamente piden perdón por alguna omisión no intencional que se haya filtrado en tan monumental obra, pero valga el párrafo anterior para dar marco a la reparación de sus memorias y al agradecimiento de toda la comunidad hacia su trabajo apasionado. Decenas de miles de seres humanos comprometidos con la Salud Pública han pasado por nuestro querido Hospital en estos más de 150 años, y solo nombraremos a unos pocos; y esto para nada significa que el resto no haya sido parte esencial de nuestro aporte a la Medicina de nuestro país, sino aún más: sin ellos hubiera sido imposible lograr tales logros. Para ellos, héroes anónimos, en esta Obra va nuestro homenaje y reconocimiento por su entrega y trabajo apasionado.

Queremos agradecer a todos los colaboradores (Jefes de Servicio, personal de salud del hospital, médico y no médico) que desinteresadamente nos aportaron información adicional que contribuyó a completar un poco más este rompecabezas: tener una historia de nuestro querido hospital lo más completa posible. Las próximas generaciones seguramente repararán los olvidos, o mejorarán con mayor información esta obra.

Esperamos haber cumplido con humildad el debido homenaje a todos ellos en estos más de 150 años de compromiso con nuestra comunidad, que hicieron grande la historia de nuestra casa, el querido “Ramos”.

Los Editores

Capítulo 1

El origen del Lazareto San Roque

Relatar la historia del Hospital Ramos Mejía implica necesariamente recorrer la propia historia de Buenos Aires. La institución no surgió de forma aislada, sino como la respuesta de una Ciudad que buscaba defenderse de crisis sanitarias sistemáticas.

Santa María de los Buenos Aires fue fundada por primera vez en 1536 por Pedro de Mendoza, experiencia que fracasó entre el hambre y el aislamiento. La segunda fundación, en 1580, encabezada por Juan de Garay, estableció definitivamente la ciudad sobre la ribera del Río de la Plata. Desde entonces, su destino quedó ligado al puerto, que consolidó el papel de la ciudad como puerta de entrada del país y le dio conexión con el mundo.

A mediados del siglo XIX, Buenos Aires vivió una transformación demográfica sin precedentes. La organización del país, la pacificación del territorio y la promesa de tierra y trabajo atrajeron una corriente migratoria masiva. Una ciudad que hacia 1850 apenas superaba los 90.000 habitantes vio multiplicarse su población varias veces en pocas décadas, al punto de que hacia 1880 buena parte de sus vecinos había nacido fuera del país. Ese aluvión inmigratorio se instaló mayoritariamente en el sur de la ciudad, en barrios como San Telmo, Monserrat y La Boca, donde antiguas casonas coloniales fueron subdivididas en conventillos: viviendas colectivas hacinadas, con un único patio, baños compartidos y escasa ventilación, que alojaban a varias familias por habitación.

Esa Buenos Aires crecía aceleradamente pero sin la infraestructura sanitaria indispensable: no había todavía red de agua corriente ni de cloacas, el agua se extraía de pozos y aljibes muchas veces contaminados, y la recolección de residuos era rudimentaria. Los terrenos bajos e inundables de la ciudad se convertían en basurales improvisados, como denunciaba el médico e higienista José Antonio Wilde:

"Los pantanos se tapaban con las basuras. Estos depósitos de inmundicias,

> *estos verdaderos focos de infección, producían, especialmente en verano, un olor insoportable y atraían millares de moscas que invadían a todas horas las casas inmediatas."*[1]

El mismo puerto que impulsaba el progreso, la inmigración y el comercio también facilitaba la circulación de enfermedades que se desplazaban siguiendo rutas marítimas internacionales. El cólera, originado en la India, alcanzó el Río de la Plata en la década de 1860, y encontró en los conventillos del sur —densamente poblados por inmigrantes recién llegados— el terreno ideal para propagarse.

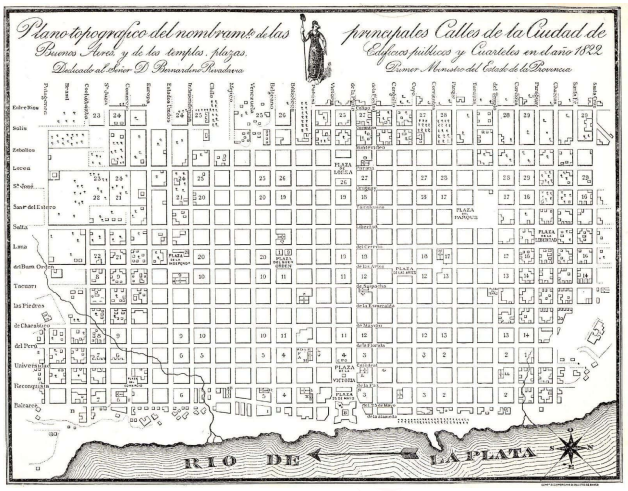


Figura 1.1: Plano topográfico de Bertres, 1822. *Fuente: Archivo General de la Nación.*

Figura 1.2: Buenos Aires á vista de pájaro, 1865. *Fuente: Museo del Bicentenario.*

En 1867, una epidemia mundial de cólera, agravada por el regreso de las tropas de la

Guerra del Paraguay, golpeó con dureza a la población porteña: se registraron más de 5.000 casos coléricos, con 1.653 defunciones, en una ciudad cuya población no alcanzaba entonces las 180.000 personas.[2,3] En 1868, mientras la Argentina combatía en el frente, soldados evacuados regresaron enfermos a una ciudad ya vulnerable. El sistema hospitalario no estaba preparado para una crisis de esa magnitud; el Hospital General de Hombres de San Telmo no podía absorber el número creciente de afectados. Frente a la amenaza, y atendiendo los reclamos higienistas de médicos como Wilde, las autoridades municipales decidieron crear un espacio específico para aislar a los enfermos y evitar la propagación del contagio: así, en 1868, por ordenanza del Dr. Juan Aldao, presidente de la Comisión Municipal y responsable de las cuestiones de higiene y salubridad pública de la ciudad, se dispuso la creación de un pequeño lazareto.[4]

Figura 1.3: Plaza Miserere, 1865. *Fuente: Archivo General de la Nación.*

Los Corrales de Miserere —que darían nombre a la plaza conocida hoy como Plaza Once— tenían ya su propia historia. Ese mismo espacio había sido escenario de episodios decisivos de la historia nacional: durante la Reconquista de 1806, Santiago de Liniers se instaló en estos corrales luego de desembarcar en San Isidro, y desde allí intimó la rendición al general Beresford en el Fuerte Mayor; el 12 de agosto, los mil quinientos soldados ingleses del Batallón 71 capitularon. En 1807, ante una segunda expedición al mando del general Whitelocke, los ingleses cruzaron el Riachuelo por el Paso de Burgos —actual Puente Alsina— y avanzaron hacia estos mismos corrales, donde tomaron posición para el asalto sobre el Fuerte de Buenos Aires. La capitulación de Whitelocke el 5 de julio puso fin a ese capítulo. Sesenta años más tarde, esas mismas tierras serían elegidas para albergar la primera institución sanitaria de la ciudad moderna.[5]

Se buscó entonces un refugio en las afueras del casco urbano, eligiendo la zona de los Corrales de Miserere (actual Plaza Once), un área alta, seca y de profusa vegetación. En una quinta situada en esas inmediaciones, sobre la entonces calle de la Caridad al 600 —hoy General Urquiza—, comenzó a funcionar en 1869 el Lazareto San Roque. Las denominaciones no eran casuales: el término lazareto —heredado de la tradición medieval de los establecimientos bajo la advocación de San Lázaro, patrono de los leprosos— designaba todo lugar de aislamiento para enfermedades contagiosas, mientras que San Roque era el santo peregrino del siglo XIV invocado por tradición como protector contra las pestes.

Las instalaciones eran simples y precarias. El lazareto contaba con dos barracas de adobe, de unos veinte metros de largo, con una capacidad total aproximada de cuarenta camas, y unas casetas de madera destinadas a la administración, la botica, los consultorios externos y el alojamiento del personal. No se trataba todavía de un hospital moderno, sino de un establecimiento de aislamiento, concebido para contener una emergencia.

El emplazamiento, alejado del núcleo urbano más denso y distante del río, respondía a los criterios sanitarios de la época basados en la teoría miasmática, en la que en el aire circulaban los miasmas. Separar al enfermo del resto de la población era la medida central. En una ciudad marcada por el crecimiento desordenado, los problemas de agua potable y la ausencia de cloacas, el lazareto funcionaba como una frontera interna: un borde sanitario dentro de la propia ciudad.

Superado el primer brote de cólera, el establecimiento sanitario no fue desmantelado como se había previsto originalmente. En lugar de ello, el Lazareto San Roque comenzó a recibir pacientes crónicos, dementes y casos incurables que no encontraban lugar en el saturado Hospital General de Hombres de San Telmo.

Figura 1.4: Plano catastral de 1867: las quintas de los Corrales de Miserere, antes de la fundación del Lazareto.

Capítulo 2

La gran epidemia de fiebre amarilla

Un punto de inflexión dramático para el Lazareto San Roque se produjo durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871, considerada la peor catástrofe sanitaria en la historia de Buenos Aires. Lo que había nacido años antes como un refugio temporal para el cólera se transformó, ante la magnitud del desastre, en un bastión crucial para la supervivencia de la ciudad. La tragedia comenzó oficialmente el 27 de enero de 1871, cuando se detectaron los primeros tres casos en los conventillos del barrio de San Telmo. A pesar de las advertencias tempranas de los doctores Luis Tamini, Santiago Larrosa y Leopoldo Montes de Oca, la Comisión Municipal presidida por Narciso Martínez de Hoz desoyó los avisos y no dio a publicidad los casos, permitiendo que la enfermedad se propagara velozmente. La ciudad se paralizó ante una mortalidad que alcanzó picos de más de 500 personas por día, sumando un total aproximado de 14.000 víctimas fatales, lo que representaba el 8% de la población porteña de la época. El pánico provocó un éxodo masivo que redujo la población a menos de la tercera parte y dejó las calles desoladas: el presidente Domingo Sarmiento, su vicepresidente Adolfo Alsina, los cinco ministros del Poder Ejecutivo Nacional, la mayor parte de los diputados y senadores, y la Corte Suprema en pleno abandonaron la ciudad.[6]

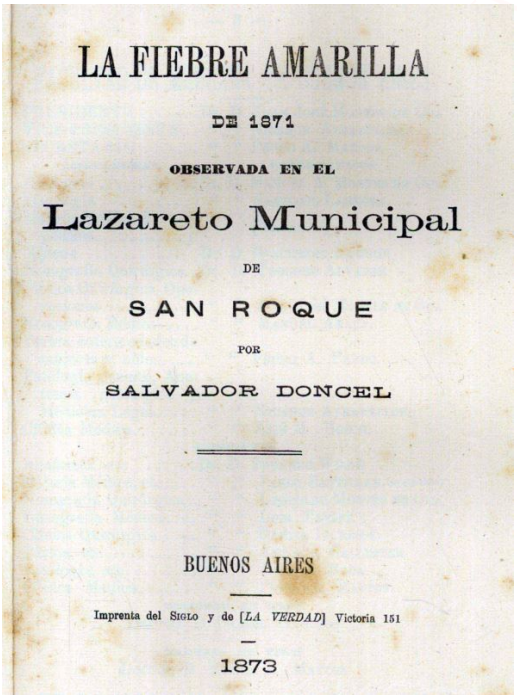
Ante ese vacío de autoridad, se conformó una Comisión Popular presidida por el abogado Roque Pérez —quien, al asumir la tarea, redactó su testamento, consciente de que moriría contagiado; y así ocurrió—. También fallecieron muchos de los médicos que permanecieron para atender a la población, entre ellos Francisco Javier Muñiz y Adolfo Argerich, cuyo sacrificio quedó inmortalizado en el cuadro de Juan Manuel Blanes.[6]

Figura 2.1: Juan Manuel Blanes, *Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires*, 1871. La obra retrata a Roque Pérez y Adolfo Argerich visitando a un enfermo en un conventillo. *Fuente: Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo.*

En este contexto de abandono institucional y saturación de los hospitales General de Hombres, Italiano y Francés, el Lazareto San Roque emergió como un recurso inapreciable para combatir lo que se conocía popularmente como el "vómito negro". Aunque sus condiciones originales eran insuficientes y precarias, consistiendo básicamente en barracas de adobe y casetas de madera, el establecimiento se convirtió en el principal escenario de lucha contra la enfermedad. Bajo la dirección médica del Dr. Pedro A. Mattos, la institución no solo funcionó como centro de aislamiento, sino como un espacio de asistencia crítica para los pacientes que el resto del sistema sanitario ya no podía albergar.

Dentro del personal del Lazareto se destacó de manera heroica la figura del practicante mayor interno, Salvador Doncel, quien encarnó la entrega absoluta al atender personalmente a 2.043 enfermos y realizar 22 necropsias para estudiar la patología en un tiempo en que aún se desconocía su vector de transmisión. En abril de 1871,

el propio Doncel se contagió de fiebre amarilla mientras prestaba servicio, logrando sobrevivir para documentar minuciosamente su experiencia. Su trabajo quedó plasmado en su tesis doctoral de 1873, titulada *La fiebre amarilla de 1871 observada en el Lazareto Municipal de San Roque*, la cual constituye hoy un testimonio semiológico e histórico de valor incalculable que posicionó al lazareto como una institución asistencial y, al mismo tiempo, productora de conocimiento científico. El cuadro de movimiento del Lazareto correspondiente al período comprendido entre el 27 de enero y el 1.º de junio de 1871, reproducido en su tesis, consigna un total de 2.199 ingresos, 982 altas, 1.160 defunciones y 57 pacientes en existencia al cierre del registro —cifras que documentan, con precisión clínica, la magnitud del desborde sanitario—. Además de la de Doncel, otras tres tesis de grado de la época abordaron los casos de fiebre amarilla registrados en el Lazareto San Roque, consolidándolo como un verdadero centro de producción de conocimiento médico.


LA FIEBRE AMARILLA

DE 1871

OBSERVADA EN EL

Lazareto Municipal

DE

SAN ROQUE

POR

SALVADOR DONCEL

BUENOS AIRES

Imprenta del Siglo y de [*LA VERDAD*] Victoria 151

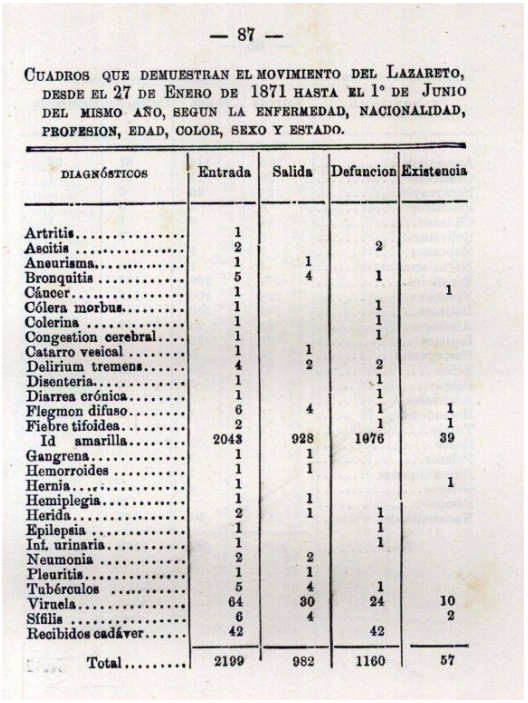
1873

Figura 2.2: Doncel, Salvador (1873). *La fiebre amarilla de 1871 observada en el Lazareto Municipal de San Roque*, Buenos Aires: Impr. del Siglo.

La epidemia fue cediendo con la llegada del frío: el 2 de junio de 1871 no se registró ningún nuevo caso, poniendo fin a la tragedia. La acumulación de cadáveres había desbordado la capacidad del Cementerio del Sur, ubicado donde actualmente se extiende el Parque Ameghino (Av. Caseros al 2300), por lo que el gobierno municipal adquirió siete hectáreas en la Chacarita de los Colegiales —actual Parque Los Andes— para crear el nuevo Cementerio del Oeste, que quince años más tarde se trasladaría al lugar que hoy ocupa el Cementerio de la Chacarita.[6] El rol desem-

peñado por el Lazareto durante la epidemia dejó una marca indeleble en la sanidad pública nacional: había demostrado, en la peor de las circunstancias, que podía sostener a la ciudad cuando el resto del sistema sanitario colapsaba.

El desempeño del Lazareto durante la epidemia puso de manifiesto su rol insustituible en la sanidad pública porteña. Entre 1869 y 1882, albergó a alrededor de 9.000 personas, bajo la conducción sucesiva de Salvador Doncel, Julián Fernández (hijo) y Telémaco Susini.[4] Frente a esta evidencia, el Dr. Julián Aguilar, cirujano de la institución y por entonces director de Hospitales de la Provincia, impulsó su transformación en un Hospital General, proyectando además su ampliación: el paso decisivo que daría origen a la institución que conocemos hoy.

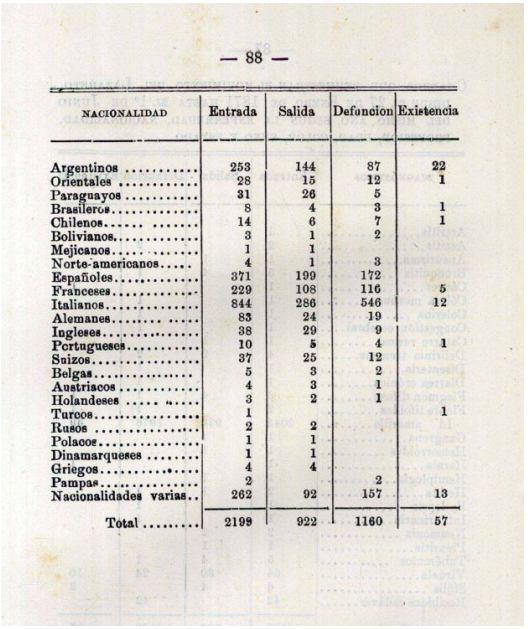


— 87 —

CUADROS QUE DEMUESTRAN EL MOVIMIENTO DEL LAZARETO, DESDE EL 27 DE ENERO DE 1871 HASTA EL 1° DE JUNIO DEL MISMO AÑO, SEGUN LA ENFERMEDAD, NACIONALIDAD, PROFESION, EDAD, COLOR, SEXO Y ESTADO.

DIAGNÓSTICOS	Entrada	Salida	Defuncion	Existencia
Artritis	1			
Ascitis	2		2	
Aneurisma	1	1		
Bronquitis	5	4	1	
Cáncer	1			1
Cólera morbus	1		1	
Colerina	1		1	
Congestion cerebral	1		1	
Catarro vesical	1	1		
Delirium tremens	4	2	2	
Disenteria	1		1	
Diarrea crónica	1		1	
Flegmon difuso	6	4	1	1
Fiebre tifoidea	2		1	1
Id amarilla	2043	928	1076	39
Gangrena	1	1		
Hemorroides	1	1		
Hernia	1			1
Hemiplegia	1	1		
Herida	2	1	1	
Epilepsia	1		1	
Inf. urinaria	1		1	
Neumonia	2	2		
Pleuritis	1	1		
Tubérculos	5	4	1	
Viruela	64	30	24	10
Sífilis	6	4		2
Recibidos cadáver	42		42	
Total	2199	982	1160	57

(a) Movimiento del Lazareto según la enfermedad.



— 88 —

NACIONALIDAD	Entrada	Salida	Defuncion	Existencia
Argentinos	253	144	87	22
Orientales	28	15	12	1
Paraguayos	31	26	5	
Brasileros	8	4	3	1
Chilenos	14	6	7	1
Bolivianos	3	1	2	
Mejicanos	1	1		
Norte-americanos	4	1	3	
Españoles	371	199	172	
Franceses	229	108	116	5
Italianos	844	286	546	12
Alemanes	83	24	19	
Ingleses	38	29	9	
Portugueses	10	5	4	1
Suizos	37	25	12	
Belgas	5	3	2	
Austriacos	4	3	1	
Holandeses	3	2	1	
Turcos	1			1
Rusos	2	2		
Polacos	1	1		
Dinamarqueses	1	1		
Griegos	4	4		
Pampas	2		2	
Nacionalidades varias	262	92	157	13
Total	2199	922	1160	57

(b) Movimiento del Lazareto según la nacionalidad.

Figura 2.3: Cuadros del movimiento del Lazareto San Roque entre el 27 de enero y el 1.° de junio de 1871, reproducidos en la tesis del Dr. Salvador Doncel (1873).

Capítulo 3

Del Lazareto al Hospital San Roque

La experiencia límite de las sucesivas epidemias demostró que el Lazareto era insuficiente, lo que impulsó al Dr. Julián Aguilar a proyectar su transformación definitiva en un Hospital General. Julián Aguilar era, en aquel momento, Director de Hospitales de la Provincia y cirujano de la propia institución.[8] Su prestigio en el campo médico era notable, siendo reconocido como autor de una técnica quirúrgica original para la cura de la hernia inguinal. Bajo su liderazgo, se propuso que el nuevo establecimiento reemplazara al antiguo Hospital General de Hombres, que funcionaba de manera precaria en la vieja residencia de los jesuitas, en el barrio de San Telmo.

El proceso de construcción comenzó formalmente en 1872, bajo la presidencia de la Comisión Municipal de Félix Bernal, momento en el que se confeccionaron los planos a través de la Oficina de Obras Públicas. La obra se presupuestó originalmente en 300.000 pesos oro. Sin embargo, en 1874, el proyecto sufrió un duro revés cuando los créditos se agotaron: los pabellones apenas alcanzaban la altura de los tirantes y solo algunos estaban techados. Las obras quedaron abandonadas durante seis años, período en el cual gran parte de los materiales acumulados se deterioraron a la intemperie.[9]

Figura 3.1: Caricatura del Dr. Emilio R. Coni, por Zavattaro (abril de 1904).

La definitiva organización nacional alcanzada en 1880 fue determinante para la reanudación del proyecto. Tras el breve enfrentamiento armado entre el gobierno de la provincia de Buenos

Aires y las fuerzas del gobierno nacional, Buenos Aires fue federalizada y declarada Capital de la República, designándose a Torcuato de Alvear como su primer intendente; ese mismo año asumió la presidencia Julio Argentino Roca, dando inicio a una etapa de consolidación institucional del país. Bajo este nuevo marco, y con la creación de la Asistencia Pública dirigida por el Dr. José María Ramos Mejía, los trabajos se retomaron finalmente en 1881.[10]

Figura 3.2: Estatua del Dr. Julián Aguilar, en los jardines del Hospital Ramos Mejía.

La dirección de la obra quedó a cargo del arquitecto Juan Antonio Buschiazzo. El edificio se levantó sobre un terreno de 16.900 metros cuadrados —casi dos manzanas— con un estilo arquitectónico sencillo pero elegante, cuyo rasgo más destacado era un gran patio central rectangular con jardín, rodeado de galerías altas y columnas de estilo dórico que unían los pabellones, creando un espacio de inspiración académica. En este proceso fue decisiva la acción del Dr. Emilio Coni, integrante de la Comisión Municipal, quien ante la falta de recursos decidió desviar fondos originalmente destinados a la construcción del Cementerio de la Recoleta para terminar las obras del hospital.[11,12]

Finalmente, el domingo 12 de agosto de 1883 se inauguró formalmente el Hospital San Roque, en una ceremonia presidida por el Dr. Ramos Mejía, director de la Asistencia Pública. En sus inicios contaba con ocho pabellones y 240 camas destinadas exclusivamente a la internación de hombres, distribuidos en torno al gran patio central con jardín. La planta baja del edificio principal albergaba las oficinas de administración y la guardia, mientras que la planta alta estaba destinada a los dormitorios de los médicos y practicantes; el ingreso se realizaba a través de un vestíbulo que conducía directamente a las galerías columnadas que unían los distintos pabellones.[10] El personal estaba compuesto por el director, el Dr. Enrique Revilla, junto a cinco médicos de planta, un administrador, un farmacéutico, cinco practicantes mayores, cinco practicantes menores, cuatro ayudantes de farmacia, cuatro cabos y tres enfermeros.[13] Las discrepancias entre el Dr. Ramos Mejía y el intendente de Buenos Aires derivarían con el tiempo en su renuncia a la conducción de la Asistencia Sanitaria, aunque su vínculo con la institución que había contribuido a crear no se interrumpiría: años más tarde asumiría la dirección del propio hospital.[13] El recuerdo del Dr. Aguilar

como gran impulsor de la obra quedó perpetuado en una estatua de cuerpo completo erigida por sus alumnos y colegas, que hoy preside el jardín central del hospital.

Ese mismo año, la Universidad de Buenos Aires instaló cátedras de la Facultad de Medicina en el flamante hospital, dando inicio a una vocación docente que acompañaría a la institución desde sus primeros días: desde entonces, el Hospital San Roque integró de manera ejemplar las tres funciones que constituyen hoy su identidad —asistencia, docencia e investigación.

(a) Fachada principal del Hospital San Roque en sus primeros años.

(b) Patio central del Hospital San Roque, con su fuente y jardines. *Fuente: Biblioteca Manuel Gálvez.*

(c) Vista exterior del Hospital San Roque sobre la calle Samuel Boote.

(d) Vista del Hospital San Roque y sus jardines. *Fuente: Biblioteca Manuel Gálvez.*

(e) Fachada del Hospital San Roque. *Fuente: Biblioteca Manuel Gálvez.*

(f) Galería interna del Hospital San Roque, con su capilla al fondo. *Fuente: Biblioteca Manuel Gálvez.*

Capítulo 4

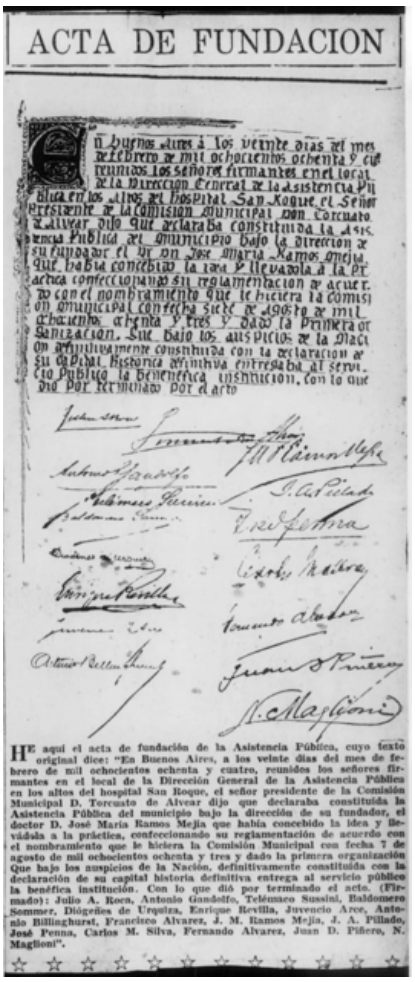
El camino hacia la modernidad: expansión y especialización

Tras su inauguración formal en 1883, la expansión del Hospital San Roque fue notablemente veloz, respondiendo a la presión asistencial de una ciudad en crecimiento exponencial. Aquella vocación docente nacida con la instalación de las primeras cátedras de la Facultad de Medicina fue consolidando un modelo de hospital escuela —el primero en estar asociado a la formación de médicos de la UBA— que integró la asistencia con la docencia y la investigación de vanguardia, articulando el San Roque con la Universidad de Buenos Aires desde sus primeros años de funcionamiento.[8]

Este crecimiento se manifestó en la rápida diversificación de sus servicios. En 1886, la atención comenzó a ser mixta, se creó el servicio de Pediatría bajo la dirección del Dr. Larguía e instaló el primer horno de desinfección de la institución.[10] Para 1888, la demanda sanitaria era tan intensa que, mientras se iniciaba la construcción de cuatro nuevos pabellones, las autoridades se vieron obligadas a improvisar carpas en el jardín para alojar hasta 600 enfermos. Esta imagen de los jardines colmados de tiendas de campaña resultó ser un testimonio elocuente de la presión que la urbe porteña ejercía sobre su infraestructura de salud en las últimas décadas del siglo XIX.

En 1892, el hospital continuó su desarrollo edilicio —aprovechando materiales provenientes de la demolición de la Avenida de Mayo— con la apertura de pabellones para Ginecología y Clínica Médica, además de la inauguración de una Maternidad con entrada independiente y torno para el abandono de expósitos.[10] Por sus servicios pasó Cecilia Grierson, primera médica argentina, quien dio sus primeros pasos profesionales en la institución.

Sin embargo, el motor principal de esta etapa de jerarquización institucional fue el Dr. José María Ramos Mejía, figura polifacética y exponente fundamental de la generación del 80. Ramos Mejía transformó la sanidad de Buenos Aires al crear y dirigir la Asistencia Pública, cuya sede funcionó originalmente en la planta alta del hospital. Este organismo, que representaba lo que hoy conocemos como el Ministerio de Salud de la Ciudad, permitió una planificación sanitaria coordinada para toda la urbe.


ACTA DE FUNDACION

En Buenos Aires á los veinte dias del mes de Febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro reunidos los señores firmantes en el local de la Direccion General de la Asistencia Pública en los altos del hospital San Roque, el Señor Presidente de la Comision Municipal don Torcuato de Alvear dijo que declaraba constituida la Asistencia Pública del municipio bajo la direccion de su fundador el Dr. don José María Ramos Mejia que habia concebido la idea y llevadola á la práctica confeccionando su reglamentacion de acuerdo con el nombramiento que le hiciera la Comisión Municipal con fecha siete de agosto de mil ochocientos ochenta y tres y dado la primera organizacion, que bajo los auspicios de la Nacion, definitivamente constituida con la declaracion de su capital historia definitiva entrega al servicio público la benéfica institucion, con lo que dió por terminado el acto.

HE aquí el acta de fundación de la Asistencia Pública, cuyo texto original dice: "En Buenos Aires, a los veinte días del mes de febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro, reunidos los señores firmantes en el local de la Dirección General de la Asistencia Pública en los altos del hospital San Roque, el señor presidente de la Comisión Municipal D. Torcuato de Alvear dijo que declaraba constituida la Asistencia Pública del municipio bajo la dirección de su fundador, el doctor D. José María Ramos Mejía que había concebido la idea y llevádola a la práctica, confeccionando su reglamentación de acuerdo con el nombramiento que le hiciera la Comisión Municipal con fecha 7 de agosto de mil ochocientos ochenta y tres y dado la primera organización Que bajo los auspicios de la Nación, definitivamente constituida con la declaración de su capital historia definitiva entrega al servicio público la benéfica institución. Con lo que dió por terminado el acto. (Firmado): Julio A. Roca, Antonio Gandolfo, Telémaco Sussini, Baldomero Sommer, Diógenes de Urquiza, Enrique Revilla, Juvencio Arce, Antenón Billinghurst, Francisco Alvarez, J. M. Ramos Mejía, J. A. Pillado, José Penna, Carlos M. Silva, Fernando Alvarez, Juan D. Piñero, N. Maglioni".

Figura 4.1: Acta de fundación de la Asistencia Pública, 20 de febrero de 1884.

En esta misma etapa, el hospital diversificó su oferta médica con la apertura de servicios de Dermatología (liderado por Baldomero Sommer en 1892), Otorrinolaringología y Oftalmología (con pioneros como Eduardo Ovejero, primer director del servicio de ORL del país). En 1904 Ramos Mejía creó la Cátedra de Enfermedades Nerviosas —la segunda del mundo en su especialidad, después de la fundada por Jean-Martin Charcot en Francia—, por la que pasaron discípulos de la talla de José Ingenieros. Para entonces, el establecimiento ya adoptaba tecnologías de punta de la época, contando con farmacia, horno de esterilización y servicios incipientes de electricidad y rayos X.

Ramos Mejía fue, además, el gran impulsor de los Consultorios Externos, promoviendo una función social inédita al abrir la institución al gran público para especialidades como dermatología y otorrinolaringología. Ejerció la dirección del hospital desde 1904 hasta su fallecimiento, ocurrido el 19 de junio de 1914. En reconocimiento a su inmenso legado como médico, sociólogo y docente, el Concejo Deliberante decidió por unanimidad, el 10 de julio de ese mismo año, rebautizar la institución con su nombre.[9] Actualmente, su memoria es custodiada por un busto realizado en 1935 por el escultor José Fioravanti, ubicado en la entrada de la calle Urquiza, recordando el camino de un hospital que nació entre pestes para convertirse en un pilar de la ciencia médica argentina.[11]

Figura 4.2: Dr. José María Ramos Mejía (1849–1914).

Nacido el 24 de diciembre de 1849 en Buenos Aires —hijo de Matías Ramos Mejía y Francisca Madero—, José María Ramos Mejía fue una de las figuras más destacadas de la llamada Generación del 80. Cursó el bachillerato en la Universidad de Buenos Aires, donde sobresalió en historia e historia natural. En 1871 —el mismo año en que la fiebre amarilla devastaba la ciudad— siendo alumno de Medicina, protagonizó junto a su hermano Francisco y otros compañeros el primer movimiento estudiantil en favor de una reforma universitaria en el país, desencadenado por el suicidio de un estudiante injustamente aplazado. El movimiento le costó la suspensión y causas judiciales por "delitos de imprenta", pues fundó el periódico *13 de diciembre*, al que también contribuyeron Vicente Fidel López y Juan María Gutiérrez.

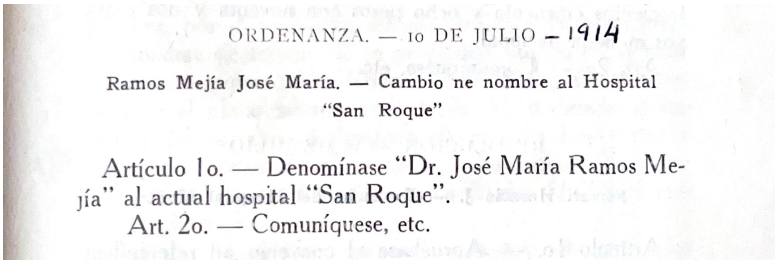
Se graduó en medicina en 1879, con la tesis *Apuntes clínicos sobre el traumatismo cerebral*. Cuatro años antes había fundado el Círculo Médico Argentino —del cual fue primer presidente—, cuya publicación de los *Anales* constituyó un hito de la ciencia médica nacional. Profundamente influido por el positivismo y por las escuelas psiquiátricas francesas —en particular la Salpêtrière, donde brillaban Charcot, Janet y Binet—, Ramos Mejía se especializó en las enfermedades nerviosas y mentales. En 1887 fue designado titular de la Cátedra de Higiene de la Facultad de Medicina, vacante por el retiro del Dr. Guillermo Rawson. Paralelamente, creó y ejerció la Cátedra de Enfermedades Nerviosas en el Hospital San Roque, donde instaló un laboratorio moderno y publicó en 1893 sus *Estudios clínicos sobre las enfermedades nerviosas y mentales*. Entre 1888 y 1892 ocupó una banca de diputado nacional, desde la que impulsó proyectos sanitaristas; luego, convocado por el presidente Luis Sáenz Peña, dirigió el Departamento Nacional de Higiene, instituyendo el lazareto de la Isla Martín García, la Inspección Sanitaria del Puerto y el Laboratorio Epidemiológico. Entre 1908 y 1912 presidió el Consejo Nacional de Educación, promoviendo la integración del inmigrante a través de la escuela pública y los símbolos de la identidad nacional.[11]

Una síntesis de su legado quedó plasmada en las palabras que le dedicó su discípulo José Ingenieros: *"Ramos Mejía representa entre los hombres de esa generación al médico humanista, al médico filósofo, al médico sociólogo, que penetra profundamente en la naturaleza humana y desde el minúsculo escenario de su clínica o desde el otro inmenso de la historia nos muestra, con sus ojos serenos, no las vísceras materiales deformes y sangrantes de una autopsia, sino las almas oscuras o claras, plácidas o tumultuosas que desfilan en nuestra sociedad y en nuestra historia".*

Capítulo 5

Transformaciones arquitectónicas y modernización del hospital

El 10 de julio de 1914, tres semanas después del fallecimiento de José María Ramos Mejía, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires sancionó por unanimidad la Ordenanza que llevaría su nombre al hospital que él mismo había contribuido a fundar y a dirigir durante una década. El texto era breve e inequívoco: *"Denomínase 'Dr. José María Ramos Mejía' al actual hospital 'San Roque'"*.[14] Aquel hospital que había nacido en barracas de adobe para combatir el cólera y la fiebre amarilla pasaba a llevar para siempre el nombre de quien lo había transformado en un centro médico de proyección internacional.



ORDENANZA. — 10 DE JULIO – 1914

Ramos Mejía José María. — Cambio ne nombre al Hospital "San Roque"

Artículo 1o. — Denomínase "Dr. José María Ramos Mejía" al actual hospital "San Roque".

Art. 2o. — Comuníquese, etc.

Figura 5.1: Ordenanza del 10 de julio de 1914 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, por la que se rebautizó el Hospital San Roque con el nombre del Dr. José María Ramos Mejía. *Fuente: Ordenanzas y Resoluciones del Concejo Deliberante, 1914, p. 89.*

A lo largo del siglo XX, el Hospital Ramos Mejía atravesó sucesivas transformaciones arquitectónicas y funcionales destinadas a ampliar su capacidad asistencial y adaptar su estructura a las nuevas demandas de la medicina moderna. Muchas de las características edilicias que hoy reconocemos en el hospital son el resultado de

estas intervenciones, las cuales permitieron el paso de una estructura de pabellones abiertos a un complejo médico tecnificado.

Gran parte del edificio actual se vincula con la importante reforma de 1928. En la década de 1920 se decidió la demolición de la capilla original, ubicada en otro sector del predio, y se construyó una nueva capilla en el centro del parque, con una orientación distinta y una presencia más protagónica en la vida cotidiana del hospital. Al mismo tiempo, las galerías abiertas que rodeaban el gran patio central y que estaban flanqueadas por columnas de estilo similar al dórico griego fueron cerradas con material y vidrios. Esta decisión buscó mejorar la funcionalidad del edificio frente al clima, protegiendo la circulación de pacientes y personal, transformando la imagen arquitectónica del conjunto de un lenguaje más abierto y "sanatorial" a uno más cerrado y compacto. La reinauguración se realizó el 8 de octubre de 1928.[10,8]

La modernización continuó en las décadas siguientes mediante la incorporación de pabellones especializados que ampliaron y diversificaron la oferta de servicios. En 1942 se inauguró el Pabellón Luis Mariano Zuberbühler, destinado al Servicio Central de Rayos, antecedente del actual área de Diagnóstico por Imágenes.[8] En 1946, gracias a la donación de la familia Inchauspe en homenaje al Dr. Luis H. Inchauspe —médico del hospital fallecido ese mismo año—, se inauguró el 24 de septiembre el Pabellón Luis H. Inchauspe, un edificio de cuatro plantas destinado exclusivamente a Cardiología. Fue el primer servicio de cardiología con internación de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y contó con un bioterio en el altillo, lo que permitió desarrollar investigación y tratamiento cardiológico de avanzada.[8] Más tarde, en 1960, se construyó el Laboratorio Central, un edificio con una recepción central y dos alas laterales dedicadas a distintas secciones bioquímicas, acompañando el crecimiento de la medicina basada en el laboratorio.

En 1953, el ministro de Salud Pública de la Nación, el Dr. Ramón Carrillo, llevó adelante una modernización integral de la mayoría de los pabellones del hospital. Las obras incluyeron la creación de un sector de cuidados especiales, la actualización completa de la instalación eléctrica y la incorporación de paneles de cabecera con oxígeno, aspiración y aire comprimido para cada cama hospitalaria, además de áreas específicas para pacientes aislados. En este período también se terminaron de cerrar los pasillos abiertos con columnas que comunicaban los diferentes pabellones y circunscribían la plaza central, consolidando un sistema de circulación interna más protegido.[10]

La historia edilicia del hospital también estuvo marcada por decisiones traumáticas. Durante la última dictadura militar, en 1977, el intendente de facto Osvaldo Cacciatore ordenó la demolición de la Maternidad y del pabellón de la Sala I con

el objetivo de generar espacios de estacionamiento. Estas demoliciones sepultaron parte del patrimonio histórico y obligaron a la reubicación de servicios esenciales dentro del bloque quirúrgico del hospital.[10,4]

En esos mismos años se inauguró el bloque quirúrgico moderno con la puesta en funcionamiento, en la década de 1970, de una planta quirúrgica en el cuarto piso dotada de doce salas de operaciones. En ese mismo sector se instaló la Unidad de Terapia Intensiva, concentrando así la cirugía de alta complejidad y los cuidados críticos para alinear a la institución con los estándares contemporáneos de atención perioperatoria. Simultáneamente, el antiguo pabellón de Hematología fue objeto de profundas reformas para convertirse en la sede de los servicios de Medicina Nuclear, Endocrinología y Medicina Transfusional, reflejando la expansión de especialidades vinculadas al diagnóstico funcional y terapias complejas.

En tiempos más recientes, el establecimiento continuó su proceso de actualización edilicia. En el año 2015 se realizó una importante modificación de la fachada y de los accesos, lo que permitió reorganizar el ingreso al área de Emergencias y al hall central. Asimismo, en 2019, se modernizó la Unidad Coronaria y se renovaron integralmente las salas de internación de Cardiología, incorporando equipamiento tecnológico y condiciones de infraestructura acordes a las necesidades de los pacientes cardiovasculares actuales.[8]

Así, a través de demoliciones, ampliaciones, cierres de galerías, construcción de pabellones especializados y reformas de servicios críticos, el Ramos Mejía fue adaptando su cuerpo de ladrillos a los cambios de la medicina, de la ciudad y de las políticas de salud. El Hospital General de Agudos Dr. José María Ramos Mejía se encuentra ubicado en la calle Urquiza 609, en el barrio de Balvanera. En la actualidad, la institución pertenece a la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y funciona como el hospital de cabecera de su propia Área Programática de Salud.

Imágenes de las transformaciones del hospital

Las siguientes imágenes reúnen distintos registros del hospital: un acto de reinauguración del establecimiento y una serie de vistas de su fisonomía original —galerías, columnas, vestíbulo, patio y jardines—, junto a imágenes del conjunto ya modernizado y de sus accesos en tiempos recientes.

(a) Acto de reinauguración del Hospital Ramos Mejía. *Fuente: Archivo General de la Nación.*

(b) Vestíbulo principal del hospital. *Fuente: Colección César Gotta.*

(c) Patio central del hospital, con sus galerías abiertas. *Fuente: Colección César Gotta.*

(d) Una de las galerías abiertas que rodeaban el patio central. *Fuente: Colección César Gotta.*

(e) Frente principal del Hospital San Roque. *Fuente: Colección César Gotta.*

(f) Frente del pabellón de Obstetricia. *Fuente: Colección César Gotta.*

(a) Detalle de las galerías y columnas del conjunto original.

(b) Jardines del Hospital San Roque, con la capilla y las galerías del conjunto histórico.

(c) Vista general del hospital con sus pabellones de varios pisos, ya modernizados.

(d) Acceso del hospital hacia la década de 1980.

(e) Acceso del hospital hacia la década de 1990.

(f) Acceso del Hospital Ramos Mejía en la actualidad.

Capítulo 6

Alimentación

Figura 6.1: Personal de la División Alimentación del Hospital Ramos Mejía junto al carro de distribución de comidas. *Fuente: Archivo General de la Nación.*

En los registros iniciales del Lazareto ya estaba el relato de la existencia de la cocina. Se desconoce, sin embargo, cómo fue evolucionando el sector a lo largo de las décadas posteriores, aunque seguramente, en la medida en que crecía el tamaño y la complejidad del Hospital, también se fue ampliando en superficie, recursos físicos y humanos.

Dice la actual Jefa de División de Alimentación, la Lic. Graciela Gramisci: "En el año 1983, cuando entré al hospital como alumna, la División Alimentación trabajaba con

un sistema de autogestión: personal, compras, limpieza y elaboración de comidas dependían directamente de la División. La cocina estaba separada en sectores donde se preparaban los diferentes regímenes dietoterápicos. Había un espacio donde se conectaban los carros térmicos a mangueras de gas para su calefacción. A las 10.30-11 hs venían las mucamas —así se llamaban, y cada sala contaba con una como personal fijo— y cargaban las tolvas de sus carros a granel. En cada sala existía un 'office de alimentación'. Hasta allí se conducía el carro, donde la mucama calentaba nuevamente las tolvas en las hornallas y el horno, y servía a cada paciente la sopa y el plato principal de acuerdo con las indicaciones que la nutricionista de cada sala dejaba en una planilla diaria. Cada sala contaba con vajilla completa para los pacientes.

Donde estaba la morgue se realizó una reforma y se hicieron las cámaras frigoríficas para la comida, donde está hoy, por la calle Venezuela, en planta baja.

En el año 1990 se privatizaron los servicios de comidas de los hospitales. Son empresas especializadas las que se hacen cargo del equipamiento, el personal, los carros transportadores, las bandejas térmicas y la mercadería, agilizándose los procesos de compra, recepción de alimentos, preparación de las comidas, servicio y limpieza. Todo, bajo el estricto control y supervisión de la División Alimentación."

Agradecimiento: Se agradece la colaboración de la Lic. Graciela Gramisci, Jefa de División Alimentación, en la redacción de este capítulo.

BORRADOR NO DEFINITIVO

Capítulo 7

Alergia

El Dr. Julio Cruciani, nacido en 1898, fundó y dirigió, antes de cumplir 20 años, la revista *Doctrina Socialista* y participó en las luchas por la Reforma Universitaria. Se graduó de médico en 1924. Desde ese momento inició una intensa labor profesional junto a especialistas de la jerarquía de Bernardo Houssay, Juan José Vitón y Julio Méndez. En 1927 ingresó como docente de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, donde fue nombrado jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Patología Médica, y en 1933 fue nombrado docente libre. Luego de la publicación de su libro *Asma, interpretación actual*, creó el Consultorio de Asma del Hospital Ramos Mejía, primer servicio público del país en esa especialidad.

Figura 7.1: Dr. Julio A. Cruciani (1898–1949).

Además de médico, investigador y docente, Cruciani fue un hombre con profundo sentido solidario. Una anécdota revela ese aspecto de su personalidad: el propio Cruciani contó que en 1923, cuando tenía 25 años, la desgracia de una paciente asmática lo impresionó tanto que comenzó a estudiar estos síndromes, agrupados hoy bajo la denominación de enfermedades alérgicas.

En 1938, por gestión de Cruciani, el Concejo Deliberante de la Capital fundó el Servicio de Enfermedades Alérgicas del Hospital Ramos Mejía y decidió construir un pabellón especial, donde actualmente funciona la División de Hematología. En 1940, por concurso, Cruciani fue nombrado jefe titular de ese servicio, una novedad en el país. En 1941 fue miembro fundador de la Sociedad para el Estudio de la Alergia. Fue autor de cuatro libros y de setenta folletos sobre temas médicos. Murió a los 51 años, en 1949. Al año siguiente, una comisión encabezada por los doctores Bernardo Houssay y Nerio Rojas le rindió homenaje. Un busto suyo, hoy exhibido en la sala de espera de Consultorios Externos de Alergia (101-103), es testigo de su paso por el Hospital.

Figura 7.2: Placa conmemorativa del Dr. Julio A. Cruciani en el barrio de Boedo, 1999.

En 1959, el Concejo Deliberante puso su nombre al pabellón de Alergia del Hospital Ramos Mejía, que él había dirigido. Con la concurrencia de su hijo, un reconocido Juez de la Nación, en 1998 el GCBA le rindió un homenaje en nuestro Hospital al cumplirse el centenario de su nacimiento. Le sucedieron en la jefatura del Servicio los Dres. Bacigaluppi. El servicio de Alergia contaba con internación, tres laboratorios —inmunología, bacteriología y micología— y preparación de extractos de alérgenos para pruebas y tratamiento, en el actual pabellón de Hematología, hasta 1978, cuando se lo trasladó a los consultorios del primer piso del pabellón de Consultorios Externos, en el extremo que da a la calle Venezuela, al lado de Odontología. El equipo estaba conformado por más de diez especialistas en alergia, enfermeros, kinesiólogos y psicólogos para brindar atención integral de las patologías alérgicas.

Posteriormente, los jefes Dres. Emilio Blanco y, luego, Adrián Lara, pudieron reorganizar la actividad asistencial y sostener la producción de extractos alergénicos, hasta que, nuevamente por motivos ajenos, se redujo la capacidad operativa del servicio, quedando abocado solo a la actividad asistencial y docente. Actualmente el servicio cuenta con cuatro médicos de planta y la jefa, Dra. Agustina Zambernardi; continúa siendo uno de los servicios de Alergia destinados a la atención de pacientes adultos más grandes del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires.

Agradecimiento: Al Dr. Adrián Lara, la Lic. Olga Robles y la Dra. Agustina Zambernardi, quienes han colaborado en la redacción del capítulo, nuestro agradecimiento.

Capítulo 8

Anatomía Patológica

El Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Ramos Mejía comienza a funcionar en el año 1904. A fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires tenía como docentes a los Dres. Telémaco Susini, Joaquín Llambías y Pedro I. Elizalde.

Telémaco Susini (1856-1936) se recibió de médico en 1879 en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. A poco de graduado, ganó una beca por tres años para perfeccionarse en Europa, donde compartió capacitación con Pasteur (en París) y con Koch (en Berlín).

Figura 8.1: Dr. Telémaco Susini (1856-1936). *Fuente: Museo de Patología, Facultad de Medicina, UBA.*

Este ámbito le abrió la oportunidad de una amplia experiencia y resultó fundamental para lo que luego vendría. Fue titular de la Cátedra de Anatomía Patológica, designado por el Congreso, entre 1886 y 1917. De inmediato gestionó la fundación de un instituto para llevar adelante la labor de investigación e instrucción del alumnado (reiteraba que prefería la denominación de Anatomía y Biología Patológica), inspirado en el de Pasteur, de reciente funcionamiento en París. Casi de inmediato se abrió el museo, con ricas colecciones, el primero del que dispondría la Universidad. Telémaco Susini fue el último director del Lazareto, antes de su conversión en Hospital de San Roque en 1914. Susini se retiró en 1917, tras 30 años de trabajo. Durante su gestión se habilitó el servicio triquinoscópico de las carnes de cerdo y la construcción del edificio de la Inspección Veterinaria en el Matadero de Liniers, donde trabajaron veterinarios y personal médico buscando asegurar la calidad de las carnes que se enviaban

al consumo. Como complemento se abrieron las estaciones sanitarias de veterinaria.

Participó de protestas estudiantiles y universitarias. En los años de la Reforma Universitaria (1918), el presidente Hipólito Yrigoyen pensó en Susini como "embajador-componedor", pero fue repudiado por los sectores conservadores. En sus escritos médicos protocolizó la descripción de todas las autopsias que se realizaban en la Cátedra, con la descripción macroscópica. Se interesó por el acceso a aguas corrientes y cloacales, las epidemias (cólera, carbunclo, fiebre amarilla, tuberculosis), la divulgación de los métodos pasteurianos y la evolución de las ideas sobre el contagio, la leche de consumo, las nodrizas, la hidrofobia, la prostitución, la higiene escolar y de los ferrocarriles, en general el estado sanitario de la Nación, pero además la influencia de la civilización sobre la salud del individuo y la colectividad: el seguro social, el seguro de enfermedad, la economía y la medicina social. En una Argentina atravesada por la problemática de la inserción de los inmigrantes, las demandas obreras y las protestas de los sectores que clamaban por una sociedad más justa, Susini acompañó esos reclamos. Participó de las jornadas que dieron lugar a la ley n.° 1.420, sobre educación primaria; fue concejal capitalino, miembro honorario nacional de la Academia Nacional de Medicina y titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, a la que ingresó en 1914. Dejó muchos discípulos, entre ellos José Bedía, Fernando Ruiz, Horacio Piñero, Gregorio Aráoz Alfaro, Carlos Malbrán, José Arce y Ángel H. Roffo.

Figura 8.2: Dr. Christofredo Jakob, especialista en neuroanatomía.

El segundo titular de la Cátedra fue el profesor Joaquín Llambías, entre 1918 y 1931. Se doctoró en 1894 y también se perfeccionó en Europa. Fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires en tiempos de Yrigoyen y presidente de la Cruz Roja Argentina. La Cátedra tomó el nombre de Anatomía y Fisiología Patológica y el Instituto fue bautizado con el nombre de Telémaco Susini; se persistió en el acopio de imágenes, fotografías y diapositivas, y se incorporó la microscopía a la descripción macroscópica de las autopsias.

El tercer titular de la Cátedra fue el Dr. Pedro I. Elizalde, entre 1932 y 1954. Se había doctorado en 1903, con una sólida formación científica. Se retiró en 1954. Sobrevino una etapa de interinatos hasta la designación del nuevo titular, Julio C. Lascano González. Elizalde integró la Sociedad Argentina de Anatomía Normal y Patológica desde 1938, y desde 1973 existe un premio trienal con su nombre en Anatomía y Fisiología Patológica.

De esa época se recuerdan dos influencias fundamentales: una de la mano de un alemán y la otra de un español. Residía en el país Christofredo Jakob, especialista en neuroanatomía, que desde uno de los laboratorios donde trabajó afianzó los conocimientos y colaboró con

el adiestramiento de nuevos investigadores, y sorprendió con la publicación de la *Folia Neurobiológica Argentina*.

Figura 8.3: Dr. Pío del Río Hortega (España, 1882 – Buenos Aires, 1945).

El otro fue Pío del Río Hortega (España, 1882 – Buenos Aires, 1945). Entrenado por buenos maestros españoles, ingleses y alemanes, fue uno de los grandes de la anatomía patológica, con vocación por los estudios oncológicos. Llegó como refugiado republicano hacia 1940, promovido por la Institución Cultural Española para un curso teórico-práctico de histología e histopatología. Confraternizó con los profesionales del Instituto de la Facultad de Medicina. Colaboró con el nacimiento de la Sociedad Argentina de Anatomía Normal y Patológica y fue uno de sus presidentes. Fundó los *Archivos de la Sociedad Argentina de Histología Normal y Patológica* y en 1943 fue nombrado profesor extraordinario de Embriología e Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata (1943-1944).

En las primeras décadas del siglo XX era habitual que las mañanas se iniciaran con verdaderas procesiones a Anatomía Patológica, donde, a través de las necropsias realizadas, se explicaba la evolución final de algunos pacientes. Esta tarea muchas veces era llevada a cabo por el jefe del Servicio, como Brachetto Brian en la década de 1940. En ese momento la especialidad hacía foco en las autopsias (macroscopía y microscopía), y se desarrollaban en forma sistemática los ateneos anátomo-clínicos con la participación de todos los servicios del Hospital.

Un destacado anatomopatólogo que se formó en nuestro Hospital fue el Dr. Oscar C. Croxatto. Se graduó en la Facultad de Medicina de la UBA en 1937. Concurrió a la Sala XIV de Clínica Médica del Dr. Abelardo Casas en nuestro Hospital, donde consolidó su interés por la especialidad de Anatomía Patológica y donde conoció al Dr. Alfredo Lanari. Asistió, entre 1942 y 1943, al Servicio de Patología del Johns Hopkins Hospital, bajo la dirección del Dr. Arnold Rice Rich. Décadas más tarde, en los años 60, junto al neurocirujano Dr. Eurnekian, trabajó en nuestro Hospital una joven y talentosa médica anatomopatóloga que recién empezaba a hacer neuropatología: la Dra. Ana Lía Taratuto, hoy una experta internacional y jefa en FLENI.

Hacia fines de la década de 1970 se hizo cargo del Servicio el Dr. Adolfo Mosto, especialista en patología quirúrgica con especial atención a las enfermedades mamarias. Previamente fueron jefes del Servicio los Dres. Rómulo Cabrini y Fritz Schajowicz, ambos destacados en patología ósea y de partes blandas. En 1977, cuando se cerró el Hospital Rawson, la Escuela de Técnicos Preparadores en Histología se instaló en el Servicio de Patología, donde persiste hasta la actualidad. El Dr. González Cueto, con gran desempeño en patología clínica, reemplazó al Dr. Mosto durante el período en que este fue jefe del Departamento

de Diagnóstico.

En la década de 1990 se incorporó la inmunohistoquímica, complemento fundamental para el estudio de los tumores. Al mismo tiempo se automatizó el procesamiento de las biopsias y, paulatinamente, el resto de la tecnología necesaria para optimizar los resultados. Con el desarrollo del diagnóstico por imágenes y los nuevos métodos intervencionistas, menos invasivos, fueron desapareciendo las autopsias. En 1994 asumió la conducción el Dr. Héctor Pascuccelli, hasta su jubilación. En 2020 se hizo cargo la Dra. Laura Jufe, especialista en uropatología, hasta la actualidad.

En toda la historia del Servicio se contó con destacados profesionales como médicos de planta; pueden mencionarse, a modo de ejemplo, los Dres. Héctor Gallardo, Hugo Molina y Julián Mosto, entre otros. En la segunda mitad del siglo XX este Servicio fue pionero en el desarrollo de técnicas innovadoras vinculadas a los tumores: las primeras determinaciones de receptores hormonales de cáncer de mama se hicieron en material fresco, en colaboración estrecha con el Servicio de Endocrinología, y también se estudiaba la proliferación celular con la técnica de timidina tritiada. En 2020 se habilitó, en los nuevos quirófanos, un sector especial para estudios intraquirúrgicos, con criostato y microscopio con conectividad para telediagnóstico.

Cabe destacar que este Servicio es receptor histórico de rotantes (residentes y no residentes, argentinos y extranjeros) en varias subespecialidades que distinguen la calidad de su trabajo. Una de ellas, la dermatopatología, se inició con el Dr. José Gabriel Casas, que además era jefe de la Cátedra de Patología. Cabe mencionar que los dermatopatólogos trabajaban dentro del Servicio de Dermatología de nuestro Hospital, vinculados a la Cátedra de Dermatología de la UBA, donde llevaban el registro de los pacientes y tenían además su propio sector de procesamiento técnico. En 1981 los Dres. Casas y Mosto acordaron el traslado de todo el sector de Anatomía Patológica cutánea al Servicio de Patología. La especialidad continuó con los Dres. Schroh y Corbella, y en la actualidad con la Dra. Poppi y el Dr. Chiappe, en permanente vínculo con el Servicio de Dermatología.

Sección de Citología

Figura 8.4: Dra. Catalina Bobrow de Gagneten, fundadora del Laboratorio de Citología (1960).

En enero de 1960 se inauguró en nuestro Hospital el Laboratorio de Citología de la Segunda Cátedra de Ginecología de la Universidad de Buenos Aires. El profesor Dr. Normando Arenas convocó a la Dra. Catalina Bobrow de Gagneten para organizar dicho laboratorio. Fue fundamental la ayuda económica brindada por la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, que también apoyó la labor educativa durante casi diez años. La Dra. Gagneten había regresado a la Argentina tras completar sus estudios de

Medicina en la Case Western Reserve University de los Estados Unidos, donde el Dr. James W. Reagan fue uno de sus profesores de patología. Luego colaboró durante un año y medio con el Dr. John K. Frost, que en esa época organizaba el Laboratorio de Citología de la Johns Hopkins University y, al igual que el Dr. Reagan, fue de los primeros anátomo-patólogos en avizorar la gran utilidad del método de George N. Papanicolaou para tamizaje y diagnóstico.

En 1964 el laboratorio fue el primero, en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en ser reconocido como Sección Citología del Servicio de Anatomía Patológica. Sus objetivos eran dos: por un lado, asistencial, brindando servicios de citopatología general, ginecológica y no ginecológica a todos los departamentos del Hospital y de otros centros de salud; por otro, educativo, organizando desde 1960 los primeros cursos anuales para formación de citotécnicos, cursos trimestrales para patólogos y residentes, y cursos cortos teórico-prácticos para patólogos del interior del país. Desde entonces también se recibió a patólogos concurrentes por períodos más largos.

En nuestro país, este laboratorio fue pionero en utilizar estudios citológicos en el diagnóstico intraoperatorio y en realizar punciones biópsicas con aguja fina de tumores palpables superficiales y profundos. Hacia fines de 1986 ya se había comenzado a trabajar con el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, junto con la Dra. Gloria Díaz y los ecografistas Dres. Carlos Sanguinetti y Guillermo Márquez. En 1994 se hizo cargo del Servicio la Dra. Rosa Laudi, quien continuó con el trabajo asistencial ampliado a todos los servicios clínicos y quirúrgicos, e incorporó la inmunocitoquímica como complemento para el diagnóstico. En 2010 se conmemoró el 50.º aniversario de la creación del Laboratorio de Citología en nuestro Hospital. En 2022 se incorporó la prueba de detección del virus del papiloma humano como tamizaje primario, y el Papanicolaou como triage, en concordancia con el cambio de paradigma para la prevención del cáncer cérvico-uterino. Desde 2023 la jefatura de la Sección está a cargo de la Dra. Analía Filippini.

Agradecimiento: Las Dras. Rosa Laudi y Laura Jufé han colaborado en la redacción del capítulo y nuestro agradecimiento.

Capítulo 9

Anestesiología

En nuestro país, las primeras anestesias certificadas como tales, con las técnicas europeas o norteamericanas, se producen en 1890, cuando los Dres. Juan B. Justo y Andrés Llobet realizaron las primeras anestesias locales con cocaína. Se habían practicado anteriormente, en el Hospital Británico, algunas anestesias etéreas en 1847. El 28 de abril de 1900, José Sabatini, farmacéutico y médico, utilizó la cocaína en anestesia raquídea para humanos en el Hospital Rawson de Buenos Aires, con muy buenos resultados. En 1921 se dictó el primer Curso de Anestesia a cargo del Dr. José Arce y se fundó la Escuela de Especialistas en Anestesia; así, la Facultad de Ciencias Médicas otorgó por primera vez a treinta médicos el diploma de perfeccionamiento en la especialidad. Germán Wernicke, uno de los fundadores de la futura Asociación Argentina de Anestesia, introdujo en la Argentina la anestesia endovenosa en 1934. Dos años después, el 31 de julio de 1936, se conformó la Sociedad de Anestesia en la ciudad de Buenos Aires. El 19 de agosto se solicitó a la Facultad de Medicina de Buenos Aires la inclusión de un cargo de Médico Anestesista en el presupuesto de 1937, y fue aceptado por el decanato de la Facultad. El cargo lo ocupó el Dr. Juan M. Márquez Miranda. En 1939, el Dr. Alberto Gutiérrez, jefe de servicio del Hospital Español de Buenos Aires, creó la *Revista Argentina de Anestesia y Analgesia*, la primera en América Latina dedicada exclusivamente a la anestesiología; en 1950 la publicación pasó a llamarse *Revista Argentina de Anestesia*, dirigida, en sus primeros cinco años, por el Dr. Juan Nesi, y editada ya no por un hospital, sino por la Asociación Argentina de Anestesiología. Con mayor fuerza institucional, la Sociedad de Anestesia se transformó en Asociación Argentina de Anestesiología el 4 de enero de 1945, con una primera Comisión Directiva integrada por los Dres. José Delorme, Pedro Franco, Juan Nesi y Leslie Cooper, extendiéndose su influencia a todo el territorio nacional. Comenzó así una vida científica muy activa en el país, organizando el Primer Congreso Argentino de Anestesiología en 1947, fomentando la creación de las distintas Sociedades de las Provincias y haciéndose cargo de la edición de la *Revista Argentina*.

El Dr. Juan Armando Nesi, maestro de la anestesiología en la Argentina y en Venezuela, había nacido en Buenos Aires el 18 de septiembre de 1909.[17–19] Fue, sin duda, el primer médico anestesiólogo de nuestro Hospital con reconocimiento más allá de nuestras fronteras. Se graduó de médico en la UBA en el año 1932. Aunque sus primeros pasos fueron por la clínica médica, ya en 1936 organizó el primer curso de anestesia que se efectuó en el país, dedicándose después exclusivamente a la práctica de la especialidad. Entre los años 1936 y 1943 fue anestesiólogo en los Hospitales de Ramos Mejía, Nacional Central y de Clínicas. En 1950 fue designado Jefe del Servicio Central de Anestesia del Hospital Guillermo Rawson. Fue Director del Curso en la Escuela Municipal de Anestesia, que en 1954 se convirtió en el Curso Universitario.

Figura 9.1: Dr. Juan Armando Nesi (1909–2001).

En 1936 fue miembro fundador de la Sociedad Argentina de Anestesiología y Presidente de la Asociación Argentina de Anestesiología, cargo que ejerció en dos oportunidades y en la que fue nombrado Socio Honorario en el año 1975. Entre los años 1945 y 1950 fue el Editor de la *Revista Argentina de Anestesiología*. Fue relator oficial en el Primer Congreso Argentino de Anestesiología, en 1947, y Presidente del 3.er Congreso Argentino de Anestesiología. Publicó más de 145 trabajos científicos y viajó en numerosas oportunidades a Estados Unidos, Brasil y Europa a fin de perfeccionarse en la especialidad. En 1940 fue residente en la Mayo Clinic de los Estados Unidos, bajo la jefatura del Dr. John S. Lundy, introductor del pentotal sódico en la práctica anestesiológica. En 1957 se trasladó definitivamente a Caracas (Venezuela), donde prosiguió su brillante carrera docente y donde falleció a los 91 años de edad. Quedará en el recuerdo de sus numerosos discípulos como un maestro. Finaliza este homenaje con las acertadas palabras del Dr. Jaime Wikinski,[18] que fuera Jefe de la División de Anestesiología de nuestro Hospital entre los años 1985 y 2019:

> *"Querido Maestro, muchas gracias por todo lo que ha hecho para la formación de tantas generaciones de anestesiólogos y por la anestesiología como especialidad".*

La Asociación Argentina de Anestesiología, con el paso del tiempo, se sintió insuficiente representante de todo lo que ocurría en la anestesiología de un país muy diversificado y con múltiples centros de estudio. En 1970 se decidió cambiar su estructura y pasó a llamarse Federación Argentina de Anestesiología, a la cual todas las sociedades provinciales se adhieren voluntariamente. Con la jubilación del Dr. Wikinski, le sucedió como Jefa de la División de Anestesiología la Dra. Roxana Lettini, desde 2019 hasta la actualidad.

Capítulo 10

Área Programática de Salud

Uno de los cambios más importantes en las políticas sanitarias de nuestro país fue la adopción de la estrategia de Atención Primaria de la Salud, resultado de las conclusiones de la legendaria reunión de Alma-Ata, en la década de 1970.

En 1984 se reglamentaron las Áreas Programáticas en la Ciudad de Buenos Aires. Así se creó nuestro departamento, el más joven de los departamentos hospitalarios, que por ese entonces era una división que dependía directamente de la Subdirección Médica del hospital.

Figura 10.1: Prof. Dr. Abel Agüero, primer jefe del Área.

En 1986 se designaron interinamente los primeros Jefes de División o Unidad del Área Programática. Luego de un concurso, en 1987 ganó el cargo el primer jefe del área, el Profesor Doctor Abel Agüero, quien lideró y condujo la División con una fuerte impronta comunitaria, comenzando a pensar en una forma diferente de ver y abordar el proceso salud-enfermedad. Con un consultorio cedido detrás de Odontología y otro "prestado" por Consultorios Externos, no contaba con más personal que un médico cirujano, el Dr. Miguel Manzi, una secretaria, la Sra. Elena Sangregorio, y él mismo. A pesar de ese escaso personal, se realizaban actividades de control escolar, vigilancia epidemiológica y participación en actividades del barrio. Poco a poco se fueron ganando espacios y recursos —humanos y físicos—, redefiniendo funciones y misiones, armando propuestas, proyectos y acciones, y estudiando otros modelos de abordaje de la salud.

En 1987 comenzó a armarse, gracias a un programa de becas, el equipo de psicopedagogía con la Lic. Viviana Kelmanowicz, quien sumó a su equipo a la Lic. Cecilia Amitrano y, posteriormente, a Gabriel Rother y María Álvarez Romero, también como concurrentes, hoy de planta. Al no tener un espacio propio, fueron alojadas en Pediatría por el entonces jefe, el Dr. Adolfo Schygiel, conformando junto a las psicólogas el equipo de aprendizaje y

atendiendo así, con una mirada integral, los problemas escolares mediante la detección e intervención precoz. Su línea de trabajo se denominó "Psicopedagogía Estratégica", y sus tratamientos incluyen a las escuelas y a los padres de los niños.

Con el tiempo se fueron sumando más profesionales pediatras, como las doctoras Margarita De Mola y Patricia Asnaghi, quienes se agregaron al equipo de salud escolar, y las licenciadas Leila Mir Candal (antropóloga), actual coordinadora del equipo de Programas Especiales, la psicóloga social Malena Pastor y Marta Fernández, en trabajo social, miembros también del mencionado equipo de Programas Especiales.

En 1990, la División tenía como único Centro de Salud el N.º 11, actualmente en Agüero 940. También allí funcionaba el Centro Carlos Gardel, hoy coordinado por el Lic. Carlos Herbón, pionero en técnicas de tratamiento, dedicado especial y específicamente a personas con problemas vinculados al consumo problemático de sustancias. El Centro Carlos Gardel fue elegido para representar a la Ciudad de Buenos Aires en los proyectos de intercambio de experiencias denominados URBAL, de la Unión Europea para América Latina: reducción de daños, coordinado por el municipio de Santo André, San Pablo, Brasil (2002 y 2003), y guía para la elaboración de planes municipales y escuelas de formación e implementación de proyectos, coordinado por el Consell Comarcal de Figueres, España (2003–2005).[21]

En 1997 se creó el Plan Médico de Cabecera, cuya primera coordinadora fue la doctora Adriana Rubiolo, y que en la actualidad se denomina Cobertura Porteña en Salud y está coordinado por la doctora Olga Riccitelli. En estos centros se encuentran actualmente las especialidades de pediatría, clínica médica y ginecología.

En el año 2006, el doctor Agüero pasó a desempeñarse como Jefe del Departamento de Medicina y asumió como nueva jefa la Doctora Ana María Bou Pérez. A la entonces División Área Programática llegó nuestro segundo Centro de Salud, el N.º 45, ubicado en Cochabamba 2265, adonde se mudaría el Centro Carlos Gardel.

(a) Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) N.º 11, calle Agüero 940.

(b) Acceso al Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) N.º 45, sede Cochabamba.

Años más tarde asumió la jefatura del Área la doctora María Teresa Sagio, en reemplazo de la doctora Bou Pérez, quien ocuparía los cargos de Subdirección Médica de nuestro

hospital y, posteriormente, de Ministra de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, en la jefatura de la División Programas y Centros de Salud quedó la Dra. Ana Milanino, quien a su vez, en el año 2022, quedó como Jefa del Departamento Área Programática de Salud. Desde el año 2025 se desempeña en esa función el Dr. Marcelo Ghioldi.

En el año 2018, mediante el decreto 2081/11 y en cumplimiento del Plan de Salud 2016–2019, se jerarquizaron las áreas de los hospitales generales de agudos con la elevación de las Divisiones Áreas Programáticas a Departamento Área Programática de Salud. Según reza su artículo 1.º, se incorporan al Primer Nivel de Atención los Centros Médicos Barriales y se ratifica la dependencia orgánico-funcional de la División Promoción y Protección de la Salud —la sección Control de Salud— y de la División Programas y Centros de Salud —la sección Salud Escolar, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC)—; se crea también, en este decreto, la División CEMAR (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia).

El equipo de Programas Especiales se abocaría a una tarea fundamentalmente extramural, trabajando en la construcción de actividades comunitarias, realizando Análisis de Situación de Salud y relevando las necesidades de la comunidad, con un fuerte trabajo en los asentamientos que en esa época existían, como por ejemplo bajo la autopista 25 de Mayo. También este equipo fue el encargado de instalar un sistema de referencia y contrarreferencia —sirviendo de nexo entre el hospital y la comunidad— y de trabajar con adultos en situación de calle, comedores y viviendas colectivas. Se sumaron a este equipo dos licenciadas en psicología, Norma Fernández Aiello y Patricia Maglitto, quien posteriormente, tras formarse con una beca en Italia, se abocó al programa de migrantes.

Con respecto al otro programa, el de Salud Escolar —que, como se dijo, inició las actividades del Área Programática—, es hasta el momento el único programa interministerial que, con continuidad y diferentes matices, funciona desde fines del siglo XIX, acompañando la Ley de Educación Común 1420. Recordemos que a fines de ese siglo y principios del XX la población de la ciudad de Buenos Aires creció exponencialmente con la llegada de grandes oleadas de inmigrantes, provenientes en su mayoría de Europa, que traían diferentes culturas, hábitos, costumbres y enfermedades que debían ser atendidas. Nada mejor que encontrar en las escuelas el nexo perfecto entre la salud y las familias, siendo los niños la puerta de entrada. Al equipo de salud mental ya mencionado se le suman la Lic. Alicia Cansler, fonoaudióloga, y la Dra. Ana Kirczyk, odontóloga. Según consta en las memorias del año 1993, el equipo de salud escolar estaba conformado por enfermeras, una fonoaudióloga, dos odontólogos, un deportólogo (compartido con otros grupos), un clínico, tres pediatras, un nutricionista, un trabajador social, tres psicólogas y tres psicopedagogas, más la concurrencia. El primer coordinador de este equipo fue el Dr. Juan Borria, quien posteriormente asumió el cargo de jefe de la División Promoción y Protección, ocupando la coordinación de Salud Escolar la Dra. Mirta García hasta su nombramiento como Jefa de Unidad del CeSAC 11.

Al tener toda la División dispersa en distintos consultorios y pabellones del hospital —Salud Escolar y la jefatura en el consultorio 151, parte del equipo de Deportología y Salud Escolar en el consultorio 148, Programas Especiales en el segundo piso donde actualmente funciona Salud Mental, y otros espacios más—, el Dr. Agüero logró encontrar un edificio capaz de albergar a la totalidad de los integrantes de la División. Es así como el Área Programática se traslada, con algunas dificultades, al ex pabellón de Parasitología. Edilíciamente, es un pabellón que consta de un subsuelo (sede de la residencia del Equipo de Psicopedagogía); una planta baja, donde se encuentran seis consultorios que ocupan el Equipo de Salud Escolar y el Equipo de Gerontología —creado en 2007—; y un primer piso, que cuenta con tres consultorios, el despacho de la jefatura y una amplia aula donde se dictan cursos durante la mañana y donde por la tarde funciona una escuela de adultos (CENS 55).

Actualmente, el departamento cuenta con más de 150 profesionales de la salud, con un Área Programática Central, dos Centros de Salud (11 y 45), dos Centros Médicos Barriales (6 y 29), un Centro de Adicciones (Carlos Gardel), dos residencias, concurrentes y pasantes, y continúa creciendo, a la espera de la próxima anexión de un tercer Centro de Salud. A lo largo de los años, y a través de sus profesionales, el Área Programática realizó Congresos Nacionales, Simposios, Jornadas y publicaciones de varios libros, y fue distinguida con múltiples premios otorgados por Universidades, Sociedades Científicas y hospitalarias. También del área salieron directores y subdirectores de hospital, ministros, adscriptos y asesores. Algunos de sus programas fueron y son: Apostar a la Vida —que, si bien no fue parte del Área, fue huésped de ella, donde desarrolló sus actividades durante muchos años—, De Niño a Niño, el Programa para Adultos Mayores, el Programa de Autoestima, el Equipo de Primera Infancia, Discapacidad y Trastornos del Espectro Autista y Neurodesarrollo.

Agradecimiento: La Dra. Ana Milanino ha redactado este capítulo, con la valiosa colaboración del Prof. Dr. Abel Agüero y de las licenciadas Cecilia Amitrano, Alicia Cansler, Teresa Fernández y Leila Mir Candal, que refrescaron la memoria para describir la historia de nuestra querida Área Programática.

Capítulo 11

Cardiología

Entre los antecedentes de la cardiología argentina, la Sala XII del Hospital Ramos Mejía, bajo la jefatura del profesor titular de la Cátedra de Medicina Interna, el Dr. Rafael A. Bullrich, tuvo un lugar sobresaliente. En el año 1930, el profesor Bullrich, entusiasta de la cardiología francesa, se trasladó desde el Hospital Alvear al Hospital Ramos Mejía para ocupar la jefatura de la Sala XII, acompañado por dos jóvenes médicos, los Dres. Eduardo Braun Menéndez y Blas Moia. En 1931, Bullrich designó a Braun Menéndez encargado de la Sección Cardiología, y a Blas Moia, responsable de la Sección Gastroenterología y director de la revista *Archivos Médicos del Hospital Ramos Mejía*. Cuando el Dr. Braun Menéndez regresó de un viaje a Europa, trajo consigo un electrocardiógrafo Boulitte de dos cuerdas, que donó al hospital y que aún se exhibe en la biblioteca del Pabellón Luis H. Inchauspe, División Cardiología. Por entonces se incorporó al plantel de la Sala XII un joven médico, el Dr. Luis H. Inchauspe, que había dado muestras de gran interés por la cardiología.

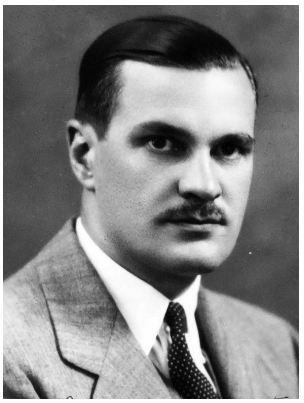


Figura 11.1: Dr. Eduardo Braun Menéndez.

Los estudios médico-sanitarios de aquellos años revelaron la alta incidencia de las enfermedades cardiovasculares como causa de muerte. Esto motivó a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales a impulsar iniciativas para el control y tratamiento de las enfermedades del corazón. Entre las propuestas se destacó, y se consideró la más importante, la del Prof. Rafael A. Bullrich, quien creó, en el año 1934, los Dispensarios de Asistencia al Cardíaco en la Municipalidad de Buenos Aires. A partir de ese momento se crearon dispensarios en los hospitales capitalinos, bajo la jefatura de médicos compenetrados con la cardiología, que fueron nombrados "Delegados". En el año 1939 ya había diez dispensarios, agrupados en un organismo municipal centralizado bajo la denominación de "Dirección de Asistencia Social al Cardíaco", cuyo director fue el Dr. Bullrich, con sede en el Hospital Ramos Mejía como Dispensario N.º 1. Estos

dispensarios no se circunscribieron solo a los límites de la ciudad de Buenos Aires, sino que se crearon otros en las ciudades de Rosario y Mendoza. Durante cierto tiempo, Eduardo Braun Menéndez estuvo a cargo del Dispensario N.º 1, pero, debido a su creciente vinculación con el profesor Bernardo Houssay, decidió abandonar la cardiología clínica y, en el año 1935, se trasladó a la Facultad de Medicina para dedicarse a la investigación, como Director de Investigaciones Cardiovasculares del Instituto de Fisiología dirigido por Houssay; sus investigaciones culminarían con el descubrimiento de la angiotensina. Cuando el Prof. Bullrich fue nombrado Decano de la Facultad de Medicina y Miembro Titular Vitalicio de la Academia Nacional de Medicina, debió dejar el Hospital Ramos Mejía, y designó al Dr. Blas Moia director del Dispensario N.º 1 y jefe de la Sala XII.

Compenetrados de la importancia de la comunicación científica en la educación médica, y convencidos de que la cardiología argentina debía tener su propia revista especializada, los Dres. Blas Moia y Eduardo Braun Menéndez crearon la *Revista Argentina de Cardiología* en el año 1934, el mismo año de la creación de los dispensarios. La experiencia adquirida por Moia como editor de *Archivos Médicos del Hospital Ramos Mejía* contribuyó de manera significativa a la concreción de este proyecto. Como Miembros de Honor de la revista, sus editores eligieron a los profesores Francisco Arrillaga, Rafael A. Bullrich, Mariano Castex, Bernardo Houssay y Tiburcio Padilla. El éxito y la excelencia de la publicación se reflejaron en las calurosas felicitaciones enviadas por las direcciones científicas del *Archives of Internal Medicine* y del *American Heart Journal*. Tres años después, también por iniciativa de Braun Menéndez y Moia —en calidad de secretarios provisorios— junto a dieciséis miembros fundadores, quedó formalmente fundada, en la Asamblea Constituyente de abril de 1937, la Sociedad Argentina de Cardiología.

En 1942, el Dr. Luis H. Inchauspe, miembro del plantel médico del Dispensario N.º 1 a cargo del profesor Blas Moia, murió de manera súbita. Para honrar su memoria, sus padres decidieron construir y donar un pabellón de cuatro plantas destinado a la cardiología, en el predio del hospital. La obra civil estuvo a cargo del ingeniero Inchauspe, hermano de Luis, con el asesoramiento médico de Blas Moia. Así, el 24 de septiembre de 1946 se inauguró oficialmente el Pabellón de Cardiología Luis H. Inchauspe, bajo la dirección y jefatura del profesor Moia. El Pabellón fue el primer servicio de cardiología con internación de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, y el primero en contar con una Residencia de Cardiología de diez médicos, que vivían en el Pabellón y provenían de otros países de Latinoamérica y del interior de la Argentina. La proverbial vocación docente y el reconocido nivel académico de Blas Moia, secundado por destacados colaboradores, hicieron del Pabellón Inchauspe el centro cardiológico más afamado del país por su calidad asistencial y su dedicación a la formación de cardiólogos. De su seno surgió la mayoría de los cardiólogos que ocuparon las jefaturas de los servicios de cardiología de los hospitales capitalinos —creados en el año 1949— y de los centros cardiológicos del interior del país. La docencia se basaba en la transmisión oral y práctica, en la modalidad maestro-discípulo, complementada con clases, ateneos, cursos y publicaciones científicas en revistas de la especialidad,

nacionales y extranjeras.

La incorporación de los Dres. Atdemar J. Álvarez (1949) y Mauricio B. Rosenbaum al Pabellón Inchauspe, en los años 50, significó un salto cualitativo, con fuerte impacto en las actividades de docencia e investigación. En el año 1970, el profesor Moia se acogió a los beneficios de la jubilación y, en su lugar, quedó interinamente a cargo de la jefatura del Pabellón el Dr. José Skivinsky, hasta el año 1972. En 1973, el Dr. Mauricio B. Rosenbaum se trasladó desde el Hospital Salaberry para asumir la dirección del Pabellón, que ejerció hasta el año 1987.

El Pabellón Luis H. Inchauspe

La entrada del Pabellón quedaba al final de un pasillo pavimentado, y el edificio disponía de tres pisos, un altillo y un subsuelo. En la planta baja se encontraban la recepción, los consultorios para la atención de los pacientes ambulatorios y los laboratorios para la realización de estudios radiológicos, electrocardiogramas, fonocardiogramas y balistocardiogramas. También contaba con ambientes destinados a archivos, a la extracción de sangre y a un sector para dispensar tratamientos, pues en esa época los medicamentos eran entregados por el hospital y los inyectables se aplicaban allí mismo. En el primer piso estaban el despacho de la dirección, el aula, la biblioteca, los laboratorios de análisis clínicos, el laboratorio de anatomía patológica y el destinado a investigaciones, además de tres habitaciones donde vivían los residentes becarios. El segundo piso estaba destinado a las salas de internación de hombres y de mujeres y a una sala de reuniones; en su parte superior se encontraba el altillo, que servía de bioterio y depósito. El subsuelo albergaba archivos, el depósito de material anátomo-patológico y las salas de máquinas.

Gracias a la permanente acción de la Fundación de Investigaciones Cardiológicas Einthoven y al aporte municipal, el Pabellón fue totalmente remodelado, acorde con los cambios impuestos por la modernización de la cardiología. En la actualidad cuenta con cuatro plantas totalmente funcionales; en el subsuelo, también remodelado, funcionan el área de Genómica, la informatización de la Unidad Coronaria y el área de control y regulación de ensayos clínicos.

La Escuela Argentina de Electrocardiografía

Figura 11.2: Dr. Mauricio B. Rosenbaum.

Con la creación de la Escuela Argentina de Electrocardiografía por Rosenbaum, junto con la incorporación de los Dres. Marcelo V. Elizari y Julio O. Lázzari, comenzó una nueva etapa de orden científico en el Pabellón Inchauspe, cuyo prestigio trascendió las fronteras del país. El descubrimiento de la trifascicularidad del sistema de conducción cardíaco y la edición, en el año 1968, del libro *Los Hemibloqueos* —con su versión en inglés, *The Hemiblocks*, y su traducción al italiano, *Gli Emiblocchi*— generaron una verdadera revolución en el ámbito de la electrocardiografía mundial, acompañadas de numerosas publicaciones en revistas internacionales de alto impacto.

De inmediato, el interés por la electrofisiología cardíaca dio lugar a importantes investigaciones originales realizadas en el Pabellón Inchauspe, volcadas en revistas cardiológicas y en el libro *Frontiers of Cardiac Electrophysiology* (1982) —traducido luego al español y editado por M. B. Rosenbaum y M. V. Elizari—. La Escuela Argentina de Electrocardiografía logró avances sobresalientes y se perfiló como pionera y autoridad en varios temas de la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de las arritmias. La definición de los hemibloqueos y la conducción trifascicular, la memoria cardíaca, el estudio y tratamiento de las arritmias, el desarrollo del uso de la amiodarona como antiarrítmico, el estudio de la miocardiopatía crónica chagásica y el de la etiopatogenia del síndrome de Brugada fueron algunos de sus aportes originales a la cardiología mundial.

La jubilación de Mauricio B. Rosenbaum, en el año 1987, no afectó la producción científica, la actividad docente ni el interés por la comunicación médica escrita de sus discípulos, ya que quedó como jefe el Dr. Marcelo V. Elizari. Las dos ediciones del libro *Arritmias cardíacas. Bases celulares y moleculares. Diagnóstico y tratamiento* (1988 y 2000, editadas por M. V. Elizari y P. A. Chiale) son un buen ejemplo de ello. Bajo el liderazgo del Dr. Elizari, y con la colaboración del Dr. Pablo A. Chiale, el equipo de cardiólogos de la División brindó a la comunidad cardiológica de habla hispana la oportunidad de incorporar y actualizar sus conocimientos sobre las arritmias cardíacas, desde los conceptos básicos hasta la clínica, en su diagnóstico y tratamiento. Con posterioridad se publicaron otros libros de alto contenido didáctico, editados por médicos del Pabellón Inchauspe: *Marcapasos, resincronizadores y cardiodesfibriladores implantables* (Pablo A. Chiale y co-

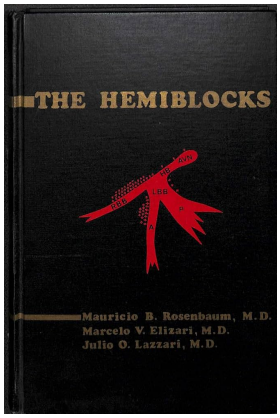


Figura 11.3: *The Hemiblocks*, edición en inglés de la obra de Rosenbaum, Elizari y Lázzari.

laboradores, 2008); *Terapia eléctrica de las arritmias y de la insuficiencia cardíaca avanzada* (Julio D. Pastori, 2022); y el libro electrónico *Cardiología para la práctica diaria* (2022), cuyos editores son los Dres. Justo Carbajales, Alejandro Tomatti, Daniel Bender, Elías Benchuga y Mario Principato.

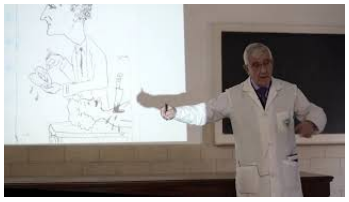


Figura 11.4: El Dr. Marcelo V. Elizari en una clase en el Pabellón Inchauspe.

El jefe actual del Pabellón Inchauspe, División Cardiología, es el Dr. Justo Carbajales. Bajo su jefatura, desde el año 2019 se inauguró en el segundo piso la nueva Unidad Coronaria, junto con la Unidad de Cuidados Intermedios y la modernización de las salas de hombres y mujeres. Además, se estructuró el equipo de Genómica Cardiológica, único en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. En 2024 comenzó la modernización tecnológica de la sección de Hemodinamia, con un angiógrafo de última generación, y la puesta en marcha del plan de Cardiología Personalizada de Precisión, único en Latinoamérica, que renueva el espíritu pionero propio de los miembros del Pabellón Inchauspe.

Jefes del Pabellón Inchauspe

Desde la inauguración del Pabellón, en 1946, los médicos que estuvieron a cargo de su jefatura fueron:

- Prof. Blas Moia (1946–1970)
- Dr. José Skivinsky (1971–1972)
- Prof. Mauricio Bernardo Rosenbaum (1973–1986)
- Prof. Marcelo Víctor Elizari (1987–2012)
- Prof. Rafael Acunzo (2013–2018)
- Prof. Justo Carbajales (2019–presente)

Agradecimiento: Los Dres. Marcelo V. Elizari y Justo Carbajales han colaborado en la redacción del capítulo y para ellos nuestro agradecimiento.

Capítulo 12

Cirugía Cardiovascular

A fines de 1978, la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires decidió cerrar el Hospital General de Agudos "Dr. Guillermo Rawson". El Servicio de Cirugía Cardiovascular, a cargo en ese momento del Dr. Miguel Bellizzi (1926–1991), fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. Como hecho anecdótico, vale recordar que el primer trasplante cardíaco de la Argentina, realizado el 31 de mayo de 1968, tuvo relación con nuestro Hospital: el paciente donante, Emilio Tomassetti, se encontraba internado en la cama 23 de la sala 15 del Ramos Mejía.

En los primeros años, la División de Cirugía Cardiovascular tenía una actividad ferviente: se realizaban entre seis y diez cirugías semanales. Por los cambios políticos de aquel entonces (1988) mermaron las cirugías cardíacas, y en 1991 falleció el Dr. Bellizzi, que trabajó hasta pocos días antes de su partida. Quedaron en el servicio cinco discípulos directos, los doctores J. Álvarez, D. Nussembaum, J. Cociolo, R. González y A. Schena.

En la década de 1980 comenzó la residencia de Cirugía Cardiovascular, lo que le dio al servicio un nuevo empuje, y se incluyó la flebología dentro de las especialidades tratadas, con participación plena en congresos. A partir de 1994 se dio comienzo a la cirugía endovascular, realizando con frecuencia procedimientos con este revolucionario método.

Dos integrantes del equipo se trasladaron a los Estados Unidos para realizar los cursos de perfeccionamiento pertinentes, y el tratamiento del aneurisma de aorta pasó a realizarse de manera rutinaria. Sin dejar de ser pioneros en esta metodología, en junio de 1997 se realizó, en conjunto con el Hospital Militar Central, la primera colocación de una endoprótesis aórtica de balón expandible que se implantaba en el mundo.

Dichas técnicas, mininvasivas y endovasculares, llevan ya treinta años instaladas en el servicio, y permiten resolver patologías cada vez más complejas, logrando crear estándares de comportamiento y mecanismos de autorregulación y mejora continua que deben ejecutarse para garantizar un impacto positivo en la sociedad.

Tomar conciencia de que esta responsabilidad social es nuestra —porque somos actores

y funcionarios del hospital— nos convierte en la herramienta fundamental para el fortalecimiento progresivo y continuado de los servicios institucionales. Los últimos Jefes de División fueron el Dr. Norberto González y, en la actualidad, el Dr. Jorge Cociolo.

Agradecimiento: Al Dr. Jorge Cociolo por la redacción de este capítulo.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 13

Cirugía General

La historia del Servicio de Cirugía General del Hospital Ramos Mejía está indisolublemente unida a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialmente a la II Cátedra de Cirugía. Si bien, como veremos más adelante, y al amparo de la ley Padilla, el Hospital fue sede durante distintos períodos históricos de la III y la V Cátedras, con insignes cirujanos como titulares, la columna vertebral fue siempre la Segunda Cátedra de Cirugía. Nacieron juntos y nunca se separaron.

Cuando en 1883 se inauguró el Hospital San Roque, por Ley de la Nación el Hospital Buenos Aires pasó definitivamente a la Facultad de Medicina, con la denominación de Hospital de Clínicas. En la misma época, la Universidad de Buenos Aires gestionó convenios con la Comuna para la instalación de cátedras, primero en el Hospital San Roque y luego en otros hospitales municipales. Por estos convenios, la Municipalidad nombraba Jefe de Servicio al profesor titular de la Cátedra, quien adquiría todas las obligaciones de un jefe municipal, además de cumplir sus funciones docentes. El San Roque se convirtió en el primer Hospital Asociado a la Facultad de Medicina —término hoy de uso corriente—. Esta asociación resultó de extraordinario beneficio para alcanzar el alto nivel de atención médica y de formación profesional que dio prestigio mundial a la medicina argentina en las primeras décadas del siglo XX.

En 1887, a propuesta de la Universidad, el presidente Juárez Celman creó la II Cátedra de Cirugía y nombró como primer profesor titular al Dr. Luis Güemes, nieto del prócer salteño. Nunca fue realmente cirujano, por lo que declinó el cargo casi de inmediato para dedicarse con gran brillo a la Clínica Médica. A propuesta de la Facultad, el Poder Ejecutivo designó entonces titular a Julián Aguilar, cirujano emprendedor y progresista, autor de una técnica original para la cura de la hernia inguinal, que fue director de nuestro Hospital y cuya estatua se encuentra en el patio central. Falleció a los 48 años, en 1903.

En 1904, la Facultad elevó una terna integrada por los Dres. Juan B. Justo, Enrique Corbellini y Daniel Cranwell, y el presidente de la Nación designó a Juan B. Justo profesor titular de la II Cátedra de Cirugía.

Justo introdujo y difundió en el país la práctica de la cirugía aséptica; por ordenanza municipal, el pabellón quirúrgico del Hospital lleva su nombre. Junto con él se alejaron del Hospital Enrique Corbellini —cirujano excepcional, que realizó las primeras tiroidectomías en el hipertiroidismo— y Nicolás Repetto. Un nuevo decreto del presidente de la Nación, en 1906, designó titular al Dr. Pascual Palma, de una terna que integraban también Daniel Cranwell y Avelino Gutiérrez. Discípulo de Pirovano, Palma era un hábil cirujano y un docente práctico y concreto, a quien disgustaban las exposiciones magistrales tan en boga en su época.

Figura 13.1: Dr. Daniel J. Cranwell.

Figura 13.2: Dres. Juan B. Justo y Nicolás Repetto. *Fuente: Archivo General de la Nación.*

Figura 13.3: Prof. Pedro Chutro (1880–1937).

Por entonces funcionaba también en el Hospital San Roque la III Cátedra de Cirugía, a cargo primero del profesor Diógenes Decoud, luego de Pedro Chutro y más tarde de Alejandro Ceballos. Pedro Chutro (1880–1937), notable cirujano general argentino y discípulo de Alejandro Posadas, tuvo una resonante actuación durante la Primera Guerra Mundial en París, reemplazando a su admirado maestro A. Gosset: allí trabajó en jornadas agotadoras después de las batallas, dirigiendo las trescientas camas de cirugía del Hospital Buffon. El gobierno francés le otorgó el grado de Oficial de la Legión de Honor, y también recibió la Medalla por Servicios Distinguidos de los Estados Unidos. De vuelta en Buenos Aires en 1919, dictó clases de Clínica Quirúrgica como titular de la III Cátedra en los modestos locales que le brindaban los hospitales municipales Durand y Ramos

Mejía. La Cátedra fue trasladada en 1958, por su entonces titular Aníbal Introzzi, al Hospital de San Martín, luego "Mariano Castex" y hoy "Eva Perón".

Palma renunció en 1921. La Facultad propuso a Armando Marotta, de una terna integrada además por Roberto Solé y José Jorge. Debido a las obras de refacción del Hospital San Roque, Marotta llevó provisoriamente la II Cátedra al Hospital Italiano, cuya jefatura de servicio ejercía desde 1920. Concluidas las obras, y reinaugurado el Hospital con el nombre de Ramos Mejía, Marotta asumió en él la jefatura de la Cátedra, en la sala 7 del primer piso del pabellón de cirugía. Marotta jerarquizó el servicio: fue un gran semiólogo y un operador mesurado y eficaz, con destacada actividad académica. Presidió en 1928 el Primer Congreso Argentino de Cirugía y, tres años más tarde, fue miembro titular de la Academia Nacional de Medicina. Se retiró en 1941, al llegar al límite de edad.

Figura 13.4: Sala de operaciones del Hospital San Roque. *Fuente: Colección César Gotta.*

En 1911 había sido designado jefe de la Sala II de Cirugía del Hospital San Roque el ya citado Dr. Daniel Cranwell, miembro de la Academia Nacional de Medicina y presidente de la Asociación Médica Argentina entre 1906 y 1907. En 1909 fue nombrado profesor titular de la Cátedra de Patología Externa y, en 1911, junto a otros diecinueve cirujanos, fundó la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires.

En 1929, el Prof. Dr. Robertson Lavalle fue nombrado director del Hospital, a la vez que ejercía la jefatura de la Sala VI de Patología Quirúrgica. Había sido presidente de la Asociación Médica Argentina entre 1917 y 1919. Por entonces, la Sala IX estaba a cargo del Prof. Marcelo Vías; el Prof. Armando Marotta era titular de Clínica Quirúrgica y jefe de la Sala VII; y el Prof. Delfor del Valle (h) era jefe de la Sala XI de Clínica Quirúrgica e Instituto de Gastroenterología.

Para suceder a Marotta, el presidente de la Nación eligió a Delfor del Valle (h), de una terna propuesta por la Facultad que integraban también Avelino Gutiérrez y Oscar Ivanissevich. Del Valle poseía una gran cultura médica y general, espíritu investigador, fino sentido clínico, técnica quirúrgica depurada y equilibrio emocional frente a las situaciones más dramáticas. Fue uno de los impulsores de la neurocirugía en nuestro país y figura descollante en la cirugía biliopancreática: el descubrimiento de la colédoco-oditis escleroretráctil le dio renombre universal. Gran organizador de su servicio, en la docencia abolió las clases magistrales e inició la denominada enseñanza "socrática", con activa participación de los alumnos.

Jubilado Del Valle en 1953, se designó a cargo de la Cátedra al Dr. Abel Canónico, cargo que ocupó por escasos meses, en años de intensos conflictos políticos. Luego del golpe de Estado, en noviembre de 1955 la Facultad de Medicina nombró interinamente al Dr. Alejandro Pavlovsky a cargo de la II Cátedra y, por ende, de la jefatura del Servicio de Cirugía; en 1957 ganó el concurso correspondiente y fue ratificado en el cargo. En los seis años que estuvo al frente de la Cátedra transmitió su gran experiencia, su sentido clínico, su criterio y su capacidad quirúrgica. Fue autor de seis libros y centenares de publicaciones científicas; presidió la Academia Argentina de Cirugía y la Asociación Argentina de Cirugía —que lo designó cirujano maestro—, fue miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y la Municipalidad de Buenos Aires lo distinguió como Maestro Extraordinario y Jefe Honorario de Cirugía del Hospital Ramos Mejía.

Al retirarse Pavlovsky, y tras el correspondiente concurso, el Consejo Superior Universitario designó en 1963 al Dr. Jorge Sánchez Zinny profesor titular de la II Cátedra de Cirugía. De gran personalidad, notable clínico quirúrgico y cirujano de enorme capacidad, Sánchez Zinny fue un digno heredero de sus predecesores y consolidó a la II Cátedra como uno de los lugares de referencia y foco de irradiación de la mejor cirugía argentina. Dejó también el recuerdo de su atrayente personalidad como caballero, hombre de bien y cultor de la más rigurosa ética médica. Fue miembro fundador de la Sociedad Argentina de Cirujanos, miembro de la Academia Nacional de Medicina y gobernador para la Argentina del American College of Surgeons hasta su deceso. También en 1963, el servicio de la Cátedra fue uno de los elegidos por la Municipalidad para iniciar la experiencia con médicos residentes: fue la primera residencia quirúrgica de los hospitales públicos de la Capital Federal, bajo la conducción del Dr. Sánchez Zinny. Por ese entonces ya habían caído de hecho los acuerdos entre la Municipalidad y la Universidad de Buenos Aires. Sánchez Zinny fue, hasta el presente, el último jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Ramos Mejía con el cargo de profesor titular.

Figura 13.5: Quirófano del Hospital Ramos Mejía. *Fuente: Archivo General de la Nación.*

El gobierno dictatorial de turno anuló, en 1977, todos los convenios preexistentes. En marzo de 1979, la Facultad designó en forma interina al jefe de servicio de la División "A", profesor adjunto Dr. Roberto Garriz, a cargo de la II Cátedra. Proveniente de la escuela quirúrgica del Hospital Rawson y discípulo de Ricardo Finochietto, Garriz fue un cirujano de cualidades excepcionales y un ser humano de extraordinaria bonhomía, reconocida no solo por sus discípulos dilectos, sino por todos aquellos que tuvieron el placer de conocerlo. Llegó con su equipo al Ramos Mejía no para sustituir una escuela quirúrgica, sino para enriquecerla —como el Dr. Elbio Bilesio, entre otros notables cirujanos—; su jefe de residentes fue el Dr. N. Lami. La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires creó entonces el Departamento de Cirugía —estructura que engloba todas las especialidades quirúrgicas del Hospital— y le asignó al Ramos Mejía dos Divisiones de Cirugía General. La II Cátedra conservó su ubicación en las ex salas 6 y 7, con la denominación de División "A". Así fue produciéndose, en las generaciones posteriores de cirujanos, la amalgama entre la escuela finochiettista y la de Sánchez Zinny.

En 1984, la Facultad de Medicina de la UBA eliminó las cátedras tal como se las conocía hasta entonces y departamentalizó la enseñanza de las especialidades, aunque la denominación de II Cátedra siguió vigente en la memoria colectiva. Fueron distinguidos jefes del Servicio de la División "A" de Cirugía y responsables de la materia en el Hospital Ramos Mejía los Dres. Alejandro Pavlovsky, Delfor del Valle, Jorge Sánchez Zinny y Roberto Garriz, y los profesores adjuntos Héctor Santángelo y Luis Gutiérrez. También se desempeñó como responsable de la materia el profesor titular Dr. Juan C. Milanese, cargo que ejerció no en las Divisiones de Cirugía General, sino en el Departamento de Urgencias del hospital, del que era jefe. En la actualidad, el jefe de la División "A" (antigua sala 7) es el Dr.

Roberto Amicucci.

A la otra División, la "B" (antigua sala 9, que Sánchez Zinny había hecho famosa, de tradición francesa), se le asignó el tercer piso del bloque quirúrgico del hospital. Por su jefatura brillaron Horacio Achával Ayerza, Alejandro Villegas, Héctor Santángelo, Luis Vicente Gutiérrez Maxwell, Alberto Caniparoli, Miguel Astudillo —dilecto discípulo de Villegas en cirugía torácica— y Roberto Lami —también cirujano torácico, que fue jefe de la División "A"—. El actual jefe del Servicio y titular de la II Cátedra de Cirugía es el Dr. Norberto Lucilli.

Figura 13.6: Pabellón de Cirugía de Hombres, antes de la reforma edilicia.

El Hospital Ramos Mejía ha dado insignes figuras a la historia de la cirugía argentina, historia en la que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires jugó un papel decisivo. Los jefes de División, junto con todos los docentes que hoy tratamos de hacer honor a la herencia recibida, consideramos que un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires no tiene destino sin docencia de pre y posgrado, y que esa actividad debe ser tutelada por la Facultad de Medicina de la UBA: uno de nuestros objetivos permanentes es que esa unión sea indestructible. A nuestro Hospital se lo reconoce, además, como piedra angular de la cirugía en la Argentina, asiento de la Segunda Cátedra de Cirugía de la Facultad de Medicina. Por sus salas han pasado generaciones de los mejores cirujanos del país, como los Profs. Pedro Chutro, Julián Aguilar, Jorge Sánchez Zinny y Horacio Achával Ayerza.

Como ya se ha relatado en otras especialidades, con el cierre del Hospital Rawson por la última dictadura militar los discípulos de los hermanos Finochietto emigraron en parte al Hospital Argerich y en parte a nuestro Hospital. A mediados de 1978, la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires decidió cerrar definitivamente el Hospital "Dr. Guillermo Rawson"; una historia de más de cien años quedaba atrás. Tras el cierre, la Escuela Quirúrgica Municipal de Graduados trasladó su sede al Hospital Argerich, bajo la dirección del Dr. Delfín Vilanova. El 26 de abril de 1984, tras el retiro de este, la Escuela cambió nuevamente de establecimiento: por agregados a la primitiva Ordenanza N.º 18614 (Boletín Municipal 11.761) y con la firma de los Dres. Saguier y Puga, se resolvió su traslado a la División "A" de Cirugía, sala 7 del Hospital José María Ramos Mejía, bajo la dirección del Prof. Dr. Roberto A. Garriz, por entonces jefe de la División Cirugía. El mismo decreto dispuso, además, levantar la cesantía *post mortem* que pesaba sobre el Dr. Ricardo Finochietto desde 1956. Actualmente, y con las restricciones originadas por el paso del tiempo y los cambios frecuentes en las políticas de salud, la Escuela continúa funcionando en la sala 7 del Hospital Ramos Mejía.

Otra personalidad destacada fue el Prof. Dr. Juan Carlos Milanese, que ingresó en marzo

de 1959 como médico asistente y se desempeñó en el Servicio de Cirugía y en el Departamento de Urgencias, del cual fue cirujano de guardia, jefe de unidad y, en 1979, jefe de departamento. En la docencia universitaria fue profesor regular adjunto de la Segunda Cátedra de la UBA y profesor titular en 1987; en 1998 fue designado profesor consulto titular de la UBA. Sus aportes en investigación se dieron en la relación de la calcemia con el débito gástrico y en la fisiopatología de las lesiones ulcerosas y la secreción gástrica. Bajo la guía del Prof. Sánchez Zinny, aportó trabajos originales sobre la anastomosis ascendo-recto latero-terminal como tratamiento del megacolon del adulto, la recto-promonto-pexia perineo-abdominal y la reconstrucción perineal en las malformaciones congénitas. Falleció el 6 de mayo de 2008.

Los profesores titulares de Cirugía de la Segunda Cátedra fueron, en orden sucesivo: Sánchez Zinny, Garriz, Milanese, Lami y Lucilli. La Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados, cuyo primer director fue el Dr. Ricardo Finochietto desde 1949, llegó a nuestro querido Hospital José María Ramos Mejía a partir de 1984, con la dirección del Prof. Dr. Roberto A. Garriz.

Ya en tiempos recientes, en febrero de 2021 se llevó a cabo la remodelación de los quirófanos centrales del Hospital.

Figura 13.7: Pabellón quirúrgico luego de la reforma, que lleva el nombre de Juan B. Justo (comparar con la figura 13.6, que muestra el edificio anterior).

Agradecimiento: Los Dres. Roberto Lami, Roberto Amicucci y Norberto Lucilli han colaborado en la redacción del capítulo.

Capítulo 14

Cirugía Plástica

En los años 40 solo había en el país un reducido número de cirujanos plásticos. Algunas publicaciones en revistas médicas o en el boletín de la Sociedad Argentina de Cirujanos registraban su actividad. En 1941 se realizó en Río de Janeiro el primer Congreso Latinoamericano, con escasa concurrencia; los asistentes argentinos más conocidos fueron Ernesto Malbec, de Buenos Aires, y Lelio Zeno, de Rosario.

A comienzos de esa década sobresalió el Dr. Ernesto Malbec. De fuerte personalidad, forjada en un pasado de dura lucha —primero como delegado estudiantil y luego como político de acción en Avellaneda—, volcó finalmente su dinamismo y capacidad de trabajo en la cirugía plástica. Realizó su principal labor en el Hospital Ramos Mejía. Publicó numerosos trabajos y fue asiduo concurrente a reuniones dentro y fuera del país; activo propulsor de la especialidad, realizó muchos viajes a los países más diversos, difundiendo los logros de nuestra entonces novel disciplina.

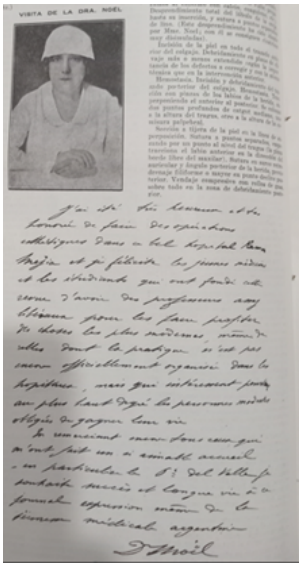


Figura 14.1: Dra. Noel, invitada a operar en el Servicio de Cirugía Plástica (1929).

También fue practicante de cirugía en nuestro Hospital Fortunato Benaim. Hizo aquí sus primeras prácticas y, tras conocer al profesor Arnaldo Yodice durante un Curso de Patología Quirúrgica, no volvió a despegarse del maestro, siguiéndolo al Hospital Argerich. En 1946 se recibió de médico y, a raíz de un hecho fortuito —un incendio en un conventillo de la Boca—, Yodice le indicó que se ocupara de los quemados; allí comenzarían los aportes brillantes que Benaim haría a la medicina.

A comienzos de los años 40 podían señalarse otros cirujanos plásticos. Entre ellos, Roberto Dellepiane Rawson, con quien colaboraba Simón Kirschbaum en una reducida dependencia del Hospital Rawson; este último fue luego el

fundador del Instituto de Quemados. Por esos años visitó el Hospital el afamado Dr. Sir Harold Gillies, que operó en él. Malbec formó excelentes discípulos, entre los que se destacaron Norberto Spera y Jorge Quaife. Este último fue jefe de la Sección Quemados, que estaba dentro de la Unidad de Cirugía Plástica, cuyo jefe era el Dr. Vieyra Urquiza.

También nuestra Cirugía Plástica se vio enriquecida por el Hospital Rawson. La Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados se ordenaba en Departamentos de las distintas especialidades —idea verdaderamente precursora—: Intestinal y Proctológica; Gastroesofágica; Cara y Cuello; Maxilofacial; Paredes Abdominales; Tórax y Cardiovascular; Traumatología y Cirugía de la Mano; Hígado y Vías Biliares; y Mama. Las rotaciones eran cuatrimestrales, y los cursistas pasaban por los distintos Departamentos, donde se familiarizaban con la concentración de las diferentes patologías. A esto se sumaban la traducción de trabajos y revistas, la realización de prácticas cadavéricas, el entrenamiento en el manejo del instrumental —con suturas y nudos quirúrgicos—, la cirugía en animales de experimentación y cursos nocturnos de las diferentes subespecialidades, dirigidos por los jefes de cada Departamento. Los dos mejores promedios al finalizar el curso quedaban incorporados como médicos del Servicio.

Con el cierre del Hospital Rawson, el Servicio de Cirugía Maxilofacial y Plástica llegó a nuestro Hospital como Sección en 1978. Su jefe, el Dr. José Alberto Cerisola, gestionó ante las autoridades municipales la creación de la División de Cirugía Plástica y Reparadora, con tres unidades, dando de baja la Sección Quemados y uniendo los dos servicios. También se creó un Curso Superior de Cirugía Plástica, que otorga el título de especialista, y la primera residencia de la especialidad. Este formato sigue en la actualidad, habiendo sido reemplazado dicho curso por el de la UBA, cuya directora es la Dra. Nora Petralli y cuyo subdirector es el Dr. Saladino, desde su creación en 2010.

Cuando el Dr. Cerisola se jubiló, asumió como jefe de División el Dr. Manuel Viñal, hasta 2009; lo sucedió la Dra. Nora Petralli, jefa de División hasta la actualidad. Cada año se forman con excelencia entre cinco y seis profesionales con título universitario de la UBA.

Como dice José Alberto Cerisola, gran cirujano maxilofacial y luego jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Ramos Mejía:

> *"...había en todos un espíritu docente heredado, una pasión obsesiva por enseñar a operar, reglando las cirugías hasta en los pequeños detalles, lo que iba desde la posición del paciente, la colocación de los campos y la ubicación del cirujano y los ayudantes, hasta cómo la instrumentadora debía ordenar su instrumental".*

Capítulo 15

Clínica Médica

En 1892 se creó el Servicio de Clínica Médica. Junto con Cirugía, fue uno de los servicios con mayor cantidad de camas a su cargo, y como en todo hospital de estilo francés organizado en pabellones, se fueron incorporando a lo largo del tiempo distintas Salas identificadas con números romanos, cada una a cargo de distinguidos profesores. Tomando la definición que diera el Dr. Eduardo Benzecry del practicante —figura tan frecuente e imprescindible en el trabajo hospitalario de los primeros años del Hospital—, el practicante no era ni un alumno ni un residente, sino que ejercía ambas funciones a la vez: sobre todo era un discípulo del Jefe, a quien elegía por afinidad humana y científica, y llegaba a la Sala luego de un período de rotación por vacunación y laboratorio, existiendo aún un escalón más, el de practicante de guardia.

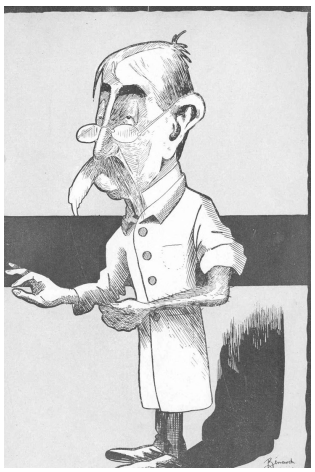


Figura 15.1: Caricatura del Dr. Francisco A. Sicardi.

En 1905, Francisco Sicardi era jefe de la Sala IX —que luego pasaría a llamarse Sala XVI, a cargo de Abelardo Casas—; por entonces eran cuatro los profesores titulares de la Cátedra de Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la UBA: Güemes, Ayerza, Chávez y Sicardi. Sicardi protagonizó un duelo académico por un concurso de Profesor Adjunto junto a Julio Méndez, que perdió; en su Sala se formaron eminencias de la medicina como Benito S. Bosch, Juan A. Siffredi, Félix Celesia, Carlos Preioni, Alfredo Larguía, Ismael Hernández, David Speroni y José Merlo Gómez. Sicardi, además de médico, fue escritor; una arteriosclerosis precoz y una fractura de fémur lo postraron tempranamente a una silla de ruedas, desde la cual dio su última clase en 1914, rodeado de sus discípulos, y falleció en 1927. La Sala XVI —sala exclusivamente de hombres, donde hoy se encuentra la Sala de Dermatología— quedó a cargo del Prof. Abelardo Casas, siguiendo los pasos de su maestro; hacia 1940 trabajaban allí médicos como Moisés Benarós, que luego fue cardiólogo, y Adalberto Goñi, que llegó a ser Jefe de Clínica Médica del Hospital Arg-

erich. Otro discípulo destacado fue el Dr. Oscar C. Croxatto, graduado en la UBA en 1937, reconocido por su "ojo clínico" en Semiología. Abelardo Casas fue un maestro nato, sin cargos académicos pero con escuela propia.

Figura 15.2: Dr. Eduardo Benzecry.

En 1929, la Sala I de Clínica Médica estaba a cargo del Dr. Julio Méndez, con formación alemana centrada en la técnica, en contraste con la tradición clínica francesa que sostenían Abelardo Casas y Rafael Bullrich, antiguos compañeros de Facultad; en esa época los jefes, con cargos vitalicios, eran reacios al intercambio académico entre servicios. En la Sala I —donde antiguamente funcionó la Unidad Docente Hospitalaria de la Universidad del Salvador— fue Jefe de División el Prof. Lucio Sanguinetti, cuyo *Semiología y Semiotecnia*, continuado por su hijo Carlos María Sanguinetti, se sigue utilizando en la actualidad; era reconocido por su trato humilde y afectuoso con colegas, estudiantes y enfermos. Esa Sala pasó luego a llamarse División C: jubilado Lucio Sanguinetti, ganó el concurso la Dra. Delia Rossi, a quien sucedieron el Dr. Huberman y luego el Dr. Arceno, cuando Huberman ganó el concurso de Jefe de Departamento de Medicina Interna. Fueron médicos Jefes de Unidad de la División C los Dres. Parcero, Groba, Benzekry y Slater; el Dr. Eduardo Benzecry, ya Jefe de División, siguió concurriendo jubilado a los Ateneos semanales, dejando un legado de enseñanzas recordado por sus discípulos. El Dr. Marcelo Torino perteneció como Jefe de Unidad de la División C a fines del siglo XX y principios del XXI, fue Coordinador de la Unidad Docente Hospitalaria de la UBA y Decano de la Facultad de Medicina entre 2010 y 2014, además de Profesor Titular de Medicina Interna; actualmente el Dr. Santiago Ilutovich es Jefe de la División C. Fue Jefe de Departamento de Medicina Interna el Dr. Codevila; el Dr. Huberman, además Titular de la Cátedra de Medicina Interna de la UBA, fue sucedido en esa jefatura por el cardiólogo Víctor Sued y, tras su jubilación, por el Prof. Dr. Enrique Parafioritti. Entre los colegas que trabajaron en el Departamento se cuenta el ex ministro de Salud del GCBA, Dr. Alberto Demicheli.

En la Sala XVI, al fallecer Abelardo Casas en 1943, asumió el Prof. Dr. Waldorp —con el tiempo rector de la UBA, de tradición germana—, lo que dio inicio a una disputa con Rafael Bullrich en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando el primero militaba en el Comité Argentino-Germano y el segundo en el Comité Franco-Americano. La Sala XV de Clínica Médica, a cargo del Dr. Bosco, profesor de Semiología, funcionó en lo que hoy es el primer piso de la Sala de Neurología, en el mismo pabellón de Casas; allí trabajaron Ramos Mejía, José Ingenieros, Blas Moia y Domingo Passanante.

Figura 15.3: Sala de hombres del Hospital, 1910.

Figura 15.4: Prof. Dr. Rafael A. Bullrich, 1929.

En la Sala XII —hoy División A de Clínica Médica— el jefe en 1929 era Bonorino Udaondo, también a cargo del Instituto de Gastroenterología, a quien sucedió Rafael Bullrich, antiguo decano de la Facultad de Medicina y de tradición francesa, quien creó en su servicio un laboratorio propio para no depender del Laboratorio Central. Braun Menéndez estuvo a cargo de la Sección Cardiología y Blas Moia de la sección Gastroenterología. Bullrich fue separado de su cargo por el gobierno peronista, junto a Mariano Castex y Bernardo Houssay, en 1943; lo sucedió Carlos Preioni en 1945, y a éste Luis U. Rabuffetti, con afinidad por la Neumonología, y luego Juan Agustín Etchepareborda, discípulo de Bullrich y de Pedro Escudero. Le siguió el Prof. Eduardo Benzecry, también de tradición francesa, y en esa misma Sala continuaron como Jefes de División Lucio Sanguinetti y su hijo, seguidos por los Dres. Mauricio Manguel y Gioseffi en la década de 1980, con los Dres. Grobba y Parcero como Jefes de Unidad. El Dr. Schapira impulsó las Residencias antes de pasar al Hospital Fernández. También se destacaron en la Sala los Dres. Agüero, Slater, Groba, Pequenera, Mémoli, Szwarc y Santiago Parcero —interesado en patología hepática, pionero de la colangiografía por punción antes de la ecografía—, junto a los médicos de planta Fratessi y León Schwartz. Jubilado Parcero, asumió el Dr. Torino como Jefe de Unidad; en 2002 se jubiló como Jefe de División el Dr. Carlos Sanguinetti, sucedido por Guillermo Márquez (2004-2016) y luego por el Dr. Rodolfo Fernández, Jefe de la División A hasta la actualidad.

En la Sala III de Clínica Médica, en los años 1930, estaba a cargo el Prof. Juan S. Vitón; por ella pasó también Ricardo Nölting, luego Director del Hospital a principios del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX funcionó allí la Unidad Docente Hospitalaria de la UBA,

con profesores como Horacio Podestá, San Román, Víctor Miatello y Delia Rossi. La Dra. Honorina Conti fue Jefa de la División B —como pasó a llamarse esta Sala— y creó el grupo de estudio de Porfirias; jubilada ella, ganó el concurso de Jefe de Unidad el Dr. Grobba, y como Jefe de División fue reemplazada por el Dr. Pedro Valicenti. Actualmente el Jefe de División B es el Dr. Alberto Guida.

Figura 15.5: Placa en homenaje al Dr. Ricardo A. Nölting.

Cabe destacar que las cátedras de Clínica Médica de la Facultad de Medicina no estuvieron confinadas al Hospital de Clínicas: tanto la Segunda como la Cuarta mantuvieron una relación directa con nuestro Hospital. Ya en la década de 1890 la enseñanza clínica se vinculó al San Roque a través del Prof. Julio Méndez, docente libre con sala propia en el Hospital. La Cuarta Cátedra funcionó en la Sala IX del entonces Hospital San Roque, dirigida por el Prof. Francisco A. Sicardi, y fue allí donde en 1904 se incorporó como Jefe de Trabajos Prácticos un joven Rafael Bullrich. Años después, ya titular de la Segunda Cátedra de Clínica Médica —creada en 1887 y antes ocupada por Juan B. Gil, Gregorio N. Chaves e Ignacio Allende—, Bullrich la trasladó a nuestro Hospital el 8 de mayo de 1931, al ser designado Jefe de Sala Médica e instalarla en la Sala XII junto a casi todo su equipo docente, multiplicando desde allí la actividad asistencial, docente y de investigación.[46]

Centro de Ecografía Clínica e Intervencionista

Figura 15.6: El Dr. Lucio Sanguinetti escribiendo su libro.

En 1979 el Dr. Carlos María Sanguinetti adquirió un ecógrafo y financió un viaje de capacitación a Cleveland, Ohio. El Dr. Guillermo Márquez, tras especializarse en Gastroenterología bajo la jefatura del Dr. Baccaro y el Dr. Aldo De Paula, viajó con el apoyo de Sanguinetti a San Francisco para formarse en prácticas intervencionistas guiadas por imágenes, en especial punciones con aguja fina guiadas por ecografía. Con un ecógrafo sencillo y la colaboración de la Dra. Catalina Bobrow de Gagneten en Citología, comenzaron las primeras punciones guiadas en hígado, páncreas, riñones, bazo y lesiones de pulmón y mediastino, además de la colocación de catéteres en abscesos y nefrostomías percutáneas. Junto al Dr. Carlos Sanguinetti y al Dr. Alberto Guida se creó el Consultorio de Ecografía Clínica e Intervencionista en la planta baja del Hospital, con apoyo de las Voluntarias de Schoenstad; los Dres. Márquez y Sanguinetti obtuvieron el Premio Hospital Ramos Mejía en 1989 con una experiencia de 1500 procedimientos tabulados, que más adelante llegó a los 3000 casos.

Agradecimiento: Al Dr. Guillermo Márquez por haber redactado sus recuerdos de los Dres. Lucio y Carlos María Sanguinetti, nuestro reconocimiento.

Centro Municipal de Porfiria

Las porfirias son enfermedades graves, hereditarias o adquiridas, potencialmente mortales si no se diagnostican y tratan a tiempo, lo que vuelve imprescindible su diagnóstico precoz en centros multidisciplinarios especializados. En nuestro Hospital se comenzó a asistir a pacientes porfíricos en la década de 1970; a partir de 1976 el Prof. Dr. Pedro Magnin atendió en la Sala de Dermatología a pacientes con porfiria cutánea, y en 1978 la Dra. Honorina Conti comenzó a asistir a pacientes con porfiria aguda en la División B de Clínica Médica, en asociación con el Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias (CIPYP). Durante 16 años se desarrolló un trabajo descentralizado de asistencia e investigación que produjo numerosos trabajos premiados; jubilada la Dra. Conti, la coordinación quedó a cargo de la Dra. Lucía Tomatti y, tras su jubilación, de la Dra. Valeria Pachioli. En 1994 se consolidó el Grupo Multidisciplinario de Atención al Paciente con Porfiria, con la participación de varios servicios del Hospital y el CIPYP, dependiente del CONICET. En la actualidad la atención se presta en la Sala de Clínica Médica B y en Consultorios Externos de Clínica y Alimentación, con la colaboración del resto de los servicios del Hospital y en conjunto con el CIPYP, que realiza las determinaciones bioquímicas en el Hospital de Clínicas; la Farmacia del Hospital mantiene una reserva de hemina para crisis severas y un kit de diagnóstico rápido (Test de PBG).

Agradecimiento: a los numerosos profesionales, residentes y jefes de servicio de Clínica Médica B, Alimentación, Dermatología, Hepatología, Ginecología, Obstetricia, Neurología, Salud Mental, Kinesiología, Consultorios Externos, Farmacia, Cirugía y Anestesia que colaboraron a lo largo de los años con estos pacientes portadores de una enfermedad huérfana.

Sección Enfermedades Emergentes

La Sección Enfermedades Emergentes fue creada formalmente por el Ministerio de Salud del GCBA en 2023 mediante el Decreto 81/23, como continuación del Grupo de Trabajo Inmunocomprometidos, conformado por la entonces Secretaría de Salud del GCBA el 20 de junio de 1997. Iniciada en un consultorio con pocas horas de atención en 1994, se convirtió en un sitio de referencia en asistencia, docencia e investigación clínica en infección por VIH/SIDA y otras enfermedades emergentes, vinculada desde el año 2000 con la Fundación IBIS. Depende de la Subdirección

Médica y se organiza en tres áreas: el Servicio de Inmunocomprometidos, el Área de Investigación Clínica "Nuestra Señora de Guadalupe" (creada en 2022) y la Clínica de Salud Sexual, que incluye el Centro de Testeo, Prevención y Diagnóstico (CePAD, creado en 2001) y la Clínica de Salud Sexual propiamente dicha (ClinSex, 2017). Está integrada por el Jefe de Sección, Prof. Dr. Marcelo H. Losso, cinco médicos de planta y tres enfermeros, además del personal aportado por la Fundación IBIS.

El CePAD ha realizado más de 60.000 testeos desde su creación, con una prevalencia del 3,1% y una incidencia de 5,6 por 100 personas/año registradas en 2022; ClinSex se ha convertido en uno de los principales prestadores públicos de PrEP y prevención combinada del país, con más de 1000 usuarios en seguimiento. En octubre de 2024, 2842 personas que viven con VIH/SIDA se encontraban en seguimiento por tratamiento antirretroviral en el Hospital. En docencia, la concurrencia post-básica en VIH/SIDA fue aprobada por la Secretaría de Salud en 2002; desde 2016 el servicio es sede de la Residencia de Investigación en Salud y desde 2022 del Curso Bianual de Postgrado de Investigación en Salud de la Facultad de Medicina de la UBA. El Dr. Losso, Investigador Principal de la carrera de investigador del GCBA, encabeza desde 2014 la producción anual de publicaciones del Hospital, con más de 220 manuscritos en revistas con revisión de pares; el servicio participó de los ensayos SMART y START, que definieron el estándar de tratamiento antirretroviral en adultos, y del estudio PROMISE en mujeres embarazadas. Durante la pandemia de COVID-19, un subsidio de los NIH permitió reciclar en 17 días una planta física del Hospital donde se desarrollaron múltiples estudios de vacunas, tratamiento y prevención de la enfermedad.

Agradecimiento: un reconocimiento especial al Dr. Carlos A. Sanguinetti, Jefe de División de Clínica Médica, quien impulsó la creación del Grupo de Trabajo dedicado a la atención de personas que viven con VIH/SIDA en los albores de la pandemia en la Argentina, y avaló la coordinación a cargo del Dr. Marcelo H. Losso, quien redactó este capítulo.

Sección Hipertensión Arterial

Creada en 1994 a partir de un proyecto inicial del Dr. Gustavo Carusso, instructor de Residentes de Clínica Médica, y del Dr. Luis Gioseffi, Jefe de División B de Clínica Médica, se oficializó como el primer Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial del GCBA tras superar numerosos obstáculos administrativos, políticos y económicos. Con el paso de los años —con mención especial a los Dres. Mariana Pérez y Diego Fernández— se transformó de una pequeña estructura asistencial en una Sección con importante actividad académica (primera concurrencia post-

básica en Hipertensión Arterial, cursos pre y postbásicos, rotación de residentes y de enfermería, actividad universitaria de grado y de especialización) y de investigación clínica, con participación en numerosos trabajos nacionales e internacionales. En 2023, más de 30 años después de su creación, se convirtió oficialmente en la primera Sección de Hipertensión Arterial del ámbito público de la CABA, constituyéndose como centro de referencia, con ampliación de sus recursos edilicios, de personal y de metodología diagnóstica para la evaluación de la patología arterial y la hemodinamia no invasiva.

Agradecimiento: Al Jefe de Sección Dr. Gustavo Carusso, quien redactó este capítulo, nuestro reconocimiento.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 16

Consultorios Externos

Desde la inauguración del Lazareto San Roque en 1869, para la atención de los pacientes con cólera, y luego con su extensión a la atención de los enfermos de fiebre amarilla, hasta el año 1882 el Lazareto ya había atendido a unas 9.000 personas.

En los años siguientes, la atención ambulatoria creció exponencialmente. Al incorporarse diferentes especialidades y la atención de mujeres y niños, el número de pacientes ambulatorios no dejó de incrementarse año a año, y hubo que disponer no solo de lugar físico, sino también de personal médico y no médico para su atención. Nuestro Hospital siempre ha estado entre los dos primeros hospitales públicos polivalentes de la ciudad de Buenos Aires en cantidad de pacientes ambulatorios atendidos: en la actualidad se atienden anualmente entre 600.000 y 700.000 pacientes.

Si bien en la bibliografía consultada no aparece citado el proceso de transformación de los consultorios externos —desde el Lazareto hasta el Hospital San Roque, no solo en lo edilicio, sino también en cuanto a su organización y funcionamiento hasta la época actual—, podemos inferir que su evolución fue de la mano del avance de los conocimientos médicos. Así, en las últimas dos décadas del siglo XIX, coincidiendo con la creación del Lazareto, se produjeron cambios notables en los conocimientos (fisiopatología, bacteriología) y en la práctica de la medicina, en torno a la ampliación de la mirada médica que hizo posible la tecnología (oftalmoscopio, gastroscopio, broncoscopio, rayos Roentgen, etc.). El surgimiento del higienismo y la introducción de la antisepsia y la asepsia hicieron que la atención médica se centrara en los consultorios de la institución hospitalaria, requiriendo un espacio donde confluyeran médicos con diversas pericias y en el que se contara con una variedad de instrumentos y con personal auxiliar especialmente capacitado.

Si bien desde su inicio como lazareto se contó con consultorios para la atención ambulatoria, en su actividad médica el Dr. Ramos Mejía promovió la ampliación de consultorios externos destinados a otras especialidades —además de las enfermedades del sistema nervioso y de las clínicas médica y quirúrgica—, agregándose los de otorrinolaringología y enfermedades de la piel. Poco tiempo después, el Dr. José Ingenieros, discípulo de Ramos Mejía, comenzó

a atender en los consultorios hospitalarios a sus pacientes cuyo padecimiento tenía causa psíquica. En 1886 se incorporó al Hospital el Servicio de Medicina Infantil, que contó no solo con área de internación, sino que también inició la atención de niños en consultorios.

En 1928 el Hospital se reconstruye, se amplía y se reinaugura, el 8 de octubre de ese año; posiblemente en esa reconstrucción los consultorios externos fueron instalados en el primer piso, como se hallan actualmente. En este breve recorrido podemos observar que, desde la creación del Lazareto, los consultorios externos brindaron atención de manera ininterrumpida hasta la actualidad: en sus comienzos, con un horario reducido de cuatro horas diarias de lunes a viernes; y a partir del año 2007, debido a la gran demanda de servicios de salud, se amplió el horario de atención entre las 8 y las 20 horas. En estos consultorios atienden 34 especialidades médicas —muchas de ellas con subespecialidades— dispuestas en 155 consultorios (54 centralizados y 101 descentralizados). Un párrafo aparte merece la actividad de los consultorios durante la pandemia de COVID-19, que puso a toda la comunidad hospitalaria frente a un nuevo desafío: se mantuvieron activos los consultorios de todas las especialidades, brindando atención médica oportuna a todo paciente que lo requiriera, tanto de manera presencial como virtual (teleconsultas).

En esta evolución, el Hospital dejó de ser el lugar donde se recibía a pobres y menesterosos para convertirse en un centro especializado de cuidados médicos, sumándose además la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, así como la enseñanza y la investigación. Queremos citar a los Jefes de Consultorios Externos de los últimos treinta años, los Dres. Ricardo Rezzonico, Marta Contreras, Jorge Paulucci y Marta Ascorti. Recordamos también a otros queridos colegas, como el Dr. De Lisi, el Dr. Aldo González y las Dras. María Inés Vásquez y Leticia López.

Agradecimiento: La Dra. Graciela M. Suárez, con la colaboración de las Dras. Leticia López y Marta Ascorti, ha redactado el capítulo, y para ellas nuestro agradecimiento.

Capítulo 17

Dermatología

El Prof. Baldomero Sommer, con antelación a la fundación de la Sociedad Dermatológica Argentina, viajó a Europa en 1884 para trabajar junto a Moriz Kaposi. A su regreso, en el año 1892, fue designado profesor titular de la Cátedra de Dermatología de la UBA, así como jefe del Servicio de Enfermedades de la Piel y Venereosifilíticas del Hospital San Roque. Hacia 1900, la Dermatología funcionaba en la planta baja donde hoy está el Laboratorio Central. Baldomero Sommer fue pionero de la Dermatología en la Argentina y primer jefe de la Sala XIV del Servicio de Dermatología y Sifilografía de nuestro Hospital.

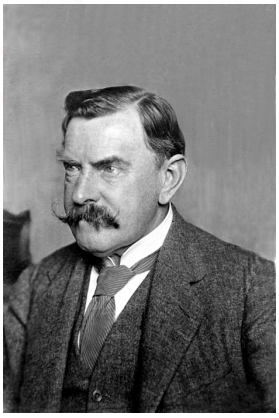


Figura 17.1: Prof. Dr. Baldomero Sommer. *Fuente: Archivo General de la Nación.*

Reunió en su Cátedra del Hospital San Roque a los especialistas de entonces —un pequeño grupo que las circunstancias del momento hicieron que fuera todo él destacado, razón por la cual la nueva Asociación tuvo brillante actuación desde su iniciación—. Se encontraron entre ellos quienes después fueron eminentes profesores, como M. Aberastury, P. L. Baliña, Ricardo Nölting y N. V. Greco. Desde la Asociación se trataron todos los temas de la especialidad, se movió la opinión pública y se incitó a los gobernantes a ocuparse de dos puntos fundamentales para la salud: la higiene y profilaxis de las enfermedades venéreas y, muy especialmente, la lepra. Como resultado de su acción contra la lepra se obtuvo la sanción de la ley de profilaxis de esa enfermedad, que lleva el nombre de su redactor, Aberastury. El 21 de agosto de 1907, un grupo de dieciséis médicos se reunió en el Consultorio de Enfermedades de la Piel y Venereosifilíticas del viejo Hospital San Roque con el objeto de fundar la Sociedad Dermatológica Argentina. El Prof. Baldomero Sommer fue el agente catalizador de aquella reunión y, por propia gravitación, el indiscutido primer presidente de la Sociedad. Veinte años después, en mayo de 1927, a propuesta del profesor Maximiliano Aberastury —continuador de Sommer en la Cátedra—, se adoptó el nombre actual de Asociación Ar-

gentina de Dermatología y Sifilología.

Figura 17.2: Busto del Prof. Marcial Quiroga, en el patio del Hospital.

Otra figura cumbre de la Dermatología argentina fue el Prof. Pedro L. Baliña, que en 1929 fue jefe de la Sala XIV de Dermatosifilografía. Constituyó, junto con Sommer y Aberastury, el trípode sobre el cual descansó firmemente el prestigio y la tradición de la Asociación. Baliña —maestro de la gran mayoría de los dermatólogos de la segunda mitad del siglo XX— estuvo ligado a la Asociación desde su comienzo, como primer secretario, luego como presidente durante dos períodos y, finalmente, como presidente honorario. Sus sabios consejos e inapreciable experiencia estuvieron siempre presentes hasta su fallecimiento en 1949. La Asociación de Dermatología y Sifilología ostenta con orgullo el título de primera sociedad de médicos especialistas constituida en el país y de primera sociedad dermatológica de los países de habla hispánica. Junto a Baliña se formó un grupo excepcional de jóvenes dermatólogos, como Marcial Quiroga, Alejandro Cordero, Pedro Magnin, Guillermo Basombrío y Antonio Raimondo; venían médicos de toda Latinoamérica y de España a formarse junto a ellos.

La posta se pasó luego a otra gran figura de la Dermatología, que haría de la docencia de pre y posgrado otro gran legado de este Servicio: el Prof. Dr. Pedro Horacio Magnin. Cursó Dermatología en el último año de la carrera de Medicina de la mano del profesor Marcial Quiroga, quien le transmitió el amor por la especialidad y de quien sería discípulo. En 1950 ingresó como adscripto a la Clínica Dermatológica de nuestro Hospital, a cargo del Prof. Marcial Quiroga, donde desarrollaría su actividad asistencial, docente y de investigación, incluso luego de su jubilación. Fue nombrado encargado de investigaciones de la Cátedra de Dermatología de la Universidad de Buenos Aires en 1952 y se doctoró, con calificación de tesis sobresaliente, en 1953. Se introdujo en el estudio de la melanogénesis a instancias de Quiroga y, con el desarrollo de la beca José Puente, durante 1954 inició investigaciones sobre el tema, que proseguiría en la Universidad de Chicago, con el profesor Stephen Rothman, durante 1955. A su regreso, en 1956, fue nombrado Docente Autorizado de la Universidad de Buenos Aires; fue profesor adjunto de Dermatología en 1965 y, en 1971, con tan solo 45 años, profesor titular. Ese mismo año ganó la jefatura del Servicio de Dermatología, sucediendo al Prof. Mazzini. Desde 1973 hasta 1986 fue director de la unidad docente hospitalaria. A fines de la década de 1970 se hizo una reforma en el segundo piso y, temporariamente, Dermatología pasó a Clínica Médica, División C; en la primavera de 1980 pasó a ocupar toda su actual disposición.

Fue un incansable trabajador, con extraordinarias condiciones organizativas, que plasmó en la Cátedra y en su quehacer diario. Su agenda, inseparable compañera, reflejaba el tra-

bajo cotidiano, proyectado muchas veces con hasta dos años de antelación. Era el primero en llegar al Servicio, comenzando su actividad antes de las 4 de la mañana. En la sala de Dermatología, la Sala XIV, desarrollaba una intensa labor en la que se sucedían la atención de enfermos, las interconsultas, los cursos, los ateneos clínicos y bibliográficos, las entrevistas, las recorridas de sala y la supervisión de trabajos científicos, de investigación, de becas o de tesis doctorales que apadrinaba. Constituyó ejemplo y estímulo para quienes lo rodeaban, que encontraban en él el apoyo y el aliciente necesarios. La sala de Dermatología lleva hoy el nombre del Dr. Baldomero Sommer. Magnin dividió el Servicio en 17 sectores, como subespecialidades. Continuaba su tarea en la práctica privada, en su consultorio, y las últimas horas del día las dedicaba al estudio, la escritura y la preparación de conferencias, trabajos, clases y cursos, en su vasta y actualizada biblioteca del 5.º piso de la calle Arenales. Pasaba los fines de semana en su quinta de Ezeiza, su cable a tierra, no sin antes —los sábados por la mañana o al regreso, los domingos— visitar a los pacientes internados en su servicio. Fue un fiel ejemplo de estudio, esfuerzo, dedicación y compromiso.

Figura 17.3: El Dr. Pedro H. Magnin junto a su maestro, el Prof. Marcial Quiroga, y colaboradores.

Con la convicción de que la educación es uno de los pilares más importantes para el desarrollo del ser humano, ejerció con entusiasmo la docencia de pre y posgrado, con más de 200 cursos para especialistas dictados. Estos se iniciaban en febrero con el curso de formación de ayudantes de trabajos prácticos, poniendo especial interés en la relación docente-alumno; en el mismo mes se desarrollaba la cursada de verano para el pregrado. Cabe mención especial el curso anual para graduados, con clases teórico-prácticas, que se iniciaba los lunes a las 5 de la mañana —con la atención de pacientes que en muchos casos pasaban la noche en el hospital para ser atendidos—, actuando él como único docente. Dirigió el Curso Superior para la especialización de dermatólogos de la Asociación Argentina de Dermatología entre 1968 y 1970, y el de la UBA entre 1973 y 1992. Puso particular interés en ciertos aspectos de la Dermatología y la medicina social, reflejados en la prioridad que dio a la atención, el estudio y el seguimiento de pacientes con melanoma y en el énfasis que ponía en la campaña contra la lepra: además de destacar la importancia de educar tanto al dermatólogo como al médico general en el reconocimiento precoz de la enfermedad, con sus cursos "Piense en lepra", lo plasmó en la campaña de búsqueda activa de casos. El Servicio, bajo su dirección, fue uno de los primeros en adherirse, a partir de 1981, a la poliquimioterapia propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Fue autor de 19 libros —y colaborador en otros 5—, con aproximadamente 320 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales y más de 400 conferencias pronunciadas en el país y en el extranjero. A lo largo de su carrera recibió más de 20 premios, otorgados por distintas entidades, como la Facultad de Medicina de la UBA, la Asociación Argentina de Dermatología, la Comisión Nacional de Cultura y la Academia Nacional de Medicina, ocupando

el sitial de Marcial Quiroga. En 1986 recibió el título de Maestro de la Medicina, otorgado por la Prensa Médica —premio a la trayectoria de una vida como médico y como hombre—, galardón que ese año compartió con el Dr. René Favaloro y el Dr. Emilio Etala, y que antes habían recibido los doctores Marcial Quiroga, Pablo Negroni, Alfredo Lanari, Leoncio Arrighi, Luis Federico Leloir, Enrique Malbrán y Roberto Votta, entre otros. Fue director de la *Revista Argentina de Dermatología* y presidente, en tres oportunidades, de la Asociación Argentina de Dermatología, entidad a la que —al igual que al Servicio— dedicó gran parte de su tiempo.

Figura 17.4: El Prof. Magnin junto a sus discípulos del Servicio de Dermatología.

En palabras del ex jefe del Servicio, el Dr. Daniel Feinsilver: *"Su escuela estaba signada por la correlación clínico-patológica, el cuestionamiento diagnóstico y sus diagnósticos diferenciales. Admitía en el servicio a todos, no te cerraba la puerta, pero decía: 'vienen solos y se van solos'; cuando no respondías a sus exigencias, te ignoraba y te ibas. Siempre te exigía más, y sabía cuándo estabas preparado para darte libertades académicas, pero nunca dejaba de ayudarte y de revisar tus trabajos, en los que no quería figurar, aunque los trabajara. Un grande absoluto, un padre de la medicina con nosotros; nunca ocultó sus conocimientos, y si no sabíamos el diagnóstico, decía: 'vamos a investigar'. Sus principios eran la ética, la dignidad y la solidaridad con los pacientes. Sus cursos, ateneos y clases de actualización, donde siempre nos daba un lugar y nos hacía crecer, llenaban el aula; siempre quedaba gente parada fuera de la puerta abierta. Venían jóvenes dermatólogos en formación de todas las provincias y de países vecinos. Invitaba a profesores de todos los hospitales, y también del interior y del exterior".*

En la actualidad, en el Hospital se dicta el Curso de Especialistas Universitarios de la especialidad, de la Facultad de Medicina de la UBA, y funciona una de las residencias más reconocidas del país. Después del Prof. Dr. Pedro Horacio Magnin fueron jefes de División los Dres. Daniel Feinsilver, Mercedes Hassan y, en la actualidad, David Muhafra.

Agradecimiento: A los Dres. Daniel Feinsilver, Natan Gotlib y David Muhafra, que han colaborado en la redacción del capítulo, nuestro agradecimiento.

Capítulo 18

Diagnóstico por Imágenes

Si bien hoy en día el nombre de la División es Diagnóstico por Imágenes, solo 22 años después del descubrimiento de los rayos X se fundó la Sociedad Médica de Radio y Electrología —primer nombre de la Sociedad Argentina de Radiología (SAR)—, en Buenos Aires, el 14 de mayo de 1917. Teniendo en cuenta este contexto, vale recordar a quienes pusieron la piedra fundamental para la creación de la sociedad: los Dres. Alfredo Lanari, Humberto Carelli, José Saralegui, José F. Merlo Gómez, Juan E. Barragué, José Guardado, Eduardo L. Lanari, Carlos H. Niseggi, Pedro A. Maissa, Antonino de Nucci, Alberto M. Marqué, Cornelio Donovari, Rafael Espínola y Antonio Valdivieso.

Figura 18.1: Sala de radiografía del Hospital, *circa* 1910. *Fuente: Colección César Gotta.*

Figura 18.2: Dr. Pedro Abel Maissa, profesor de Radiología y Fisioterapia y jefe del Servicio Central.

El Dr. Pedro A. Maissa, egresado en 1922, era concurrente al Instituto de Radiología del profesor Alfredo Lanari y se desempeñó a continuación en el Hospital Nacional de Clínicas. En 1929 era jefe de la sala de Rayos X el Dr. Rafael Espínola. Maissa fue, en 1934, profesor adjunto de Radiología y Fisioterapia y, en 1936, jefe del Servicio Central del Hospital Ramos Mejía, cuyo pabellón integral proyectó e inauguró el 17 de julio de 1942. Fue elegido por concurso profesor titular en 1955, y presidente de la SAR entre 1939 y 1941. El curso de Médico y Técnico Radiólogo Universitario fue una iniciativa del Dr. Maissa, quien presentó el proyecto al decano Dr. Escardó el 22 de enero de 1958; el nuevo decano, Dr. Luis Munist, lo aprobó el 29 de abril de 1959. Al entrar en vigencia el llamado plan de las Unidades Hospitalarias en 1961, se suprimió Radiología como materia de promoción, quedando limitada a ser una cátedra de posgrado; una serena evaluación de los resultados llevó a las autoridades de la Facultad a enmendar ese error, y la materia volvió al currículum: la primera promoción de alumnos de Medicina realizó su curso en mayo de 1983. En 1972 Maissa creó la Fundación Maissa, y en 1980 se inauguró el Instituto de Estudios Oncológicos. Fue premiado como Maestro de la Medicina Argentina en 1988.

Figura 18.3: Placa recordatoria al Maestro Dr. Mario Martella, en el Pabellón "Luis Mariano Zuberbühler".

Figuras descollantes han pasado por el Servicio, como los Dres. César Gotta, Mario Martella —que vino desde el Hospital Rawson en 1977 a nuestro Servicio, donde permaneció hasta su jubilación—, Juan Carlos Spina y Gloria Díaz, que dieron prestigio nacional a nuestro Servicio.

Gloria Díaz fue jefa del Servicio de Radiodiagnóstico de nuestro Hospital hasta jubilarse. Fue profesora titular por concurso de Diagnóstico por Imágenes en la Facultad de Medicina de la UBA hasta su jubilación, presidenta de la SAR en el período 1983–1984 y Maestra de la Radiología Argentina en 1994. Todo esto, antes de que existiera la Ley de Cupo Femenino en el país y en épocas en que el porcentaje de mujeres estudiantes de medicina o médicas era sensiblemente menor al actual. Pero sus días de gloria también incluyen las jornadas en el Hospital Rawson, a cargo de la Sección Angiografía, donde practicaba y enseñaba lo aprendido en París en los años sesenta; o su trabajo en el Hospital Ramos Mejía, donde lideraba un servicio que era modelo en el ámbito público, por el que pasaron infinidad de radiólogos que buscaban conseguir una rotación "con Gloria" para completar su formación. Todos —pero sobre todo

quienes compartieron con ella los días de hospital— la describen como una personalidad carismática, vigorosa y emprendedora. Sus discípulos subrayan su honestidad, su espíritu docente, su ilimitada capacidad de trabajo y su sentido del humor, siempre agudo. Gloria Díaz fue además madre de tres hijos, dos de ellos —Carla y Pablo— relacionados con la radiología. Al repasar su trayectoria resulta impactante la labor de Gloria, como todos la llaman, y uno imagina el esfuerzo y las horas que su obra demandó. Su ejemplo desmiente el adagio desmoralizante que cada tanto nos impregna, e inspira el esfuerzo de muchas colegas que, además de cumplir con la labor asistencial, enseñan, investigan, estudian y viajan para completar su formación. Gloria Díaz, pionera de la radiología argentina, femenina y singular.

El Pabellón "Luis Mariano Zuberbühler" de Diagnóstico por Imágenes ha atravesado muchas transformaciones edilicias, y hoy cuenta con cuatro salas de radiología digital, una sala de radiología digital contrastada, dos salas de mamografía digital, tres salas de ecografía general, una sala de ecografía de urgencia, una sala de ecodoppler, intervencionismo y área de la mujer, un tomógrafo helicoidal multicorte de 16 canales y, próximamente, un resonador magnético; todo digitalizado y con un sistema PACS para su almacenamiento y consulta.

Figura 18.4: Esquina del Servicio de Radiodiagnóstico, 1945.

Agradecimiento: El Dr. Sebastián Pérez Espinosa ha colaborado en la redacción del capítulo, y para él nuestro agradecimiento.

BORRADOR

Capítulo 19

Endocrinología

El nacimiento de la Endocrinología de nuestro Hospital estuvo íntimamente ligado al cierre del Hospital Rawson durante la dictadura militar, en 1978. Pero comencemos la historia unas décadas antes ya que, como está relatado en otro capítulo, tanto el Dr. Houssay como el Dr. Leloir fueron médicos en nuestro Hospital. Los médicos formados en el Instituto de Fisiología del Hospital Rawson condujeron y llevaron a cabo, en las décadas de 1930 y 1940, la transformación de la clínica médica basada en la anatomía patológica hacia una clínica basada en la fisiopatología. Allí, con la creación de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, la Endocrinología argentina se fundó con Alfredo Biasotti, Enrique B. del Castillo, Juan Reforzo Membrives y Rodolfo Pasqualini. Rodolfo Pasqualini fue uno de los padres de la Endocrinología del país, junto a Bernardo Houssay. El Dr. Pasqualini fue profesor titular de Clínica Médica y director del Instituto Modelo Doctor Luis Agote en el Hospital Rawson. Desde 1947 hasta 1955 ocupó la dirección del Instituto Nacional de Endocrinología, creado por Ramón Carrillo. Uno de sus discípulos fue el Dr. Roberto Soto.

El Dr. Roberto Soto, profesor emérito de la Facultad, fundó el Servicio de Endocrinología del Rawson. Allí lo acompañó el Dr. Gerardo Sartorio, bioquímico, con la creación de un laboratorio propio de medición de hormonas. Desarrollaron, entre otros aportes, el método para medir la tiroglobulina como marcador oncológico del cáncer de tiroides, y su aplicación. Se conformó la primera Residencia de Endocrinología en adultos del país, en 1971, que permitió la incorporación de endocrinólogos a lo largo de todo el país. También fue la única sede del Curso Superior de Especialista en Endocrinología a cargo del Dr. Pasqualini, que posteriormente fue trasladado al Hospital de Clínicas y que en la actualidad cuenta con distintas sedes para la formación de la especialidad.

Mientras tanto, en esos años, en nuestro Hospital trabajaba en Clínica Médica la Dra. Hilda Parisier, endocrinóloga (ver más adelante la reseña en el tema Desaparecidos durante la Dictadura), quien llegó a ser editora de la revista de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, y gran generadora de publicaciones en revistas indexadas.

Cuando se cerró el Hospital Rawson, el Servicio se trasladó al Hospital Ramos Mejía y,

junto al Dr. Roberto Soto y el Dr. Gerardo Sartorio, pasaron los médicos de planta —los Dres. Antonio Codevilla, Elena Yampey, Hernán Flaster, María Luisa Mac Kay, David Goldberg, Graciela Stalldecker y Rabino—; los residentes de tercer año —los Dres. Gabriel Glikman y Alberto Vespasiano—, los de segundo año —María del Carmen Silva Croome y Gustavo Rocatagliata—, e ingresaron en primer año, ya en este Hospital, las Dras. Susana Lupi y Alicia Gauna, y como instructora la Dra. Ester Pardes y como jefa de residentes la Dra. Lidia Coniglio. En el Hospital Ramos Mejía ocupó el espacio físico donde funcionaba Hematología —y donde está actualmente la División Endocrinología—, de ahí que todavía hoy haya quedado Hemoterapia en la planta baja y el primer piso. Mientras se realizaron las remodelaciones edilicias del pabellón de Hematología, el Servicio deambuló por distintas partes del Hospital, incluida una sala de cirugía. En 1982 se llegó a la estructura actual, en la cual en la planta baja funcionan los consultorios externos de las diferentes áreas del Servicio, en el primer piso el Laboratorio de Hormonas y, en el subsuelo, el aula, el despacho de jefatura y las áreas de trabajo académico. Junto con Endocrinología, los Dres. Soto y Sartorio trajeron también la Medicina Nuclear al Hospital, cuyo alcance en ese tiempo se limitaba prácticamente al diagnóstico y tratamiento de las tiroideopatías. En 1982 se creó el Servicio de Medicina Nuclear independiente de Endocrinología —en la planta baja, donde está hoy en día—, con todo el crecimiento de esta rama de la medicina que hoy conocemos.

Otro aporte de los Dres. Soto y Sartorio fue el desarrollo de la medición neonatal de TSH, junto con el Servicio de Endocrinología del Hospital Ricardo Gutiérrez, para diagnosticar precozmente el hipotiroidismo neonatal, estudio que hoy es de rutina diaria para todo neonato en el mundo. En la Argentina, la pesquisa neonatal para el hipotiroidismo congénito primario se realiza desde la década de 1980, siendo obligatoria por ley nacional —la ley 23.413 y su modificatoria 23.874, reglamentadas en noviembre de 1996— "en todos los recién nacidos de maternidades y establecimientos asistenciales que tengan a su cuidado recién nacidos". Nuestra División integra desde hace años, y hasta la actualidad, la red de Pesquisa Neonatal del Gobierno de la Ciudad.

Al Dr. Roberto Soto se lo recuerda como un hombre incansablemente trabajador, de carácter severo, y con una capacidad creativa y un empuje destacados. Su comentario habitual ante la dificultad era: "Hacer una torta con huevo, harina, manteca y azúcar es fácil", y así emprendía los desafíos. Organizó jornadas científicas cubiertas totalmente con exposiciones de ocho a diez invitados extranjeros, líderes en patología tiroidea. A la residencia siempre le dio un lugar destacado, incentivando la investigación, las becas y una actividad asistencial basada en el respeto y el conocimiento. Se jubiló en el año 1986 y le sucedió, como jefe, uno de sus discípulos, el Dr. Antonio Codevilla. Luego el Servicio estuvo sin jefe durante siete años, por conflictos legales en el concurso de dicho cargo, y en ese tiempo fue sostenido por todos sus integrantes. El Dr. Levi continuó y, desde 2010 hasta la actualidad, es jefa de División la Dra. Alicia Gauna. Como jefes del Laboratorio de Endocrinología, al Dr. Sartorio lo continuó la Dra. Patricia Glikman y, actualmente, la

Dra. Fabiana Fierro, quienes junto a los bioquímicos de planta mantuvieron el alto nivel, incorporando permanentemente nuevas metodologías y la medición de nuevos analitos. La Residencia de Endocrinología es una de las más prestigiosas de Latinoamérica, y el Servicio, si bien fue reconocido tradicionalmente por sus mayores aportes en el estudio de la patología tiroidea, en la actualidad es de referencia tanto en tiroides como en las distintas áreas de la Endocrinología.

Agradecimiento: Las Dras. Silvia Croome y Alicia Gauna y el Lic. Gerardo Sartorio han colaborado en la redacción del capítulo, y para ellos nuestro agradecimiento.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 20

Enfermería

Sin duda, la figura fundacional de la Enfermería en la Argentina —y, a la vez, primera médica del país— fue Cecilia Grierson Duffy (1859–1934). En 1883 ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas, donde se graduó seis años más tarde. A principios de abril de 1886 la ciudad de Buenos Aires sufrió una epidemia de cólera —la tercera del siglo—, y todos los estudiantes de medicina fueron convocados a prestar servicios en la salud pública. Cecilia Grierson fue destinada a la Casa de Aislamiento (Paraguay y Azcuénaga, el embrión de lo que sería, años más tarde, el Hospital de Clínicas), uno de los lugares de atención y refugio para los enfermos que debieron improvisarse a lo largo de la ciudad. Tuvo como grupo de trabajo al Dr. Penna y al Dr. Estévez. Decía la Dra. Grierson: *"Los días agotadores pasados en la Casa de Aislamiento me hicieron concebir la idea de educar a enfermeras, puesto que no había quien respondiera a las necesidades de los enfermos. El mejor medio de proporcionar alivio a los que sufren es colocar a su lado personas comprensivas, afables y capacitadas que puedan colaborar con el médico en la lucha por recobrar la salud".*

Figura 20.1: Cecilia Grierson, sentada en quinto lugar desde la derecha, junto a sus estudiantes, 1910. *Fuente: Archivo General de la Nación Argentina.*

La epidemia pudo controlarse, mermando los casos hacia fines de abril de ese año, fecha

en la que Grierson retomó sus estudios —pese a haber sufrido las descalificaciones de sus profesores y compañeros—. En 1889, un grupo de estudiantes disconformes, entre los que se encontraban José María Ramos Mejía y Juan B. Justo, por considerar la carrera de medicina demasiado teórica y carente de práctica, creó el Círculo Médico, donde funcionó una escuela práctica de medicina con consultorios de diversas especialidades y un centro dedicado a la difusión y a la investigación. En este establecimiento Grierson creó la primera Escuela de Enfermeras de América Latina, con un plan de estudios formal, en la que se estableció el uso de uniforme para las enfermeras —adoptado posteriormente por la mayoría de los países latinoamericanos—. Se desempeñó como directora hasta 1913.

Apenas se recibió se incorporó al Hospital San Roque, donde se dedicó a la ginecología y la obstetricia. Hoy en día, la Escuela de Enfermería Profesional que lleva su nombre, fundada en 1886, con más de 125 años de historia, ofrece dos modalidades de formación: la de Auxiliar de Enfermería (que requiere título secundario y se cursa en dos años) y la de Profesional de Enfermería (una carrera de tres años). Funciona en el barrio de Caballito, junto al Hospital Durand. Entre sus principales características se cuenta la innovación de pensar una enfermería mixta y laica, al frente del cuidado de las poblaciones y de la enseñanza en salud. A diferencia de la corriente anglosajona, Grierson no excluyó de la enfermería a los varones, aunque estableció diferencias en el ejercicio profesional siguiendo estereotipos de la época. En su trayectoria pueden identificarse acciones tendientes a fortalecer la obligatoriedad del estudio sistemático de la enfermería, el control de la formación y del ejercicio profesional, y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las enfermeras. No agotó allí los temas sobre los que argumentó: también se explayó acerca de la educación técnica y el trabajo de la mujer, la relación entre el magisterio y la enfermería, la creación de instituciones que ampliaran la influencia de la profesión, la militancia gremial y la inclusión del estudio de la enfermería en la universidad. Grierson organizó a las y los graduados con el fin de controlar el ejercicio, la formación y la protección social, además de conformar un gremio ya en el siglo XIX.

Figura 20.2: Enfermeros del Hospital, 1910. *Fuente: Dirección General de la Administración Sanitaria y Asistencia Pública, Memorias, Intendencia Municipal de la Capital, 1910.*

Lamentablemente, no poseemos registros ni confirmación de hechos previos al año 1961, cuando se hallaron documentos que mencionaban a la primera jefa de Departamento de Enfermería, la Srta. Susana Sánchez, ejerciendo la Dirección del Hospital el Dr. José Luis Ayerza. A partir de entonces, y hasta el período anterior a 1987, carecemos de información. La Jefatura de Departamento de Enfermería fue conducida luego por Consuelo Iturrospe, Mercedes Medina (1987), la Lic. Leonor Andrada (1987–1989), la Lic. Nelly Maidana (1991), la Lic. María Luisa Acosta y la Lic. Susana Rodríguez (ambas a cargo hasta la selección de titular), la Lic. Isabel González Seguel, la Lic. Mirta Sosa, nuevamente la Lic. Isabel González Seguel (2008–2012), la Lic. Viviana Fernández (2012–2013) y, desde 2013 hasta la actualidad, la Lic. Hilda Fernández.

El panorama de la década de 1960 se caracterizaba por un plantel mínimo de personal formado —acorde al momento— y mucho personal empírico, proveniente en su mayoría de las mucamas de los sectores de internación, con vocación y voluntad de aprender técnicas de atención. El Hospital no escapaba a la situación general de la época: a pesar de que empezaban a aparecer centros formadores (la Cruz Roja Argentina, las escuelas de los hospitales de colectividades, etc.), el grueso del plantel de Enfermería estaba compuesto por personal de formación empírica, captado entre quienes se encargaban de otras tareas o entre voluntarios. En 1967 se sancionó la Ley 17.132 (del Ejercicio de la Medicina, la Odontología y las Actividades de Colaboración), que incluía un capítulo para la Enfermería y sus competencias. A partir de ella comenzó a perfilarse —muy lentamente— un perfil de mayor formación académica para la actividad, aunque en los puestos de conducción persistía el personal con mayor experiencia y trayectoria.

Fueron necesarios veinticuatro años más para la sanción de la Ley 24.004, del Ejercicio Profesional de la Enfermería, que sentó las bases de las incumbencias específicas para los distintos niveles de formación y comenzó a implementarse en los ámbitos hospitalarios de la Ciudad de Buenos Aires.

Figura 20.3: Enfermeras del Hospital, 1910. *Fuente: Dirección General de la Administración Sanitaria y Asistencia Pública, Memorias, Intendencia Municipal de la Capital, 1910.*

En 1999 se sancionó, en la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 298, que establece el Ejercicio Profesional de la Enfermería y de las Auxiliares de Enfermería y que, junto con la Ley 471 (de Relaciones Laborales, del año 2000), regula el marco legal y laboral de la profesión. Pese a los reclamos reiterados para que los licenciados en Enfermería fueran incorporados —al igual que otros profesionales de la medicina— a la Ley 6035/18, fueron excluidos sistemáticamente; en su lugar se celebró el Acta de Negociación Colectiva 19-2022, que estableció la Carrera Administrativa del Personal de Enfermería (CAPE) de aplicación en el Gobierno de la Ciudad. Dicha reglamentación diferencia la carrera de Enfermería de otras actividades, pero mantiene al personal encasillado dentro del escalafón general en lugar del profesional.

En 1996 se produjo el congelamiento de las estructuras de Enfermería, lo que generó un gran desfasaje entre las necesidades de cobertura y la dotación de personal disponible para afrontarlas. Como paliativo, esas necesidades se cubrían con los Módulos de Enfermería, creados en 1986 y vigentes hasta la fecha. Recién en 2004 comenzaron a producirse, de manera gradual, movimientos de incorporación de personal. Las estructuras de Jefaturas de Sección y de División se destrabaron en 2018, lo que permitió cubrir los cargos de conducción que hasta entonces se hallaban ocupados por suplencias. En 2016, mediante el Decreto 260, se crearon las Subgerencias Operativas de Enfermería, cargo que ocupó por primera vez la Lic. Viviana Fernández, sucedida por la Lic. Lidia Barrionuevo y esta, a su vez, por la Lic. Ana Sánchez —en todos los casos, la sucesión se produjo por la jubilación de quien lo ejercía—. En la actualidad se aguarda el concurso para la designación del cargo, tras la jubilación de la Lic. Sánchez. A la fecha, el Departamento cuenta con una dotación de 603 personas.

BORRADOR

Capítulo 21

Farmacia

La primitiva construcción que se inauguró en 1869 consistió en dos grandes barracas de adobe (de 20 m de largo, 6 m de ancho y 5 m de altura), con capacidad para 40 camas, y diez casetas de madera, una de ellas dedicada a la botica. En 1904, en el Hospital de San Roque, ya se destina un lugar específico a la Farmacia. En el Diario de la Agrupación de Practicantes del Hospital Ramos Mejía, en 1929, se da cuenta de que el Hospital contaba con un Servicio de Farmacia a cargo del Dr. José F. Bruquetas.[35,36]

Figura 21.1: Farmacia del Hospital, 1910. *Fuente: Dirección General de la Administración Sanitaria y Asistencia Pública, Memorias, Intendencia Municipal de la Capital, 1910.*

A fines del año 1996 se generó el área de Atención Farmacéutica a pacientes con VIH/SIDA, en respuesta a las primeras etapas de los Tratamientos Antirretrovirales de Alta Eficacia, cuya complejidad posológica y cuyos efectos adversos —inmediatos y a largo plazo— constituían barreras para la adherencia a los mismos, con el consecuente riesgo de fallo terapéutico. Esta área fue la primera en crearse en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y

una de las primeras del país. Además de la actividad asistencial, desde esta área se dictó durante ocho años consecutivos el "Curso de Atención Farmacéutica a los pacientes con VIH/SIDA", con el objetivo de capacitar a las y los farmacéuticos involucrados en esta problemática.

A partir del año 2014 se creó el área de Reconstitución de Citostáticos, que permitió centralizar todas las preparaciones que involucran estas drogas en un área restringida y con recurso humano profesional y técnico altamente calificado, lo que permite asegurar la calidad del producto final en las condiciones de seguridad requeridas.

En 1886, el Hospital dio un importante paso en la prevención de infecciones con la instalación de un horno de esterilización. A lo largo del tiempo se incorporaron las primeras autoclaves por calor húmedo, tecnología descubierta por Charles Chamberland en 1879. La evolución —desde el uso de "papel de diario" para envolver el material a procesar hasta el envoltorio en papel *pouch* actual— ha sido continua: los procesos que se llevan a cabo en la actualidad en nuestro Servicio incluyen tecnología de última generación, como la esterilización por peróxido de hidrógeno evaporado, que asegura un entorno más seguro, y máquinas lavadoras en el Quirófano Central que optimizan el proceso desde su inicio.

Figura 21.2: Sala de esterilización del Hospital, 1910. *Fuente: Dirección General de la Administración Sanitaria y Asistencia Pública, Memorias, Intendencia Municipal de la Capital, 1910.*

El Servicio de Farmacia de nuestro Hospital ha seguido el ritmo de la evolución de la Farmacia Hospitalaria en la Argentina, liderando iniciativas innovadoras que han mejorado significativamente la atención farmacéutica y la calidad de vida de los pacientes.[37] Su compromiso con la formación continua y la adaptación a las necesidades clínicas emergentes refuerza su papel como un pilar fundamental en el equipo de salud del Hospital. Con un enfoque en la atención integral y la seguridad del paciente, el Servicio de Farmacia está preparado para enfrentar futuros desafíos.

Nuestro Servicio cuenta con un Museo, por lo que invitamos a toda la comunidad hospita-

laria a acercarse a conocerlo: allí encontrarán herramientas y dispositivos que se utilizaban en la elaboración de algunas formulaciones, así como antiguo material de lectura.

Agradecimiento: A los Dres. María Inés, Juan Ramos, Stella Trosman y Haydée Pérez, por su colaboración irremplazable en la elaboración de este capítulo, y a las y los farmacéuticos y al personal idóneo, técnico, administrativo y de maestranza que han contribuido con su servicio y trabajo a la construcción de este Servicio.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 22

Gastroenterología

Como antecedentes de la formación del Servicio de Gastroenterología pueden señalarse dos ejemplos preliminares del siglo XX. El primero fue la presencia del Dr. Carlos Bonorino Udaondo en nuestras salas. Graduado de médico en 1908 con una tesis titulada "Contribución al estudio de los pseudo-reumatismos infecciosos", tuvo entre sus maestros a Roberto Wernicke y Gregorio Aráoz Alfaro, y viajó a Europa, donde se vinculó con especialistas de París y Berlín como Hayem, Mathieu, Roux y Boas. De regreso se dedicó de lleno a la docencia, siendo nombrado sucesivamente Asistente, Jefe de Trabajos Prácticos y Jefe de Clínica de la Primera Cátedra de Semiología; en 1913 fue designado profesor suplente de Semiología y Clínica Propedéutica, cátedra de la que fue titular desde 1928 hasta 1935. En 1929, la Sala XII de Semiología estaba a su cargo, e incluía además el Instituto de Gastroenterología creado por el Prof. Rafael Bullrich. En 1931 fue Decano de la Facultad de Medicina de la UBA, y en 1941 fue designado Profesor Honorario de esa casa de altos estudios.

Figura 22.1: Dr. Carlos Bonorino Udaondo. *Fuente: Galería de Presidentes de la Asociación Médica Argentina.*

El segundo hecho significativo fue la presencia del Prof. Delfor del Valle (h), Director Interino del Hospital y, a la vez, Jefe de la Sala XI de Clínica Quirúrgica y del Instituto de Gastroenterología, Sección Quirúrgica.

El cierre del Hospital Rawson en 1978 por la dictadura militar provocó el traslado de sus profesionales a otros establecimientos de salud de la Ciudad de Buenos Aires; nuestro Hospital, que contaba ya con un plantel médico de elevado prestigio, recibió entre otros al Dr. Lucio Sanguinetti, por entonces Jefe de División de Clínica Médica. Años antes de ese cierre, el Dr. Juan Carlos Baccaro pertenecía al Departamento de Medicina de nuestro

Hospital, y la Gastroenterología estaba representada por médicos clínicos y de nutrición en los consultorios externos. Fue decisión del Dr. Sanguinetti orientar y entusiasmar al Dr. Baccaro para que se capacitara e incursionara en las prácticas endoscópicas digestivas; éste se convertiría en el verdadero gestor de la Unidad de Gastroenterología y uno de los precursores de la endoscopía digestiva en la Argentina, lo que explica la gran cantidad de profesionales formados en estas prácticas en nuestro Hospital. En la década de 1970, la endoscopía digestiva conformaba un grupo de trabajo dentro del Departamento de Medicina.

Figura 22.2: Prof. Delfor del Valle (h). *Fuente: Biblioteca de la Facultad de Medicina, UBA.*

Ante el cierre del Hospital Rawson se incorporaron a nuestro Hospital médicos de reconocida trayectoria, como el Dr. Aldo De Paula, convocado en 1978 por el Dr. Baccaro para asumir la Jefatura de la Unidad de Gastroenterología. Este último no dudó en proponerlo para el cargo, expresando que "hay mucho que aprender en esta especialidad y nada será mejor que tener de maestro al Dr. Aldo De Paula para lograrlo". De Paula fue un ejemplo de dedicación a sus pacientes y al estudio de la especialidad, además de un ser humano inolvidable para quienes tuvieron el honor de conocerlo. Así nació la Unidad de Gastroenterología. La evolución de la medicina, y en particular de la endoscopía digestiva, motivó el crecimiento del área y la necesidad de contar con mayor recurso humano, por lo que el Dr. Baccaro convocó con fines formativos y asistenciales a los Dres. Blas Alberto González y Carlos Alberto Cúpula, provenientes de la guardia médica y del servicio de nutrición respectivamente, quienes se abocaron a las prácticas endoscópicas, dando origen a la sección de endoscopía digestiva.

A partir de entonces se sumaron a la Unidad excelentes profesionales, como el Prof. Dr. Roberto Zeilicoff en hepatología —a quien se debe, por su conocimiento y enorme capacidad docente, la formación de los médicos hepatólogos del Hospital— y el Dr. Jaime Katz, dedicado a la patología esofagogastroduodenal con inagotable proyección y permanente actualización en la materia. La Unidad, ya conformada, tuvo intensa actividad docente: recibió alumnos de pregrado de la UBA y de la Universidad del Salvador, y formó gastroenterólogos en conjunto con la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE) y por medio de la concurrencia médica municipal. A partir de la década de 1980 formó médicos gastroenterólogos que, recién diez años más tarde, comenzaron a incorporarse al plantel estable de la Unidad iniciando su carrera hospitalaria.

Con la jubilación del Dr. De Paula en 1987, el Dr. Baccaro asumió la jefatura de la Unidad —durante su gestión se creó la Cátedra de Poli-endoscopía— y el Dr. Blas González la jefatura de la Sección de Endoscopía. En 1999, al jubilarse el Dr. Baccaro, asumió por

concurso como jefe de la Unidad el Dr. Blas A. González, y el Dr. Carlos A. Cúpula la jefatura de la Sección de Endoscopía; en esta etapa se consolidaron los roles asistencial clínico-endoscópico, docente-formativo y de investigación de la Unidad. Tras la jubilación del Dr. González, el Dr. Cúpula quedó a cargo de la Unidad, y con su posterior jubilación, el Dr. Eduardo José Marini asumió en 2010 por concurso la jefatura de la Unidad, mientras la Dra. Ana Lía Ghiraldo asumió en 2011, también por concurso, la jefatura de la Sección de Endoscopía. En 2012 se incorporó la residencia médica en Gastroenterología y la Unidad se convirtió en Sede Académica de la UBA, alcanzando así un nuevo grado de relevancia dentro de la especialidad. En 2023, con la jubilación de la Dra. Ghiraldo, asumió por concurso el Dr. Fabián Precetti como Jefe de la Sección de Endoscopía.

En la actualidad, nos enorgullece saber que el recurso humano de la Unidad está constituido por discípulos directos de los médicos mencionados, referentes indiscutibles de la Gastroenterología argentina.

Agradecimiento: Los Dres. Eduardo Marini, Fabián Precetti, Ana Lía Ghiraldo y Carlos Cúpula han colaborado en la redacción del capítulo, nuestro agradecimiento.

BORRADOR – NO DEFINITIVO

Capítulo 23

Geriatría

En 1915 la Municipalidad de Buenos Aires adquirió un parque arbolado de 44 hectáreas en Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires. En 1927 se inauguró allí la Colonia de Ancianos de Ituzaingó, que llegaría a albergar a más de 1.400 pacientes. Hacia 1963, por gestión de Idélico Gelpi, se crearon partidas de médicos especialistas en geriatría para la Municipalidad de Buenos Aires y se activó el Hospital de Geriatría General Martín Rodríguez, ubicado en el predio que antes ocupaba la Colonia de Ancianos.

Figura 23.1: Vista panorámica de la Colonia para Ancianos General Martín Rodríguez.

Figura 23.2: Ángel Papeschi en su asunción como presidente de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología (1971-1972).

Durante la dictadura, por decisión del intendente Osvaldo Cacciatore, el Hospital General Martín Rodríguez —que dependía de su administración— fue desactivado compulsivamente en 1977, con el consecuente traslado de los médicos nombrados a distintos destinos. Ángel Papeschi, quien en ese momento ejercía la Dirección del Hospital Martín Rodríguez y sería luego jefe de la Unidad de Geriatría de nuestro Hospital, fue trasladado con parte de su equipo al Hospital General de Agudos Juan A. Fernández. Su trayectoria dentro de la geriatría fue relevante: fue elegido Presidente de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología para el período 1971-1972, y en la década de 1970 fue convocado para crear un Plan Gerontológico para el Municipio de la Ciudad de Buenos Aires, adaptando el modelo inglés de Asistencia Geriátrica a nuestra idiosincrasia y proponiendo la creación de un servicio de Geriatría en cada hospital municipal, en vista del cambio demográfico que se estaba iniciando. La implementación

de dichas unidades resultó muy dificultosa, e incluso algunas no pudieron activarse. En 1976 Papeschi presentó el Plan Gerontológico Municipal, que se activó durante 1978, y en 1979, junto a su equipo, creó en nuestro Hospital un servicio con un plan racional de intervenciones y un posterior seguimiento domiciliario de todos los pacientes adultos mayores que acudían al establecimiento.

Dicho servicio contaba en su creación con un pabellón arquitectónicamente adecuado para la atención de adultos mayores internados (17 camas) y un consultorio externo para pacientes ambulatorios; su lugar de internación fue desafectado de esa función y, en 1989, pasó a ser ocupado por el Servicio de Pediatría. Una de las particularidades del servicio consistía en que, además de la asistencia, brindaba formación e investigación en geriatría: en su seno se realizó el primer curso de asistentes domiciliarios para adultos mayores, y todos los años se dictaba un curso multidisciplinario a través del cual se realizaba un intercambio con la comunidad, conformándose un equipo de trabajo interdisciplinario que incluía médicos geriatras, enfermeras, cuidadoras, asistentes sociales, psicólogos, kinesiólogos y nutricionistas. Este modelo fue pionero y ejemplo seguido en el mundo por la atención que brindaba a los pacientes adultos mayores en hospitales de agudos, y formó gran cantidad de recursos gerontológicos. Con el transcurrir del tiempo, la unidad creada por Papeschi pasó a ser solo de atención ambulatoria e interconsultas.

En 2003, con el Dr. Hadid a la cabeza, se comenzó a trabajar en un proyecto articulado con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y la Universidad Maimónides, armando equipos para formar como promotores de salud a los pacientes y vecinos del área programática. La residencia de Geriatría comenzó en 2006 en la Unidad y continúa hasta la actualidad; además, la Unidad es sede de la Carrera de Médico Especialista en Geriatría y de la Diplomatura en Gerontología de la UBA, y desarrolla geriatría transversal (oncogeriatría, hematogeriatría, ortogeriatría, entre otras), atención ambulatoria y talleres de calidad de vida. Actualmente la jefa de la Unidad es la Dra. Maya Sinjovich.

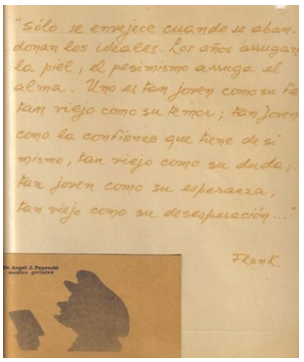


Figura 23.3: Poster que se encontraba frente al escritorio del Dr. Ángel Papeschi.

Capítulo 24

Gestión Administrativa

Cuando se reanudaron en 1881 las obras del Hospital San Roque, luego de seis años de interrupción, en la parte superior del edificio se instaló la Asistencia Pública, antecedente directo de la autoridad sanitaria y del actual Ministerio de Salud. En ese contexto, el Dr. José María Ramos Mejía fue nombrado Director de Salud Pública.

Al inaugurarse el Hospital San Roque, en 1883, la planta baja de la entrada albergaba la sala de Guardia, la Administración y la Dirección del hospital. No se conoce con exactitud la fecha en que la Administración y la Dirección volvieron a funcionar en el primer piso, pero desde entonces la organización administrativa se mantuvo como núcleo del gobierno y la gestión de la institución.

A lo largo de más de 150 años, miles de personas trabajaron en la administración del hospital, sosteniendo día a día su funcionamiento. Ante la ausencia de registros completos de todo ese personal, este capítulo presenta la estructura actual de la gestión administrativa como forma de reconocimiento y homenaje al conjunto de trabajadores y trabajadoras que han hecho posible la vida cotidiana del Hospital Ramos Mejía.

En el organigrama del Hospital (2024), la gestión administrativa se organiza en torno a diversas áreas y niveles. El equipo directivo y de conducción médica está integrado por la Dirección Médica, la Subdirección Médica, la Dirección General Adjunta y la Dirección Técnica. Desde allí se articulan las decisiones clínicas y organizativas que orientan el funcionamiento del hospital.

La Gerencia Administrativa, Económica y Financiera reúne la coordinación de la administración general, los recursos humanos, los servicios generales y la gestión contable y financiera. Dentro de ella, la Subgerencia de Recursos Humanos y Servicios Generales tiene a su cargo el Departamento de Servicios Generales, la División Camilleros, la División Recursos Físicos y la Sección Ropería y Lavandería, incluyendo la librería y los servicios de impresión y fotocopiado que históricamente abastecieron al hospital.

La División Recursos Físicos concentra las tareas de mantenimiento, depósitos y talleres,

así como la supervisión de las obras de infraestructura. En articulación con empresas especializadas en obras complejas, esta área garantiza el cuidado de las instalaciones, la reparación cotidiana y la seguridad edilicia necesaria para el trabajo asistencial.

La Subgerencia de Gestión Administrativa General comprende el Departamento Contable y Financiero. Allí se integran la División Recupero de Gastos y las secciones de Compras y Contrataciones, Contable, Patrimonio y Tesorería, que administran el flujo económico, la adquisición de insumos, el registro patrimonial y el manejo de fondos, asegurando el soporte material de todas las actividades del hospital.

El Departamento de Atención y Administración de Servicios de Salud organiza la administración de la atención médica y el vínculo con pacientes y servicios. Se estructura en tres divisiones: Admisión y Egresos, Mesón de Turnos y Atención, y Legales y Despacho. La División Admisión y Egresos articula las secciones de Estadística y Guardia, encargadas del registro y análisis de datos y de la gestión administrativa de los ingresos.

La División Mesón de Turnos y Atención coordina las secciones de Coordinación de Turnos y Servicios de Salud y Consultorios Externos. Desde allí se ordenan las agendas, la asignación de turnos y la atención administrativa de los servicios ambulatorios, garantizando el acceso de la comunidad a las distintas especialidades del hospital.

La División Legales y Despacho gestiona la documentación administrativa, los circuitos de expedientes y las cuestiones legales vinculadas a la actividad hospitalaria, asegurando el cumplimiento de normas y procedimientos. Completando el esquema, la Sección de Soporte y Sistemas se ocupa de los sistemas informáticos y del soporte tecnológico de la gestión, integrando la historia clínica electrónica, las bases de datos y las herramientas de administración digital.

La División Recursos Humanos, por su parte, coordina la administración de personal y los concursos, sosteniendo los procesos de ingreso, carrera, capacitación y organización de los equipos de trabajo. La División de Arancelamiento y Coordinación depende directamente de la Dirección Médica y se ocupa del arancelamiento de prestaciones, la relación con los sistemas de cobertura y la coordinación administrativa de esos procesos.

La complejidad de esta estructura refleja la magnitud del trabajo que supone sostener un hospital general de agudos de referencia en la salud pública porteña. Cada área, departamento, división y sección participa de manera silenciosa y constante en la organización de camas, insumos, nóminas, turnos, historias clínicas, servicios y obras, haciendo posible que la tarea asistencial se desarrolle con continuidad.

Capítulo 25

Ginecología y Obstetricia

En el Hospital San Roque, en 1892, se inauguró el Servicio de Ginecología, hito importante ya que hasta entonces el hospital solo admitía internaciones para hombres. Poco después se inauguró la Maternidad, con entrada independiente ubicada en la calle Venezuela. Este avance, con la creación de los primeros pabellones específicos, representó un compromiso decidido con la salud de las mujeres y el tratamiento de enfermedades ginecológicas que hasta entonces no contaban con atención especializada. El establecimiento de estos pabellones no solo proporcionó un espacio dedicado y equipado para la atención ginecológica y obstétrica, sino que también sentó las bases para la formación de profesionales especializados en el área; los médicos y enfermeras que trabajaron allí fueron pioneros en el desarrollo de nuevas técnicas y tratamientos que mejorarían significativamente la salud de las mujeres.

La historia de los primeros años de la ginecología en nuestro país, y en particular en nuestro Hospital, debe comenzar por la Dra. Cecilia Grierson Duffy (1859–1934), primera médica de la Argentina, cuya figura se reseña también en el capítulo de Enfermería. Realizó sus prácticas como Practicante Interna del Hospital Escuela Buenos Aires, dirigida por Juan B. Justo, y en 1888 fue nombrada practicante menor del Hospital de Mujeres —hoy Rivadavia—; su tesis de graduación se tituló "Histero-ovariotomías ejecutadas en el Hospital de Mujeres desde 1883 a 1889". Ya en el Hospital San Roque se dedicó a la ginecología y la obstetricia, pero no a la cirugía —especialidad que le fue negada por su condición de mujer, pese a haber sido la primera en obtener el título habilitante para ejercerla—. En 1891 fue miembro fundadora de la Asociación Médica Argentina; en 1892 fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, que luego se fusionaría con la Cruz Roja Argentina; y en 1901 creó la Asociación Obstétrica Nacional y la Revista Obstétrica, concebida para ofrecer a las parteras argentinas un enfoque científico y médico de una profesión que por entonces ejercían las "matronas".

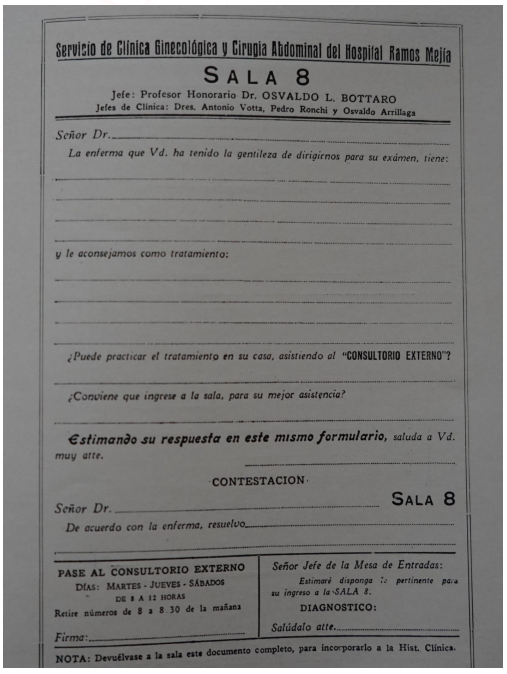
Figura 25.1: La Dra. Cecilia Grierson (sentada) durante una clase. *Fuente: Archivo General de la Nación, 1909.*

Figura 25.2: Prof. Osvaldo L. Bottaro.

Otros médicos ilustres en la historia de nuestro Servicio incluyen al Prof. Enrique Zárate, nombrado en 1929 Jefe Titular de la Sala V (Obstetricia) y reconocido por la técnica quirúrgica de sinfisiotomía de Zárate; tuvo a su cargo la Maternidad "Eliseo Cantón", que contaba incluso con un Jefe de Museo (Dr. Fernando De Luca) en esos años, cuyo material pasó luego al Museo de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la UBA. El Prof. Osvaldo Bottaro, jefe de la Sala VIII de Clínica Ginecológica y reconocido profesor de historia de la medicina y de la ginecología, fue homenajeado en 1935 como profesor honorario de Ginecología por la Facultad de Medicina de la UBA; actualmente se otorgan premios en su nombre a trabajos de investigación, y en el aula de Ginecología del Hospital existe una biblioteca que lleva su nombre, donde se conservan preparados realizados en la institución con piezas quirúrgicas de pacientes operadas desde la apertura de la sala de mujeres.

Figura 25.3: Maternidad. Clínica Obstétrica y Ginecológica. Director: Prof. Enrique Zárate, 1923.

La historia de la ginecología, marcada por avances científicos y tecnológicos, ha pasado de ser una práctica rudimentaria a convertirse en una especialidad que se perfecciona día a día. La introducción de la laparoscopia y la histeroscopia transformó radicalmente la atención ginecológica, permitiendo intervenciones más precisas y menos invasivas, con menor tiempo de hospitalización, menor dolor postoperatorio y recuperación más rápida. A las técnicas moleculares, como el test de HPV utilizado hoy en nuestro Hospital para el *screening* de cáncer de cuello uterino, se suman los avances en el tratamiento de la infertilidad, que han incrementado significativamente las tasas de éxito y ofrecido nuevas oportunidades a las parejas que buscan concebir. Conocer esta evolución permite valorar los esfuerzos de los pioneros del campo y destacar la importancia de la educación continua y la investigación en la reducción de la morbimortalidad asociada a las enfermedades ginecológicas.



Servicio de Clínica Ginecológica y Cirugía Abdominal del Hospital Ramos Mejía

SALA 8

Jefe: Profesor Honorario Dr. OSVALDO L. BOTTARO
Jefes de Clínica: Dres. Antonio Votta, Pedro Ronchi y Osvaldo Arrillaga

Señor Dr.

La enferma que Vd. ha tenido la gentileza de dirigirnos para su exámen, tiene:

y le aconsejamos como tratamiento:

¿Puede practicar el tratamiento en su casa, asistiendo al "CONSULTORIO EXTERNO"?

¿Conviene que ingrese a la sala, para su mejor asistencia?

Estimando su respuesta en este mismo formulario, saluda a Vd. muy atte.

CONTESTACION

Señor Dr. SALA 8

De acuerdo con la enferma, resuelvo

PASE AL CONSULTORIO EXTERNO
DIAS: MARTES - JUEVES - SABADOS
DE 8 A 12 HORAS
Retire números de 8 a 8 30 de la mañana

Firma:

Señor Jefe de la Mesa de Entradas:
Estimaré disponga lo pertinente para su ingreso a la SALA 8.

DIAGNOSTICO:

Salúdalo atte.

NOTA: Devuélvase a la sala este documento completo, para incorporarlo a la Hist. Clínica.

Figura 25.4: Nota de interconsulta de la Sala 8 de Clínica Ginecológica y Cirugía Abdominal del Hospital Ramos Mejía.

La Maternidad "Dr. Eliseo Cantón"

La construcción de la Maternidad data aproximadamente de los primeros años de la década de 1890; fue diseñada por arquitectos italianos, con materiales traídos desde Europa y de la demolición de edificios para la construcción de la Av. de Mayo. Se ubicaba sobre la calle Venezuela, con salida a ella, y por su parte posterior se comunicaba con el Hospital; su presupuesto y personal dependían de la Facultad de Medicina de la UBA. Se inauguró en 1892. Por Venezuela se accedía a la planta baja, donde funcionaban las oficinas administrativas, secretarías y de seis a ocho consultorios externos para pacientes ambulatorias, además de un torno para depositar a los niños "expósitos", consultorios de neonatología del recién nacido sano y una oficina del Registro Civil; había también una sala de unas 20 camas para mujeres próximas al parto, a cargo de un Jefe de División, un Jefe de Unidad y residentes. La Dra. Cecilia Grierson, junto al Dr. Alfredo Lagarde, realizó la primera cesárea exitosa en un hospital público en septiembre de 1892. La Maternidad contaba con consultorios propios de colposcopía, a cargo del Dr. Ricardo Güello, y de patología mamaria de la embarazada; un subsuelo con 15 camas para mujeres solteras embarazadas; y, en el primer piso, un Aula Magna semicircular con capacidad para 200 personas, oficinas de Enfermería y una sala de patologías obstétricas de unas 18 camas. Por la entrada desde el Hospital se accedía a dos salas de prepartos de dos camas cada una, con guardia diaria de obstetras, obstétricas, residentes, anestesista, instrumentadoras y enfermeras, realizando un promedio de cinco partos por día. Según la tradición del Hospital, entre los nacidos en la Maternidad se menciona a la poeta Alfonsina Storni, el 29 de mayo de 1892. El quirófano estaba vidriado por sus cuatro costados, con gradas laterales para observar las maniobras del equipo.

Figura 25.5: Frente de la Maternidad "Dr. Eliseo Cantón", con entrada independiente por la calle Venezuela.

Un piso intermedio albergaba el Museo, a cargo en la década de 1930 del Dr. Fernando De Luca y, en la de 1960, de los Dres. Biaggi y Viale. En el tercer piso se encontraban

las habitaciones de descanso del personal de guardia, además de un laboratorio propio de bioquímica, uno de anatomía patológica —donde se destacó el Dr. Rabow—, un bioterio y la biblioteca, todos dependientes de la Facultad de Medicina; la propia Maternidad tenía además su revista de investigación y comunicación. En total contaba con aproximadamente 54 camas, lo que la constituía en la mayor maternidad de los hospitales públicos del GCBA. Fueron Jefes de la Maternidad, luego de Eliseo Cantón, los Dres. Enrique Zárate, Roberto Pintos, Antonio Votta, Carlos Viggiano y, por último, el Dr. Carranza, jefe al momento de su demolición por orden del Ing. Cacciatore durante la dictadura militar, en 1978.

Figura 25.6: Sala de partos de la Maternidad, 1910.

La Residencia de Obstetricia se abrió en 1960, siendo nuestro Hospital el primero en tenerla dentro de la Municipalidad de Buenos Aires; el Dr. Roberto Pintos fue uno de los primeros residentes, y el Dr. Armando Dunaievsky —años después Jefe de División de Obstetricia— la comenzó en 1965, junto a la Dra. Nilda Zunino como destacada Instructora de Residentes. Se dictaban también, de manera original y pionera, "cursos de partos sin temor" a cargo de la Sra. Páez y Mattos, entre otras; en la década de 1960 los partos se realizaban con cloroformo inhalado, oxitocina, meperidina y dilatador del cuello uterino. La Facultad de Medicina de la UBA fue el motor y marco de la Maternidad: allí funcionó la Primera Cátedra de Obstetricia, a cargo del Prof. Dr. Roberto Martín Pinto, amigo del Dr. Leloir, con investigaciones sobre la fisiología del 17-β-estradiol publicadas en revistas internacionales y en consorcio con la Escuela Obstétrica de Montevideo. Por el Servicio pasaron también la actual Vicedecana de la Facultad de Medicina, Dra. Claudia Negri, y los Dres. Raúl Vinograd, Carlos Viggiano, Antonio Votta, Liliana Lisardi y Armando Dunaievsky.

Al demolerse la Maternidad se creó, en el segundo piso del pabellón quirúrgico (lado sur), una nueva área de Maternidad de 20 camas, con dos de preparto y tres baños. El primer Jefe del Departamento Materno-Infantil, desde 1978, fue el Dr. Horacio Giménez, siendo Jefe de División el Dr. Armando Dunaievsky desde ese año hasta 2020, reemplazado por el Dr. Alejandro Hakim y, a su fallecimiento, por el Dr. Muñoz Álvarez. La Neonatología fue presidida por el Dr. Carlos Mercau (padre), luego por el Dr. Schegel y más tarde por Carlos Mercau (hijo).

Agradecimiento: Las Dras. Stella Maris Raya y Natali R. Barrero han redactado lo referente a Ginecología; al Dr. Armando Dunaievsky por habernos brindado toda la información acerca de la Maternidad "Dr. Eliseo Cantón"; nuestro agradecimiento a todos ellos.

Capítulo 26

Hematología

In memoriam: Dra. Beatriz Iparraguirre.

El Dr. Luis Agote obtuvo su título de médico en 1893 y pasó por diversas instituciones, entre ellas nuestro Hospital San Roque, el Hospital de Clínicas y el Hospital Rivadavia; quizás ese fue el primer paso de una figura fundamental para la hematología mundial y argentina vinculada a nuestro Hospital.

En la década de 1950 se produjo un considerable progreso de la hematología en la Argentina, impulsado por la actividad del "Instituto Municipal de Hematología", originalmente la Sala 18 de Enfermedades de la Sangre de nuestro Hospital, bajo la dirección del Dr. Luis Demarval. Se conformó así una sala para la atención exclusiva de pacientes hematológicos, con 50 camas (25 para hombres y 25 para mujeres) y dos habitaciones de atención diferencial en planta baja, a cargo de los Dres. Arturo Musso, C. Taquini, A. Zurutuza, H. Ferrer y C. Badano. En el subsuelo se realizaban los exámenes citomorfológicos de sangre periférica, punción medular, improntas y punciones ganglionares, a cargo de los Dres. Emilio Lida, León Braier, Gregorio Bomchil, Guillermo Hidalgo, Alberto Santoro y Alfredo Pavlovsky —este último, autor de una tesis doctoral sobre material ganglionar galardonada con el Premio Pascual Palma—. El Instituto contaba además con sectores de Radiología, Radioterapia, Gastroenterología y un laboratorio de hemogramas.

Con el retiro del Dr. Demarval, la jefatura fue ocupada por el Dr. Musso, quien junto al Dr. Gregorio Bomchil emprendió la transformación del Servicio para alinearlo con los progresos de los centros internacionales de la especialidad. Bomchil —presidente de la Sociedad Argentina de Hematología en 1973— puso en marcha, con la colaboración de la Srta. Ángela Utsumi, el primer centro de derivación del país para exanguinotransfusión por enfermedad hemolítica del recién nacido, luego continuado por el Dr. José Teruya. El Labo-

Figura 26.1: Dr. Gregorio Bomchil.

ratorio de Coagulación fue organizado por los Dres. Marcos Kleimans y A. Derechin, con la incorporación posterior del Dr. Raúl Barraza y la Sra. Magdalena Sosa, dedicado al control de tratamientos anticoagulantes y al diagnóstico de coagulopatías. El consultorio de Leucemias Agudas estuvo a cargo de los Dres. G. Hidalgo, Carlos Bernadou y A. Santoro, con la posterior incorporación de la Dra. Marión Epinger; el sector de Inmunohematología, a cargo de los Dres. José Teruya, Jaime Weingast y Juan Turensky; y el de Mielomas y proteínas, con los Dres. Luis Gernek, Cecilio Jait y Raquel Osatinsky, y más tarde el Dr. J. Becherini. El Laboratorio de Hemocitología estuvo luego a cargo de la Dra. Regina Kohan, quien pasó por concurso a la jefatura de Oncohematología del Hospital Pedro Elizalde.

A fines de 1958, con la asistencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica, se instaló un laboratorio de radioisótopos a cargo del Dr. J. Carmena, dedicado inicialmente al estudio de policitemias; participaron los Dres. Raúl Segade, Mario Aggio, Fernando Cavagnaro, Adelma Segovia, M. E. Bernadou y la técnica María Teresa Ertola. El consultorio de enfermedades linfoproliferativas estuvo a cargo de los Dres. Marcos Morguenfeld y Guillermo Hidalgo, y luego de Morguenfeld, Nilda Somoza y Juan Magnasco. El Dr. Musso falleció el 22 de diciembre de 1958, y el Dr. Bomchil asumió la jefatura en forma interina, efectivizada en 1960; en 1959 comenzó la construcción de un primer piso en la parte posterior del edificio, con aula, biblioteca y laboratorios. En 1963 se organizó el laboratorio de esferocitosis hereditarias, a cargo del Dr. Osvaldo Giossefi, y el Laboratorio de Citoquímica fue dirigido por el Dr. Daniel Catovsky, quien luego se perfeccionó en Londres y realizó allí una destacada carrera de investigación internacional; su colaboradora, la Dra. Beatriz Sforza, asumió por concurso en 1984 la Jefatura de Hematología del Hospital Argerich.

Figura 26.2: Dra. Beatriz Iparraguirre (con anteojos) en el Servicio.

En 1960, la Dra. Beatriz Iparraguirre, de regreso de su residencia en Estados Unidos, se especializó en talasemias y hemoglobinopatías, organizando junto a la Sra. Angélica Landoni un laboratorio que recibió numerosos becarios de distintas provincias y produjo abundantes comunicaciones científicas. En 1973 publicó en *Acta Hematológica* el descubrimiento de una nueva hemoglobina inestable, la Hemoglobina Buenos Aires, hallada en una familia que estudiaba. En 1978 pasó a ser Jefa de Hematología del Hospital Francés, y en 1986 fue la primera mujer Presidenta de la Sociedad Argentina de Hematología; a comienzos de 1978 estuvo detenida en el contexto de la dictadura, y su reconocimiento internacional —entre otros, gracias a la ayuda del Dr. Catovsky desde Inglaterra— resultó decisivo para salvar su vida.

El Laboratorio de Hemostasia, a cargo del Dr. Kleimans con la colaboración del Dr. Barraza y las bioquímicas Dora Zdrowjesky y Lucía Kordich —esta última socia fundadora del

Grupo Cooperativo Latinoamericano y del Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis—, comprendía los sectores de plaquetas, hemofilia y control de anticoagulados. El laboratorio de Citogenética estuvo a cargo de las Dras. Susana Mide e Irma Otero. El Dr. Bomchil se retiró en julio de 1976 y fue reemplazado por el Dr. Marcos Morguenfeld hasta su fallecimiento; ocupó luego la jefatura en forma interina la Dra. María Elena Bernadou, hasta que por concurso asumió el Dr. Alfredo Macchi, proveniente del Hospital Rawson. A su fallecimiento en 1977 asumió el Dr. Guillermo Hidalgo, Jefe de División desde 1980 hasta 1990. En 1978 el Instituto pasó a funcionar en la ex sala de Alergia, donde continúa en la actualidad.

El Instituto se destacó también por su intensa actividad docente: en 1962 contó por primera vez con dos residentes seleccionados por concurso y subvencionados por la Fundación de Investigaciones Hematológicas, los Dres. Luis Garnek y Juan Martín; en 1964 la Secretaría de Salud Pública aprobó las residencias en hematología por concurso. Funcionó como Unidad Docente adscripta de la UBA y de la Universidad del Salvador, y dictó numerosos cursos, entre ellos el Curso Municipal de Técnicos en Hematología, aún activo. La formación de generaciones de residentes, becarios y rotantes —muchos de los cuales hoy ocupan cargos relevantes en el país y en el exterior— le valió a la Sala 18 el apodo de "Sala Semillero de la Hematología Argentina", título que conserva hasta hoy. La Fundación de Investigaciones Hematológicas, integrada por amigos y familiares de pacientes del Dr. Bomchil y presidida por la Sra. Fanny Jasnis junto a la Sra. Ester Sadosky, prestó un significativo apoyo económico al Instituto, al igual que la Fundación ANMAT mediante becas para profesionales.

Las salas de internación de la especialidad siguen siendo, hasta hoy, las únicas dentro de la medicina pública de la Ciudad de Buenos Aires para pacientes adultos. La visión de futuro del Dr. Bomchil le permitió comprender que aquellas 50 camas pronto resultarían insuficientes; en pocos años el Instituto se transformó en centro referente de diagnóstico e internación del país y en lugar de formación de hematólogos de excelencia, perdurando el reconocimiento de sus discípulos hacia quien consideran el gran maestro y artífice indiscutible de la institución. Es indudable su contribución a la historia de la hematología argentina y sudamericana, incluido el breve y frustrado intento de constituirse en el primer centro público de trasplante de progenitores hematopoyéticos para pacientes adultos. Luchando contra numerosos inconvenientes, la mítica Sala 18 persiste y resiste, atendiendo a pacientes derivados no solo de los hospitales públicos de la ciudad, sino de otros puntos del país y de países vecinos.

Agradecimiento: Las Dras. Irene Rey y Miriam Arias han colaborado en la redacción del capítulo, nuestro agradecimiento.

Capítulo 27

Hemoterapia

La medicina transfusional actual es una especialidad médica que exige conocimientos de epidemiología, microbiología, biología molecular, inmunología, histocompatibilidad e inmunogenética y estadística, entre otros, para gestionar las Unidades de Transfusión y los Bancos de Sangre intrahospitalarios, donde se reciben, estudian y notifican las donaciones, y comprende además la terapia celular, de tejidos y la inmunoterapia. Mediante tecnología de trazabilidad y hemovigilancia, su misión es infundir el componente correcto al receptor correcto y prevenir la recurrencia de reacciones transfusionales adversas. A comienzos del siglo XX se practicaban transfusiones directas, conectando quirúrgicamente la arteria del donante con la vena del receptor; en 1901 el Dr. Karl Landsteiner descubrió los distintos tipos de sangre y la incompatibilidad de las transfusiones entre grupos sanguíneos, describiendo el sistema ABO, descubrimiento por el cual recibió el Premio Nobel en 1930.

El 9 de noviembre de 1914, el Dr. Luis Agote —médico argentino formado en la UBA, recibido en 1893, que se desempeñó en nuestro Hospital (entonces San Roque), en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Rivadavia— introdujo, tras estudios preliminares in vitro y en animales, el uso del citrato como medio de conservación y anticoagulación, y realizó junto a su laboratorista Lucio Imaz la primera transfusión exitosa entre humanos con sangre citratada. Vale destacar el vínculo de Agote con nuestra institución: el paciente de aquella histórica transfusión provenía del Hospital Ramos Mejía y fue derivado luego al Hospital Rawson, en cuyo Instituto Modelo de Clínica Médica se concretó el procedimiento. La operación fue un éxito y el paciente se restableció en pocos días; en su recuerdo, cada 9 de noviembre se celebra en el país el Día del Donante Voluntario de Sangre. A partir de allí, en el mundo y en la Argentina, se hizo evidente la necesidad de contar con personal capacitado para las transfusiones y con la logística de los bancos de sangre, en paralelo a los avances de la inmunohematología, las serologías y los hemoderivados.

Figura 27.1: Primera transfusión de sangre citratada, 9 de noviembre de 1914.

El tratamiento de las hemorragias se realizaba mediante transfusiones de sangre fresca, y la Sección de Hemoterapia de la Academia Nacional de Medicina contaba con un importante banco de sangre; en la década de 1950 comenzaron a crearse los primeros Servicios de Hemoterapia hospitalarios del país. En 1950 el Hospital Bernardino Rivadavia fue designado sede de la Comisión Directiva de la Asociación de Hematología y Hemoterapia, bajo la presidencia del Dr. Miguel Ángel Etcheverry, y en 1972 el Dr. Juan Marletta creó la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, naciendo la profesión de técnico en hemoterapia. El Servicio de Hemoterapia de nuestro Hospital se creó probablemente en la década de 1950; el Dr. Ceancio fue el primer Jefe de Servicio del que se tiene referencia, sucedido por el Dr. Juan Víctor Morando, recordado por su gestión impecable y calidez humana. El servicio alcanzó reconocimiento entre sus pares de la Ciudad de Buenos Aires por su experiencia en la identificación de anticuerpos en alosensibilización y en transfusiones de pacientes con hemoglobinopatías o anemias hemolíticas autoinmunes; a partir de la Ley de Chagas de 1980 se comenzó a realizar la serología de Chagas.

Con el tiempo, la práctica evolucionó de transfundir sangre entera a separar el plasma de los glóbulos rojos y, con las bolsas flexibles, a obtener concentrados plaquetarios por centrifugación. El servicio funcionaba antiguamente en el espacio hoy ocupado por la atención de pacientes pediátricos, con un promedio de cien donantes diarios; las Dras. Trilla y Cuiz se ocupaban del estudio de las enfermedades transmisibles por transfusión, y desde temprano se respetaron prácticas de seguridad del paciente, como la determinación obligatoria del grupo sanguíneo ABO al pie de cama. En 1983 comenzó a identificarse el VIH, estableciéndose su detección obligatoria en 1990; en 1986 se realizó el primer trasplante de médula ósea de la Argentina, y el servicio brindó soporte transfusional a los pacientes trasplantados de la División Hematología. En la década de 1990 se incorporó el primer separador celular del Hospital (Haemonetics V50 Plus), iniciando una etapa de capacitación en aféresis que continúa hasta el presente, incluyendo recambios plasmáticos terapéuticos y leucoaféresis para pacientes de oncohematología; durante la pandemia de

COVID-19, en 2021, la entonces jefa de Servicio, Dra. Inés Ferniot, condujo un protocolo de investigación con aféresis publicado en revistas internacionales. En 1999, la incorporación de la biología molecular permitió reducir el período de ventana en la detección de VHC, VIH y VHB; desde 2012 se cubren guardias dobles de técnicos y médicos las 24 horas en el área de urgencias transfusionales. El servicio cuenta hoy con equipos de quimioluminiscencia para el estudio de infecciones transmisibles por transfusión en los cerca de cinco mil donantes atendidos anualmente, así como con un sistema de gestión de la calidad, hoy a cargo de la Bioquímica Graciela Daleoso, que junto a la Dra. Inés Ferniot elaboró el manual de calidad y los procedimientos operativos estándar de la Unidad de Hemoterapia.

Agradecimiento: A la Dra. Alicia Endara por la redacción de este capítulo, nuestro reconocimiento.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 28

Infectología

Nuestro Hospital nació como Lazareto de San Roque, que sirvió también, pasadas las epidemias de cólera y fiebre amarilla, para alojar hacia fines del siglo XIX a los enfermos con tuberculosis. El Dr. Telémaco Susini, uno de los últimos Directores del Lazareto, realizó aportes valiosos en el campo de la incipiente infectología: dada la importancia de los estudios sanitarios para la ganadería del país, dedicó especial atención al carbunclo y su vacuna, a la tuberculosis bovina, a la perineumonía ovina y a las enfermedades del cerdo, asociándose a la labor de la Inspección Veterinaria mediante controles cruzados e intercambio de información entre especialistas.

Figura 28.1: Dr. Julio Méndez. *Fuente: Colección Biblioteca Central, Facultad de Ciencias Médicas.*

El Dr. Julio Méndez, antes de trabajar en nuestro Hospital, realizó aportes fundamentales al desarrollo de la infectología en el país. Recibido en 1884, viajó a Alemania y Francia, donde asistió al desarrollo de la bacteriología con Roberto Koch, de la anatomía patológica con Rudolf Virchow y trabajó en París con Louis Pasteur. Regresó a Buenos Aires en 1889 y se hizo cargo como médico Jefe de la Sala I del Hospital San Roque; entre 1891 y 1894, conservando ese cargo, ganó por concurso la Dirección del Laboratorio Bacteriológico de la Asistencia Pública de Buenos Aires, donde en 1894 preparó el primer suero antidiftérico argentino, de mayor acción antitóxica que los preparados por Emil von Behring en Berlín y por Roux en París. En 1895, junto al Dr. Julio Lemos, fundó el Instituto de Antitoxinas, donde estudiaron la vacuna contra el carbunclo; en 1897 anunció el descubrimiento de una vacuna anticarbuncosa original de uso veterinario. Vacante la Cátedra por el fallecimiento del Dr. González del Solar, fue nombrado el Dr. Enrique Revilla en 1902 —más tarde Director de nuestro Hospital— y, por renuncia de éste, el Dr. Méndez en 1903. Fue Director de nuestro Hospital entre 1901 y 1904, primer Presidente de la Sociedad Argentina de Patología Infecciosa y Epidemiología, Presidente

de la Asociación Médica Argentina entre 1912 y 1913, y falleció el 8 de agosto de 1947.

Desde los primeros casos de infección por el virus de inmunodeficiencia humana en 1982 en nuestro país, la aparición de infecciones oportunistas por agentes poco frecuentes —junto al desarrollo de nuevas formas de tratamiento inmunosupresor y de trasplantes de órganos— contribuyó a una creciente especialización para enfrentar la complejidad diagnóstica y terapéutica de los agentes emergentes. En 1983, un grupo de médicos fundó la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) para sistematizar conocimiento y normativas en torno a la especialidad naciente. La historia de la Infectología en nuestro Hospital comienza en el seno de la Residencia de Enfermedades Infecciosas de adultos del Hospital Francisco J. Muñiz a principios de los años 1980: por iniciativa del primer Instructor y Jefe de Residentes, Dr. Ernesto Efron, y con el apoyo de la Jefa de Sala 20 del Muñiz, Dra. Laura Astarloa, se organizó la rotación de residentes por el Servicio de Hematología de nuestro Hospital, entonces bajo la jefatura de la Dra. Ana Huberman. De ese vínculo surgió que el Dr. Raúl Salerno decidiera quedarse como consultor infectológico al finalizar su residencia, sumándose poco después las Dras. Ana Colombini, María Cristina Ezcurra y Viviana Ybarra. A fines de los años 1980 el Dr. Salerno logró el apoyo de la Dirección del Hospital y se creó el "Grupo de Trabajo de Infectología", dependiente del Departamento de Medicina Interna.

Poco después se incorporó la enfermera Cristina Funes, recién formada en el primer curso de Enfermería en Control de Infecciones de la Escuela Superior de Enfermería "Cecilia Grierson", estableciéndose desde entonces un fuerte vínculo entre infectólogos y Enfermeros en Control de Infecciones (ECI) —rol al que luego se sumarían Beatriz Martín, Silvia Nulman, Marta Ávalos y Silvana Hernández—. El Grupo participó activamente en brotes locales (cólera en 1992, dengue e influenza en 2009) y en situaciones pandémicas internacionales (VIH/SIDA desde la década de 1980 y ántrax en 2001). A comienzos de los años 1990 se sumó un cargo vespertino ocupado por la Dra. Claudia Sarkis, incorporando la atención de pacientes pediátricos; a fines de esa década comenzaron las actividades docentes de pregrado para la UBA y la UAI, y el curso de especialización de posgrado de la UCA. Entre 2005 y 2007 el Grupo participó en la atención de pacientes con autotrasplante de médula ósea y células progenitoras hematopoyéticas. En la década de 2010 se intensificó la interacción con Epidemiología, en especial con la Dra. Rosana Agoglia, se incorporó la Dra. Ana Torlaschi y se jubiló el Dr. Salerno, quedando a cargo la Dra. Viviana Ybarra. El 1.º de septiembre de 2022 inició la jefatura el Dr. José María Bruguera.

Agradecimiento: La Dra. Viviana Ybarra y el Dr. José Bruguera han colaborado en la redacción del capítulo, nuestro agradecimiento.

Capítulo 29

Instrumentación Quirúrgica

La instrumentación quirúrgica tiene como misión asistir, controlar, supervisar y evaluar lo que atañe a su tarea específica en el proceso de atención del paciente, desde su ingreso al quirófano hasta su egreso de la sala de recuperación posanestésica, asumiendo su responsabilidad laboral de manera ética y profesional e integrando activamente el equipo técnico-profesional del Centro Quirúrgico.[1]

A nivel mundial, a principios del siglo XX el instrumental de las mesas quirúrgicas era preparado por las enfermeras, que durante la Segunda Guerra Mundial ayudaron a los cirujanos a operar y salvar cientos de vidas. En la Argentina, los maestros de la cirugía comenzaron a formar recursos humanos idóneos para tareas específicas en los actos quirúrgicos: en la década de 1930 la instrumentadora quirúrgica comenzó a tener lugar en los equipos y centros quirúrgicos cuando el Dr. Guillermo Bosch Arana[2] consideró imprescindible su presencia para acortar los tiempos operatorios y anestésicos en beneficio del paciente, desarrollando incluso un método de señas que permitía operar sin hablar y concentrados. Años después, los Dres. Ricardo Finochietto y José Joel escribieron los primeros libros de instrumentación quirúrgica, a la par que se crearon los primeros cursos para instrumentadoras. En los años 1970, cuando la carrera era aún considerada una actividad de colaboración, funcionaban tres escuelas hospitalarias municipales —Argerich, Rawson y Ramos Mejía—, unificadas por contenido curricular y carga horaria; en 1976 se otorgaron las primeras matrículas profesionales, tras la inclusión de la profesión en la subárea de controlador del ejercicio profesional.

En nuestro Hospital, los primeros quirófanos funcionaban en los distintos pisos de las salas de cirugía; en la década de 1970 se inauguró la nueva planta de cirugía en el cuarto piso del pabellón quirúrgico, con 12 salas de operaciones, desde entonces sede de todas las cirugías. Según los registros, las primeras instrumentadoras egresaron de la escuela en 1972, época

[1] 1994 — Resolución 348/94.

[2] Guillermo Bosch Arana (1889–1939), médico cirujano argentino. Fundó la primera escuela de Instrumentación Quirúrgica en el Hospital Argerich.

en que las alumnas solo instrumentaban mientras los enfermeros atendían el quirófano. En 1978, al cerrarse el Hospital Rawson, sus instructoras fueron trasladadas a la escuela del Ramos Mejía, y dos años más tarde se incorporaron al plantel de instrumentadoras de planta permanente del Quirófano Central.

Figura 29.1: Instrumentadoras del Plan Piloto, 1987.

En 1986, sobre la base de un proyecto de la Sra. Inst. Alicia Susana Grazioli de Bonafine y la Sra. Inst. María Clara Vásquez Mansilla, se firmó un convenio entre el Director de Atención Médica, el Director de Hospitales y representantes de las Escuelas de Instrumentación Quirúrgica y de Enfermería sobre el funcionamiento de las plantas quirúrgicas, conocido como el "Plan Piloto": su fundamento era recuperar al personal de Enfermería de los quirófanos para la atención directa del paciente y dejar las plantas quirúrgicas en manos de instrumentadores formados en sus propias escuelas. Nuestro Hospital fue el primero en poner en funcionamiento el Plan Piloto, surgiendo así la función del instrumentador circulante; en 1986 el intendente municipal decretó la designación de 17 instrumentadoras, que ingresaron a comienzos de 1987.

El servicio de Guardia realizaba además sus propias cirugías de urgencia, en un principio con una instrumentadora por día y, tras la ampliación de la dotación, con dos instrumentadoras de guardia las 24 horas durante los siete días de la semana. En 1994 el Ministerio y la Secretaría de Salud aprobaron las "Normas de Organización y Funcionamiento de las Áreas de Instrumentación Quirúrgica en Establecimientos Asistenciales" (Resolución 0348/94). En 1995, por resolución ministerial, se inauguró en el Hospital el Centro Obstétrico, con quirófano propio coordinado por una instrumentadora y dos instrumentadoras de guardia diarias. En 2006 se autorizó la ampliación de personal con el ingreso de diez instrumentadores, permitiendo extender el horario de cirugías hasta las 18 hs, como en la actualidad; nuestro Hospital es uno de los pocos del sistema que opera en turnos matutino y vespertino. En 2019, en los nuevos quirófanos, comenzó a operarse neurocirugía los días sábados —siendo nuestro Hospital el único de la red en programar cirugías ese día—, y en mayo de ese año, bajo decreto 83/19, se aprobó la Estructura Organizativa de Jefaturas de Hospitales, dando lugar al actual Departamento de Asistencia Técnica, del que los instrumentadores forman parte con cinco jefaturas de sección, una de división y el Departamento a cargo.

En la actualidad, los instrumentadores cumplen funciones en los tres centros quirúrgicos del Hospital, en los quirófanos de Guardia y del Centro Obstétrico, y en la planta quirúrgica en los turnos matutino y vespertino, ocupándose de la supervisión y conducción del desempeño de los instrumentadores, el reabastecimiento de insumos, las licitaciones y evaluaciones, la codificación de materiales y los protocolos de trabajo, además de participar en proyectos de investigación y en el Comité de Docencia e Investigación. Sus competencias, transversales

a todos los profesionales del sector salud, les permiten asumir una responsabilidad integral sobre el proceso en el que intervienen, junto a competencias tecnológicas y conocimientos metodológicos y de técnica quirúrgica.

Agradecimiento: A la Lic. Marcela A. Aragón, quien ha redactado este capítulo, nuestro agradecimiento.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 30

Kinesiología

El Hospital Ramos Mejía fue inaugurado en 1884 y ha pasado por diversas etapas de crecimiento y modernización. Desde sus inicios se comprometió con la atención integral de la salud, incorporando distintas especialidades, entre ellas la kinesiología.

La kinesiología, como disciplina relacionada con el estudio del movimiento humano y su aplicación en la salud, tiene raíces que se remontan a la antigüedad. Desde sus orígenes hasta su reconocimiento como disciplina profesional, ha continuado desarrollándose y adaptándose a las necesidades contemporáneas, contribuyendo de manera significativa al bienestar de las personas; su enfoque integral hacia la medicina y la rehabilitación contribuyó a que se la reconociera como disciplina esencial para la recuperación de los pacientes, mejorando la calidad de la atención en los hospitales públicos.

La Dra. Cecilia Grierson, médica de nuestro Hospital, publicó en 1897 *Masaje práctico*, uno de los primeros libros sobre técnicas kinesiológicas, y en 1904 y 1905 dictó los primeros cursos de "Gimnasia Médica y Quinesioterapia" en la Facultad de Medicina, siendo el primer antecedente de la Kinesiología en la Argentina; además fue docente adscripta en la Cátedra de Física Médica y Obstetricia. En el Diario de la Agrupación de Practicantes del Hospital Ramos Mejía de 1929 se informó que el Hospital contaba con un Servicio de Masajes a cargo de Nicolás Torres, Rosalía de Perés y Elena Guarnieri. En 1930 se creó la primera carrera de Kinesiología en la Universidad de Buenos Aires.

El Servicio de Kinesiología de nuestro Hospital comenzó a consolidarse en las décadas de 1950 y 1960, cuando se reconoció la importancia de la rehabilitación física como parte esencial de la recuperación de los pacientes. En 1967 funcionaba de lunes a sábados, en turnos mañana y tarde, con diez profesionales, contando con docentes de la UBA y jefes de cátedra. En 1978, con el cierre del Hospital Rawson, se incorporaron nuevos profesionales que cumplían funciones en el turno tarde; ese turno se cerró años después y volvió a reabrirse en 2004. En sus inicios el Servicio se encontraba ubicado en el subsuelo del pabellón quirúrgico, donde actualmente funciona Ropería; en 1987 fue trasladado a su ubicación actual, en el tercer piso del mismo pabellón.

A lo largo de los años, el equipo de Kinesiología ha estrechado su colaboración con otros profesionales de la salud, brindando un enfoque multidisciplinario; en la actualidad funcionan dos grupos de trabajo: uno de rehabilitación respiratoria y otro de transición de pacientes con mielomeningocele. Con el tiempo se incorporaron nuevas tecnologías y técnicas de tratamiento, adaptándose a las necesidades cambiantes de la población, lo que incluye la implementación de terapias manuales, ejercicios terapéuticos y equipamiento especializado para mejorar la recuperación y la calidad de vida de los pacientes. El Servicio, dependiente del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento y con doce profesionales en total —muchos de ellos docentes de la UBA y jefes de cátedra—, ha logrado atender a una amplia gama de pacientes, desde quienes presentan lesiones deportivas hasta personas mayores que requieren rehabilitación quirúrgica o neurológica.

En 2013 se incorporaron los primeros siete kinesiólogos titulares de guardia, cumpliendo funciones en áreas cerradas y dependiendo del Departamento de Urgencia; en 2022 se amplió la dotación a tres kinesiólogos titulares de guardia. Los últimos Jefes de Unidad fueron el Dr. Kaplan, la Lic. Marta Almeida y, en la actualidad, la Lic. Mónica Pugliese.

La historia del Servicio de Kinesiología del Hospital Ramos Mejía es un reflejo del compromiso con la excelencia en la atención de la salud. A través de los años ha demostrado ser un componente vital en el proceso de recuperación de los pacientes, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la comunidad que atiende, y continúa adaptándose y evolucionando para enfrentar los nuevos desafíos del ámbito de la salud.

Agradecimiento: A la Lic. Mónica Pugliese por la redacción de este capítulo, nuestro agradecimiento.

BORRADOR — EN CONSTRUCCIÓN

Capítulo 31

Laboratorio Central

El Círculo Médico Argentino, liderado por el Dr. José María Ramos Mejía, desarrolló un programa de mejoras en los hospitales de la ciudad que incluía los estudios bacteriológicos, indispensables para arribar a diagnósticos certeros e instalar tratamientos oportunos y eficaces. Para ello se construyó el Laboratorio Bacteriológico de Asistencia Pública, en funcionamiento desde 1886 hasta 1893 bajo la dirección del Dr. Telémaco Susini, a quien sucedió el Dr. Julio Méndez; también formaron parte de este laboratorio, dedicado fundamentalmente al diagnóstico de cólera y otras enfermedades infecciosas, el Dr. Carlos Malbrán y el Dr. Silverio Domínguez, ambos con vasta experiencia recogida en los laboratorios europeos de París, Berlín y Viena. En la década de 1940, el Prof. Raúl Biot, Jefe de la Cátedra de Histología de la Facultad de Medicina, y el subjefe Dr. Varela asignaban la tarea diaria; el practicante de vacuna ascendía a practicante de laboratorio y, cumplida su capacitación, pasaba a ser practicante de sala.

Figura 31.1: Laboratorio del Dr. Galli. *Fuente: Archivo General de la Nación, 1935.*

División Análisis Clínicos

En sus comienzos el Hospital no contaba con un único servicio para los análisis clínicos: las muestras de sangre, orina y excreciones se analizaban en sectores ubicados dentro de las áreas de internación, con un modesto mobiliario inspirado en los laboratorios químicos europeos de la época —mesas resistentes a los químicos, microscopios, mecheros tipo Bunsen, vasos de precipitados, erlenmeyers, tubos de ensayo, embudos, probetas graduadas, buretas y destiladores—. Desde el Lazareto y hasta la década de 1960, cuando se construyó el edificio del Laboratorio Central, estas prácticas se realizaban dentro de las salas de internación, generalmente a cargo de médicos; más tarde se edificaron pequeños laboratorios en los servicios médicos, con microscopio, balanza analítica y algún material volumétrico de vidrio. Con el avance de la tecnología, laboratorios de especialidades como Hematología y Endocrinología tuvieron un crecimiento importante. El 28 de noviembre de 1919 la Facultad de Medicina aprobó el plan de estudios de la carrera de Bioquímico, propuesto por el Dr. Juan Antonio Sánchez, egresando la primera promoción en 1921-1922 con el título de doctores en Bioquímica y Farmacia; sin embargo, los laboratorios clínicos comenzaron a incorporar mayor número de bioquímicos solo después de la creación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en 1957.

A partir de 1950 llegó la automatización del laboratorio, que mejoró notablemente la precisión y exactitud de los resultados al reemplazar el manejo humano de muestras y reactivos por máquinas con pipetas automáticas y sustancias estándar de referencia. El primer equipo automatizado del Hospital, que realizaba solo glucosa y urea, se instaló en el Laboratorio Central en la década de 1970; desde entonces el desarrollo tecnológico e informático mundial posicionó al laboratorio clínico en un lugar de privilegio respecto de los estándares alcanzados en las tres etapas del proceso analítico —preanalítica, analítica y posanalítica—, mejorando los tiempos de respuesta y la calidad de los resultados. El edificio del Laboratorio Central mantiene su estructura arquitectónica original, con una parte central donde se ubican la recepción y los boxes de toma de muestra, y dos alas laterales donde se distribuyen las secciones del servicio. En su estructura orgánico-funcional se inscribe como División Análisis Clínicos, con tres secciones —Bioquímica Clínica, Hemocitología y Microbiología— organizadas según las especialidades bioquímicas reconocidas por el Ministerio de Salud de la Nación, además de dos grupos de trabajo: Inmunología y Autoinmunidad, y Biología Molecular. El Laboratorio de Urgencias depende de la Dirección Técnica de la Jefatura de la División Análisis Clínicos, aunque administrativamente sus profesionales bioquímicos responden al Departamento de Urgencias.

El servicio cuenta con 20 autoanalizadores de última generación y todo el instrumental necesario para el acondicionamiento de las muestras en la etapa preanalítica; el aseguramiento de la calidad se realiza mediante programas internos y externos internacionales de evaluación, siguiendo normas como la ISO 15183. La gestión de la información se realiza mediante SIGEHOS (Sistema de Gestión Hospitalario), conectado con el LIS del laboratorio y con los autoanalizadores, generando un circuito bidireccional de datos. La producción

anual del servicio asciende a 1.300.000 determinaciones, atendiendo a 148.000 pacientes; más allá de los números, la tecnología y la calificación profesional, el Laboratorio Central alberga un equipo de personas siempre dispuesto a ofrecer un servicio un poco mejor cada día.

Unidad de Parasitología

Fue creada en 1979 por el Prof. Dr. Pedro Garaguso, eminente parasitólogo argentino que previamente había tenido a su cargo Parasitología del Hospital Pedro Elizalde. El edificio, ubicado frente a Anatomía Patológica, lindante con las calles 24 de Noviembre y México, contaba con un subsuelo de depósito, planta baja con sala de espera y laboratorios donde se realizaban inmunofluorescencia, extracciones de material biológico, serologías y procesamiento de materia fecal; allí funcionaban también el escritorio del jefe de Chagas, espacios para preparación de hisopos y repique de medios de cultivo, y un bioterio con ratones para las pruebas de Sabin y Feldman. En el primer piso había un insectario con triatomíneos de diferentes estadios, mantenidos bajo condiciones controladas de temperatura y humedad, y un aula-laboratorio para 50 personas utilizada por alumnos universitarios y cursos de perfeccionamiento; fuera del pabellón existía incluso un corral para una oveja, dadora involuntaria de sangre para la prueba de fijación de complemento. La Unidad se concibió para el trabajo interdisciplinario, con médicos, bioquímicos, biólogos, veterinarios, químicos, técnicos y auxiliares de laboratorio, y realizaba xenodiagnóstico, siendo el único lugar de los hospitales de la CABA en hacerlo.

En 1996 las autoridades hospitalarias decidieron que el edificio fuera ocupado por el Área Programática, y la Unidad de Parasitología se trasladó al Laboratorio Central; en esa mudanza forzada se perdió equipamiento como selladores de frascos y centrífugas refrigeradas, y las cámaras de frío y de estufa fueron reconvertidas en vestuarios y aula de entrenamiento. A pesar de ello, los miembros de la Unidad continuaron realizando trabajos científicos en colaboración con instituciones públicas y privadas, publicando libros, dirigiendo cursos internacionales y participando en la elaboración de normas parasitológicas y en consensos.

Sección de Micología

La creación de la Sección de Micología Médica comenzó en 2005, con el objetivo de mejorar el diagnóstico y tratamiento de las infecciones fúngicas invasoras en un hospital con creciente demanda de pacientes inmunocomprometidos: las internaciones por enfermedades oportunistas asociadas al VIH avanzado y la apertura de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea requerían profesionales especializados en la prevención, epidemiología, diagnóstico y tratamiento de las patologías fúngicas más prevalentes en esa población. Esa demanda fue absorbida por la Unidad de Parasitología, cuya jefa, la Lic. Gabriela Razzitte, aceptó el desafío de organizar el nuevo sector, desarrollando en forma permanente los tres objetivos de

la actividad hospitalaria: asistencia, investigación y docencia. En lo asistencial se mejoró la infraestructura y se incorporó equipamiento gracias a un subsidio de la agencia científica y tecnológica nacional y al apoyo del entonces viceministro de Salud, Dr. César Sáenz, además de la gestión del Director Dr. Pascuccelli, quien ayudó a conseguir los recursos para los cerramientos del área y la compra del equipamiento necesario.

La Dra. Roxana G. Vitale, investigadora del CONICET y una de las primeras micólogas especializadas en micología médica en la CABA, fundó junto al Dr. Afeltra este servicio, incorporando las técnicas de diagnóstico micológico; el sector fue el primero en toda Latinoamérica en realizar, como institución pública y gratuita, las determinaciones de niveles plasmáticos de antifúngicos sistémicos, hoy un estándar de cuidado para los pacientes con infección fúngica invasora. En investigación, la Dra. Vitale —miembro del CONICET— y el Dr. Afeltra —investigador independiente de la Carrera de Investigación para la Salud del GCBA— desarrollan estudios básicos y aplicados, incluyendo el desarrollo de nuevas moléculas antifúngicas y estudios multicéntricos en colaboración con otros centros, siendo ambos autores de numerosas publicaciones en revistas científicas de alto nivel. La Dra. Vitale dirige el Curso Internacional de Postgrado en Micología Médica, dictado de manera ininterrumpida en los últimos 20 años en Holanda, Austria, Alemania, Brasil, China y los Estados Unidos; fue becaria Fulbright para realizar trabajos de investigación conjunta con el National Institutes of Health (NIH) de los Estados Unidos.

Agradecimiento: A las Lic. Gabriela Razzitte, Jefa de Departamento, y Susana Ravea, Jefa de División de Análisis Clínicos, y a los Dres. Roxana G. Vitale y Javier Afeltra, por la redacción de este capítulo, nuestro agradecimiento.

BORRADOR NO PUBLICADO

Capítulo 32

Nefrología

La Nefrología es una especialidad relativamente joven dentro de la medicina interna. En la década de 1970, el Dr. Mauricio Manguel, entonces a cargo de la Clínica Médica C, impulsó la formación de varios de sus colaboradores en distintas subespecialidades: envió al Dr. Héctor Marone a realizar el Curso Superior de Nefrología, al Dr. Marcelo Torino a Cardiología, al Dr. Pedro Valicenti a Hepatología y al Dr. César Sáenz a Neumotisiología, sentando así las bases de varios de los servicios que hoy conforman el Hospital.

El Dr. Marone, ya formado en Nefrología, aprendió a practicar la biopsia renal por punción —con agujas de Vim Silverman modificadas por Franklin— junto al Dr. Puddú, a fines de la década de 1970. La técnica se realizaba entonces "a ciegas", sin guía ecográfica, y nuestro Hospital fue uno de los pocos centros del país en realizar biopsias renales en esa época. Con el advenimiento de la hemodiálisis, el Dr. Armesto se asoció brevemente con Marone en la práctica privada y juntos conformaron un Grupo de Trabajo de Nefrología dentro del Hospital, aunque Armesto luego se trasladó al Hospital Fernández.

El actual Jefe del Grupo de Trabajo, Dr. Cristian Kramer, recuerda haber realizado diálisis peritoneal en 1979 como estudiante de la UDH, y haberse incorporado en 1981 como único colega de Marone. En aquellos años, las muestras de biopsia se enviaban sin cargo al Hospital de Clínicas para su procesamiento, y el estudio de los sedimentos urinarios era enseñado por el Dr. Balbachian. En 1984 se incorporó el Dr. Roberto Ocáriz; en 1991, tras ganar en 1987 un concurso que combinaba guardias de doce horas los fines de semana con tareas de planta durante doce horas, el propio Dr. Kramer se integró formalmente al servicio de Nefrología, de modo que hacia 1992 el servicio contaba ya con tres médicos.

La técnica de biopsia renal guiada por ecografía fue enseñada por los Dres. Carlos Sanguinetti, Alberto Guida y Guillermo Márquez. La Dra. Diana Miserendino se formó como nefropatóloga junto a la técnica conocida como "la Sra. Blanca", procesando las muestras de biopsia del servicio. Hacia fines de la década de 1990, el Dr. Marone pasó a ser Jefe de Unidad en Clínica Médica, quedando Ocáriz y Kramer como únicos nefrólogos; la Dra. María Inés Marone fue designada médica de guardia para hemodiálisis, aunque esa función

no pudo sostenerse en el tiempo. Con la emigración de la Dra. Miserendino a Córdoba, el retiro de la Sra. Blanca y la rotura del micrótomo del servicio, el procesamiento de biopsias renales dejó de realizarse en el Hospital. Posteriormente el Dr. Marone se jubiló y el Dr. Ocáriz se trasladó a Bariloche.

La Dra. Silvia Mura se incorporó como concurrente, devolviendo al servicio a tres integrantes junto con la Dra. Marone; Mura se trasladó a España hace aproximadamente tres años, y la Dra. Verónica Roatta ganó el concurso subsiguiente. El servicio mantiene una activa participación docente en el grado de la UBA, el posgrado de la UCA y en la Sociedad Argentina de Nefrología.

Agradecimiento: Al Dr. Cristian Kramer, Jefe del Grupo de Trabajo de Nefrología, por la redacción de este capítulo.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 33

Neonatología

Se define como Servicio de Neonatología a la Unidad Funcional que garantiza la cobertura asistencial de los pacientes neonatos enfermos, así como la asistencia a los recién nacidos en la sala de partos o pabellón y la atención del neonato que se encuentra en puerperio junto a su madre.

Figura 33.1: Incubadoras para niños del Hospital, 1910.

El servicio de nuestro Hospital fue fundado en 1967 por el Dr. Juan Carlos Mercau, en la Maternidad "Eliseo Cantón", hasta su demolición en 1977. La antigua maternidad contaba con una sala de partos, internación conjunta, una sala de recién nacidos en observación y una terapia, y un laboratorio para exámenes mínimos —hematocrito, grupo sanguíneo y factor, y dosaje de bilirrubina—, efectuados por los propios médicos, además de una sala de médicos y un espacio de investigación; en el piso existía un museo de obstetricia. Los médicos de guardia eran los de Pediatría. Se realizaba docencia de pregrado, posgrado y residencia, siendo el único hospital general de agudos que efectuaba la formación de médicos en la especialidad.

Desde 1977 el servicio pasó a funcionar en el segundo piso del pabellón quirúrgico, donde cuenta con una sala de partos, una sala de neonatología y de cuidados intermedios, un salón de médicos, un dormitorio para los médicos de guardia, una sala en la maternidad para internación conjunta y un consultorio externo. En un principio se comenzó a brindar atención con dos incubadoras y, con el esfuerzo de todo el equipo, se pudo pasar a funcionar como una terapia neonatal. En 1994 se logró contar con médicos neonatólogos de guardia y se efectuó el primer cierre de ductus en un recién nacido en un hospital general de agudos, a cargo del Dr. Cornejo, cirujano de la Casa Cuna, logrando el reconocimiento de nuestro Hospital. Hoy el servicio cuenta con un médico genetista, una médica de diagnóstico por

imágenes, un neurólogo, una oftalmóloga y una cardióloga, con médicos de guardia propios y médicos de planta, un Jefe de internación conjunta y un Jefe de neonatología; se realiza docencia de pregrado y posgrado.

Sus jefes, en orden cronológico, fueron los Dres. Juan Carlos Mercau, Horacio Olive, Zigman Zigaler, Olga Da Cruz, Carlos Mercau, Alfredo Codina, Hugo Pandullo, Gustavo Pintos, Jorge Lamela, Marcela Echeverría y Mónica Rebagliati.

Agradecimiento: Al Dr. Carlos Mercau, por la redacción de este capítulo, nuestro agradecimiento.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 34

Neumotisiología

Los antecedentes de la Neumotisiología en nuestro Hospital se remontan al Prof. Luis U. Rabuffetti, Jefe de la Sala XII en la década de 1950, quien se interesó tempranamente por la patología respiratoria y el asma. El Dr. Julio Cruciani, Jefe de Alergia, escribió sobre el asma en 1930 en el diario de la Asociación de Practicantes; el Dr. Isidoro Steimberg, de la Sala III y coeditor de los libros sobre asma de Cruciani, escribió ese mismo año sobre la cura y el clima en la tuberculosis; y la Dra. Iris Tessieri, de la Sala VI, bajo el Prof. Robertson Lavalle, escribió en 1930 sobre el diagnóstico de la tuberculosis. Más adelante, el Dr. Manguel, Jefe de la División A, envió al Dr. César Sáenz a realizar el Curso Superior en el Hospital Muñiz.

La Unidad de Neumotisiología fue creada por decreto municipal en 1979, inicialmente dependiente de la División A de Clínica Médica y luego autónoma. En agosto de ese año fue designado primer Jefe el Dr. Eduardo A. Herrmann, previamente Jefe de Unidad en el Hospital Muñiz. Se trató de la única Unidad de Neumotisiología con internación en un Hospital General Municipal, con quince camas y quince pacientes tuberculosos trasladados desde el Hospital Muñiz junto con un jefe y dos médicos de planta.

Figura 34.1: Dr. Eduardo Herrmann, primer Jefe de la Unidad de Neumotisiología.

Herrmann se jubiló en 1982 y fue sucedido por el Dr. César Sáenz, quien ejerció la jefatura hasta 2006 —año en que asumió además como viceministro de Salud del GCBA hasta 2007—, retomándola luego hasta su jubilación en 2016. Le siguió de manera interina la Dra. Mónica Jajati hasta 2018, año en que el Dr. Martín Sívori, actual Jefe, ganó el concurso correspondiente. A lo largo de los años se desempeñaron como médicos de planta los Dres. Lupi, Norma Sanfeliz, Néstor Hoffman, Eva Blaho y Claudio González.

Desde 1997 el servicio enseña Neumonología en el pregrado de la UBA de manera ininterrumpida, siendo subsede del Curso Superior de especialistas desde ese año y Sede desde 2021. En 2007 se creó la Residencia de Neumonología, de categoría A y entre las mejores calificadas del país; en septiembre de 2020 se creó el Centro Universitario de Neumonología "Dr. J.M. Ramos Mejía" de la UBA. El servicio cuenta con más de doscientas publicaciones indexadas y se ha modernizado con fibrobroncoscopios, un laboratorio pulmonar moderno y un gimnasio de rehabilitación respiratoria en conjunto con Kinesiología. Funcionan también consultorios de subespecialidad para enfermedades pulmonares intersticiales difusas (con Reumatología), hipertensión pulmonar (con Cardiología), manejo del paciente neuromuscular (con Neurología, Alimentación, Kinesiología y Fonoaudiología), evaluación de patologías del sueño (con Neurología) y manejo del asma grave (con Otorrinolaringología y Alergia). El servicio recibe además pacientes derivados de hospitales pediátricos.

Actualmente integran la planta los Dres. Mónica Jajati, Daniel Pascansky, Paula Kaplan, Romina Fernández, Pablo Szwarstein, Javier Iriarte Vasquez y Laura Soledad Prigioni, junto con la Sra. Laura Chekherdemian en tareas administrativas.

BORRADOR – NO DEFINITIVO

Capítulo 35

Neurocirugía

La historia de la Neurocirugía en nuestro Hospital puede organizarse, siguiendo la clasificación de Carrillo actualizada por el Dr. León Turjanski, en cinco grandes períodos: los Precursores (1885-1905), los Iniciadores (1905-1925), los Sistematizadores (1925-1950), la Consolidación (1950-1977) y la Actualización con Subespecialización (1978 a la actualidad).[47]

Los Precursores (1885-1905)

El Dr. Juan B. Justo inauguró la neurocirugía en el Hospital San Roque en 1889, cuando fue el primero en el mundo en realizar con éxito una craneotomía osteoplástica en dos pacientes; introdujo además la asepsia en la Argentina entre 1889 y 1890, realizó la primera laminectomía del país —en un lesionado medular por herida de arma de fuego— y publicó, entre otros temas, sobre la flebitis del seno cavernoso. Queda así establecido que Juan B. Justo fue el primer cirujano neurológico del Hospital Ramos Mejía; su paso fugaz por la especialidad bastó para grabar el sello de su talento. Fundador del Partido Socialista, fue cesanteado en 1900 por sus posiciones políticas. El Dr. Nicolás Repetto —graduado en la UBA en 1894 y formado en cirugía durante una residencia en Europa— asistió a Justo, cofundó junto a él "El Hogar Obrero" en 1905 y escribió "Lecciones sobre Cirugía Craneana". El Dr. Alejandro Posadas, sin pertenecer al Hospital San Roque, fue uno de los primeros en el mundo en publicar sobre los quistes hidatídicos. El Dr. Enrique Corbellini, profesor suplente desde 1901, investigó los tumores cerebelosos junto a Jakob.

Los Iniciadores (1905-1925)

El Dr. Delfor del Valle (h), nacido en 1887 y recibido en 1912, fue Jefe de la Sala XI y creador del Instituto de Gastroenterología; fue el primero en utilizar el abordaje transcraneal para los tumores de hipófisis en 1923, y su libro de 1939 sobre el esfínter de Oddi dio nombre a la "Enfermedad de Del Valle". Convocó al extranjero a los Dres. Ernesto Dowling y Salvador

Viale; se retiró en 1956 y falleció en 1974. El Dr. Eliseo Segura publicó en 1917 sobre cirugía de hipófisis, orientándose más tarde hacia la Otorrinolaringología.

Los Sistematizadores (1925-1950)

El Dr. Manuel Balado, discípulo de Arce, tomó a cargo en 1926 la sección de neurocirugía del Hospital de Clínicas y en 1937 se convirtió en el primer Profesor Titular de Neurocirugía dedicado exclusivamente a la especialidad en Sudamérica.

El Dr. Ernesto Dowling se inició bajo Delfor del Valle (h) en la Sala XI, se graduó en 1918 y viajó en la década de 1920 a formarse con Adson en la Mayo Clinic, con Dandy en Johns Hopkins, con Frazier en Filadelfia y con Cushing en Boston; regresó en 1925 para fundar el primer centro neuroquirúrgico de la Argentina, creó la técnica conocida como "parto hidatídico a lo Dowling" y en 1937 asumió la neurocirugía del Hospital Rivadavia. Tras la partida de Dowling y Viale hacia ese hospital, el servicio quedó sin neurocirujano dedicado por un tiempo, siendo el Dr. Julio Lyonnet —decano de la Universidad de La Plata y pionero, junto a Fernando Silva, de la vía transoval para la neuralgia del trigémino— quien actuó como consultor.

Figura 35.1: Dr. Ernesto Dowling.

La Consolidación (1950-1977)

El Dr. Alberto Eurnekian, nacido en 1928 y recibido en 1953, se formó bajo el Dr. Raúl Carrea en el Hospital de Niños y viajó a Johns Hopkins, Inglaterra y el Karolinska Institutet; de regreso hacia 1959 estableció el servicio de Neurocirugía, autofinanciado al no integrar aún el organigrama municipal, dentro de la Cirugía General a cargo del Dr. Sánchez Zinny. Desarrolló técnicas de angiografía y estudió el síndrome de Hakim-Adams (hidrocefalia); su colega el Dr. Strejilevich se interesó por la cirugía de nervio periférico y columna. La sala contaba con siete camas para hombres, siete para mujeres, dos habitaciones semiprivadas y una oficina con biblioteca y sala de enseñanza; la instrumentadora Sra. Susana Blum acompañó al equipo y custodió su instrumental, provisto en su totalidad por el propio Eurnekian. El servicio mantenía una relación estrechísima con la Sala-Cátedra de Neurología —Pereyra Käffer, Gustavo Poch, Roberto Sica, Figini, Monteverde, Somoza, Delamónica y Herskovits—, grandes "proveedores" de patología certeramente diagnosticada, y su equipo operaba también junto a otros servicios, en especial Ortopedia y Traumatología y Otorrinolaringología. El Dr. Leonardo Strejilevich, de sólida formación neuroanatómica, se había incorporado en 1967, ganó un cargo de planta por concurso en 1971 y fue subjefe desde 1974. Eurnekian se trasladó a Mendoza en 1976, y el Dr. Strejilevich continuó al frente del servicio hasta su cierre, por motivos no del todo aclarados, en 1978.

La Actualización con Subespecialización (1978-actualidad)

En 1978 el servicio se trasladó en su totalidad desde el Hospital Penna, bajo la jefatura del Dr. Jorge Salvat y su equipo —Francisco Campos, Osvaldo Fernández Boan, Jorge Navarré, Oscar Stella, Ricardo Azzaneo, Héctor Aguirre y Ricardo Desillis— aunque sin espacio propio de internación al principio. Con la incorporación de este grupo se instalaron las guardias de Neurocirugía. Por concurso abierto de Jefe de Unidad se designó al Dr. Abraham Salzman —proveniente de los Hospitales Pirovano y Salaberry y formado en la UCLA—. En 1988 ingresó la Dra. Cristina Lozano, que tomó a su cargo la docencia de pregrado y se orientó al neurotrauma, y entre 1989 y 1990 los Dres. Ricardo Vázquez —dedicado a la cirugía neurovascular y la estereotaxia— y Fernando Libenson. En 1991 se retiraron los Dres. Navarré, Azzaneo, Stella y Fernández Boan. Salvat se jubiló en 1994 y asumió la jefatura el Dr. Salzman; en 1997 regresaron Navarré y Stella —este último dedicado a la neurocirugía funcional y el tratamiento del dolor—, y, al dejar Salzman la jefatura por motivos de salud, lo reemplazó el Dr. Jorge Navarré, recordado por su humildad, dedicación y refinada técnica quirúrgica, que dio al servicio un fuerte impulso en número y complejidad de intervenciones. En 1999 se incorporó el Dr. Eduardo Seoane, formado junto a Evandro de Oliveira en San Pablo, Albert Rhoton en la Universidad de Florida y Robert Spetzler en el Barrow Neurological Institute, quien introdujo la neurocirugía vascular y la cirugía de epilepsia —en conjunto con la neuróloga Dra. Kochen—, convirtiendo a nuestro Hospital en un centro de referencia nacional único en cirugía de epilepsia del adulto. Seoane asumió la jefatura de División por concurso en 2008, cargo que ocupa hasta la actualidad; se incorporaron neurocirujanos más jóvenes como los Dres. Fernando Latorre, Pablo Seoane y Fernando Morelo. Entre 2007 y 2008 se incorporaron procedimientos mínimamente invasivos —vertebroplastias, radiofrecuencia facetaria, cirugía transeptoesfenoidal—, y en 2011 la estadía del Dr. Latorre en la Universidad de Pittsburgh dio inicio a la era de la cirugía endoscópica de base de cráneo. Ese mismo año se formalizó el programa anual de residencia y se creó el Instituto de Neurocirugía de la UBA con sede en nuestro Hospital; el Dr. Seoane fue designado Profesor Titular de Neurocirugía de la UBA.

Agradecimiento: Al Dr. Eduardo Seoane, por la redacción de este capítulo.

Capítulo 36

Neurología

La Neurología moderna reconoce como referencia fundacional a Jean-Martin Charcot (1825-1893), quien en 1882 ocupó en la Salpêtrière de París la primera cátedra de Enfermedades del Sistema Nervioso creada en el mundo.

En la Argentina, el primer antecedente conocido es la tesis doctoral de 1827 del Dr. Martín García, titulada "Epilepsia, su naturaleza y curación" —cuyo texto original no ha podido hallarse. En 1885 se creó, en el Hospital San Roque, la primera sala de enfermedades nerviosas del país, a cargo del Dr. José María Ramos Mejía, humanista, escritor y sociólogo, cuya tesis doctoral "Apuntes clínicos sobre el traumatismo cerebral" incluyó la descripción de dos trepanaciones craneales. En 1884 se creó en la UBA la Cátedra de Patología Mental, cuyo concurso ganó en 1886 el Dr. Lucio Meléndez por sobre Ramos Mejía y Eduardo Pérez; le sucedieron Domingo Cabred, José T. Borda, Arturo Ameghino y Gonzalo Bosch.

El 17 de febrero de 1887, bajo el decanato del Dr. Pedro Antonio Pardo, se creó en la UBA la Cátedra de Enfermedades Nerviosas; el concurso correspondiente fue ganado por el Dr. José María Ramos Mejía, por sobre Juan B. Senorans e Inocencio Torino, convirtiéndose así en el primer Profesor Titular y dictando su primer curso en abril de ese año —solo cinco años después de la cátedra de Charcot en París, lo que la convierte en la segunda cátedra de Neurología creada en el mundo. La obra literaria y sociológica de Ramos Mejía —"La neurosis de los hombres célebres en la historia argentina", "Las multitudes argentinas", "Rosas y su tiempo"— terminaría eclipsando su producción estrictamente neurológica, recogida en sus "Estudios clínicos sobre las enfermedades nerviosas y mentales". Entre sus discípulos se destacó José Ingenieros, director del Servicio de Observación de Alienados de la Policía y reconocido como "padre" de la Reforma Universitaria de 1918. El primer jefe de clínica fue el Dr. José A. Estévez, y en 1901 se incorporó el Prof. Christofredo Jakob (1866-1956), quien introdujo la neuropatología.

Ramos Mejía dictó su último curso el 24 de marzo de 1913, renunció en julio de ese año, fue nombrado profesor honorario el 6 de agosto de 1913 y falleció el 19 de junio de 1914. El Dr. José A. Estévez asumió la titularidad en 1913 e implementó, junto a Jakob,

el método anatomoclínico; publicó sobre hemiatrofia facial progresiva (1892), meningitis cerebroespinal epidémica (1894), quiste hidatídico, corea de Sydenham (1901), un caso de encefalitis letárgica (1920) y neuritis hipertrófica del adulto (1923); se retiró en 1924 y falleció en 1927. Le sucedió en junio de 1924 el Dr. Mariano Alurralde, de orientación anatomopatológica e histopatológica, también Jefe del Servicio de Neurología de la Sala XV desde 1929 y primer Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Rawson entre 1920 y 1944; se retiró en junio de 1940 y falleció en 1944.

En agosto de 1929 el Dr. Jean Lepine, decano de la Facultad de Medicina de Lyon, visitó el servicio y dictó doce conferencias, dejando una impresión favorable registrada en el diario "El Hospital Ramos Mejía". En estas salas el Dr. Rómulo Chiappori realizó la primera descripción mundial de la enfermedad de Wilson. En 1941 asumió la titularidad de la Cátedra el Dr. Vicente Dimitri, formado bajo Jakob y Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Alvear desde 1917, quien impulsó el método anatomoclínico e influyó en el Dr. José Pereyra Käffer —quien recuperó para la Neurología la sala del antiguo Hospital San Roque— y en el subjefe Dr. Gustavo Poch, coautor de un célebre manual de pregrado. Se conformaron así dos grupos diferenciados de la neurología argentina: uno liderado por Pereyra Käffer, integrado por los Hospitales Ramos Mejía, Francés, Italiano, Español, Posadas y Castex, reunido en la Sociedad Neurológica Argentina; y otro conformado por los Hospitales Rivadavia, Rawson, Argerich, Alvear, Álvarez, Militar y Aeronáutico, reunido en la Asociación Médica Argentina en Neurología.

En 1986 el decano, Prof. Dr. Guillermo Jaim Etcheverry, convocó a concurso para tres cargos de Profesor Titular, con un jurado integrado por el Prof. Carlos Bardeci, el Dr. Alberto Aguayo —de la Universidad McGill— y el Prof. Cotone. En 1987 resultaron ganadores los Dres. Roberto E. Sica, Salomón Muchnik y Ernesto Herskovits. El Dr. Roberto Sica, formado bajo el Dr. Julio César Ortiz de Zárate y luego becado por el British Council en la Universidad de Newcastle, como Research Fellow en McMaster y como Visiting Fellow en Oxford, trasladó la Cátedra a la División de Neurología del Hospital José María Ramos Mejía, asumiendo la jefatura de División por concurso en 1988. Condujo los célebres "Ateneos de los Jueves" y se convirtió en el neurólogo argentino más prolífico de la historia, con 172 publicaciones indexadas en PubMed, financiadas por el GCBA, la UBA, el CONICET y la OMS; se retiró en 2006 como Profesor Titular Consulto y fue nombrado Profesor Emérito en 2008.

En 2007 el Prof. Adjunto Raúl Rey sucedió a Sica en la jefatura de División, alcanzando en 2012 el cargo de Profesor Regular Titular, que continúa ejerciendo en la actualidad. Hoy el servicio es el único centro público con internación neurológica diferenciada del país, cuenta con la primera Unidad de Cuidados Cerebrovasculares creada en la Argentina, una Unidad de Video Electroencefalografía, una unidad de polisomnografía y hospital de día, además de numerosos consultorios especializados en movimientos anormales, epilepsia, cefaleas, deterioro cognitivo, enfermedades desmielinizantes, neuro-oftalmología, enfermedades cerebrovasculares, neuro-inmunología, enfermedades genéticas, enfermedades de motoneurona

y electromiografía/electrofisiología, constituyéndose en centro de referencia nacional. En docencia, reúne la mayor cantidad de cargos docentes de Neurología de la UBA designados en un solo centro —un Profesor Titular y tres Profesores Adjuntos—, siendo el principal centro de formación de Latinoamérica y la primera residencia regional de Neurología. En investigación, financiada por el GCBA, la UBA, el CONICET y organismos internacionales, mantiene líneas de trabajo en neuroinmunología, enfermedades cerebrovasculares, trastornos del movimiento, enfermedades genéticas, epilepsia y enfermedades de motoneurona, con quince a veinte publicaciones anuales.

Agradecimiento: Al Dr. Raúl Rey, por la redacción de este capítulo.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 37

Nutrición

El Dr. Pedro Tesone, médico dietólogo formado en el Instituto Nacional de Nutrición —bajo la dirección del Dr. Pedro Escudero— en el Hospital de Clínicas, fue concurrente del Servicio de Nutrición y Gastroenterología del Hospital Rawson, bajo el Dr. Pedro Landabure, antes de incorporarse a nuestro Hospital como Jefe de Unidad entre 1980 y 1993, cargo desde el cual luego fue designado Jefe del Departamento de Medicina Interna. Fue además Director de la Carrera de Médicos Especialistas en Nutrición de la Facultad de Medicina entre 1998 y 2005, jubilándose poco después de esa fecha y falleciendo en 2018. Como Asesor de la Secretaría de Salud del GCBA, colaboró en la creación de la Red de Diabetes de la Ciudad de Buenos Aires entre 2000 y 2006.[48]

Agradecimiento: Al Dr. Julio Bragagnolo, por la redacción de este capítulo.

BORRADOR

Capítulo 38

Odontología

Según el diario "El Ramos Mejía" de 1929, el Servicio de Odontología tenía como Jefe al Prof. Dr. Citro Durante Avellanal, junto al Dr. Raúl Loustalán.

En la década de 1980 el servicio estuvo a cargo del Dr. Miguel Vita, Cirujano Dentomaxilar, con un equipo integrado por las Dras. Ana Parra, Hebe Mariotti y Ana Bacigalupe —odontólogas generales especialistas en discrasias sanguíneas—, la Dra. Rita Capalbo (Estomatóloga), el Dr. José Mendeluck (Cirujano Dentomaxilar), el Dr. Héctor Salas (Ortodoncista), el Dr. Ricardo Leggieri (Estomatólogo), el Dr. García (Cirujano Dentomaxilar), el Dr. Castelli (Odontólogo General) y la Dra. Romiau (especialista en discrasias sanguíneas). En el Servicio de Dermatología trabajaban además dos odontólogos estomatólogos, los Dres. Bernat Martínez y De Lafuente. Entre los concurrentes de esa época se encontraban el Dr. Ursino Pascual (Endodoncista), el Dr. Osvaldo Varela (Ortodoncista), la Dra. Nora Freiber (Endodoncista), la Dra. Ana Kirczyk (Odontopediatra), el Dr. Carlos Lausirica (Cirujano Maxilofacial), la Dra. Gladys Poledri (especialista en discrasias sanguíneas), la Dra. Marcela Vieiro (Ortodoncista) y el Dr. Marcelo Marcos Teiblum (Cirujano Maxilofacial). Las asistentes dentales Perla y Margarita La Torre completaban el equipo.

En las décadas de 1990 y comienzos de los 2000 la jefatura fue ocupada por la Dra. Ana Bacigalupe y luego por el Dr. Ricardo Leggieri, incorporándose nuevas concurrentes como las Dras. Natalia Resumil, Mariela García y Noelia Bravo, esta última en Ortodoncia. En ese período se desarrollaron las especialidades de Cirugía Dentomaxilar, Endodoncia, Operatoria Dental, Trastornos Estomatológicos, Estomatología y Ortodoncia, incorporándose a la planta la Dra. Natalia Resumil (Trastornos Hematológicos) y la Dra. Mariela García (Operatoria Dental).

En 2017 el Dr. Marcelo Marcos Teiblum asumió la jefatura del servicio, impulsando la renovación de sillones e instrumental junto a la dirección del Hospital. A comienzos de la década de 2020 se incorporaron la Dra. Noelia Bravo (Ortodoncia) y la Dra. Verónica Henolker (Endodoncista). Desde 1990 colaboran como asistentes dentales Daniel Almirón, Erika Tikona y Silvia Ávalos.

Agradecimiento: Al Dr. Marcelo Teiblum, por la redacción de este capítulo.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 39

Oftalmología

Los orígenes de la Oftalmología en nuestro Hospital se remontan al Dr. Cleto Aguirre, quien ejerció en el Hospital de Hombres y luego en el Hospital de Clínicas hasta su muerte, y al Dr. Pedro Lagleyze, titular desde 1889 de la Cátedra de Oftalmología de la UBA. Su discípulo, el Profesor Adjunto Pedro Roberts, formado en Francia, creó un consultorio en el Hospital de Mujeres de la Sociedad de Beneficencia —hoy Hospital Santa Lucía—. El Dr. Eduardo Obejero, recibido en 1880, se formó allí y creó el Servicio de Oftalmología del Hospital San Roque, del cual fue Jefe entre 1883 y 1894, orientándose más tarde hacia la Otorrinolaringología.

Según el diario de 1929, el Dr. José Cerboni era Jefe de la Sala XIII de Clínica Oftalmológica, junto a los Dres. José Oneto y Luis Guiñazú. El servicio comparte pabellón con Otorrinolaringología, con la que tiene un origen común en el Hospital San Roque. Hoy cuenta con siete oftalmólogos de planta; su actual Jefa es la Dra. María Fernanda Merlo.

Agradecimiento: A la Dra. Fernanda Merlo, por la redacción de este capítulo.

Capítulo 40

Oncología y Radioterapia

La División Terapia Radiante-Oncología Clínica nació como un servicio de radioterapia en la década de 1950. Las jefaturas iniciales estuvieron a cargo del Dr. Maisa, médico radiólogo reconocido que años más tarde sería Presidente de la Academia Nacional de Medicina, y del Dr. Eduardo Navarrine, quien posteriormente dirigiría el Hospital de Radiaciones "Marie Curie". La División contaba entonces con un equipo de radioterapia de baja energía y un Dermophan para lesiones de piel; en la década de 1960 se incorporó la primera bomba de cobalto 60, un gammathrom, bajo la jefatura del Dr. Navarrine. Entre el personal médico de esa época se encontraban la Dra. Delia Judici y los Dres. Guido Bertier, Salas y Hernández Morán —este último futuro Jefe de División con la incorporación de la Oncología Clínica.

Más adelante se sumaron los Dres. Julio Sánchez, Rubén Lencina y Jorge Chiozza, actualmente Director Médico de un destacado centro. Junto al Dr. Navarrine se incorporaron también los técnicos físicos a cargo del manejo del equipamiento, entre ellos Jorge Danazzo, quien continuó trabajando en el servicio hasta hace pocos años; entre las técnicas se contaban Beatriz Blanc, Norma Cavo y Mónica Contartese, esta última activa hasta hace un par de años y hoy en un centro privado reconocido. En la década de 1990 el Hospital Naval donó una bomba de cobalto 60 theraton 80.

La Oncología Clínica fue creciendo de manera paulatina a medida que la especialidad se consolidaba. Ya en 1967, el Dr. Luis Schapira, clínico prestigioso del Hospital, junto al Dr. Hernández Morán y al Dr. Guzmán Machado, comenzaron a atender pacientes oncológicos en un consultorio de Cirugía. El Dr. Lucio Sanguinetti, distinguido maestro de la Clínica y la Semiología, creó el Comité de Tumores —que se reúne los viernes y continúa funcionando hasta la actualidad— junto con Imágenes; los Dres. Bar Salomón y Ricardo Rezzonico, reconocidos cirujanos del Hospital, comenzaron a realizar los primeros tratamientos de quimioterapia en el subsuelo donde funciona actualmente la División. Se incorporó entonces el Dr. Gustavo Botto, prestigioso oncólogo e inmunólogo formado en parte en el Institut Gustave Roussy de Villejuif, Francia, quien le dio un fuerte impulso a la Oncología Clínica del Hospital.

El Dr. Juan Carlos Hernández Morán fue el siguiente Jefe de la División, continuando con ambas especialidades —terapia radiante y oncología clínica— y conformando un equipo de trabajo junto al Dr. Juan Magnazco, proveniente de Hematología, y al Dr. Armando Méndez, hasta su jubilación. En 2008 ingresó por concurso la Dra. Alicia Elli como Jefa de División, quien continuó con ambas especialidades e incorporó la nueva rama de Cuidados Paliativos, dando jerarquía al Hospital de Día.

A partir de 2018 se creó la Residencia en Oncología Clínica y la Sede de la Carrera de Especialista de Oncología Clínica de la UBA, así como la Sección de Oncología. La División Terapia Radiante-Oncología Clínica de nuestro Hospital cuenta con una fortaleza diferencial frente a otros hospitales polivalentes: el tratamiento interdisciplinario del paciente oncológico, con evaluación conjunta de la oncología clínica, la radioterapia y los cuidados paliativos.

Agradecimiento: A la Dra. Alicia Elli, Jefa de División, por su colaboración en la redacción de este capítulo.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 41

Ortopedia y Traumatología

Entre las figuras fundacionales de la cirugía ortopédica vinculadas a nuestro Hospital se destaca Marcelo Julio Fitte (1895-1950), nacido en Buenos Aires, quien cursó sus estudios en el Colegio Lasalle y se graduó como médico en 1921, incorporándose de inmediato como Médico Agregado al servicio de Cirugía General del Profesor Marcelo Viñas en el entonces Hospital San Roque.

Diógenes Decoud (1863-1920), nacido en Asunción del Paraguay, llegó de niño al país; tras una breve incursión en el periodismo se inscribió en 1885 en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, fue interno de Ignacio Pirovano y obtuvo su título en 1891. Actuó en los hospitales Militar y Norte (hoy Juan A. Fernández), alcanzó el profesorado suplente de Medicina Operatoria en 1894 y, al año siguiente, de Clínica Quirúrgica. Al fallecer Julián Aguilar en 1903, ocupó la jefatura de servicio vacante en el Hospital San Roque hasta su retiro de la cátedra. El Prof. José Arce, su jefe de Clínica en 1904 y 1905, lo describió como "inteligente, con gran cultura general y médica, operador hábil, de palabra fácil y galana"; "bondadoso y por eso fue muy querido". Entre sus practicantes elegía a sus futuros colaboradores, destacándose los más tarde profesores Guillermo Bosch Arana, Delfor del Valle, Ricardo Donovan y Alfredo J. Buzzi. Dejó una extensa producción científica sobre cirugía general —entre otros, "Las fracturas de la pierna" (1891), "Cirugía de los huesos" (1892) y "El método de amputación" (1896)— y dirigió durante veinte años la revista "La Semana Médica". Al jubilarse en 1919 recibió un gran homenaje de colegas, amigos y discípulos.

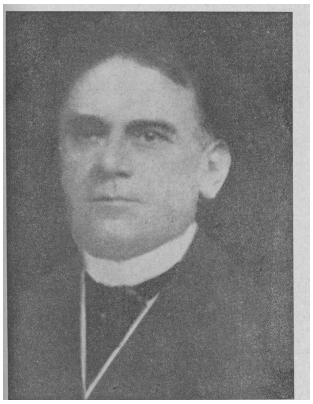


Figura 41.1: Prof. Dr. Diógenes Decoud, director del Hospital (1900-1920).

Pedro Chutro (1880-1937), notable cirujano general argentino y discípulo de Alejandro Posadas, tuvo una destacada actuación durante la Primera Guerra Mundial en París, donde

dirigió las trescientas camas de cirugía del Hospital Buffon, recibiendo el grado de Oficial de la Legión de Honor francesa y la Medalla por Servicios Distinguidos de los Estados Unidos. De regreso en Buenos Aires en 1919, dictó clases de Clínica Quirúrgica como titular de la tercera cátedra en los hospitales municipales Durand y Ramos Mejía. Su obra mayor, "Lecciones de Clínica Quirúrgica", en cuatro tomos, fue publicada póstumamente por su discípulo Ernesto Cornejo Saravia; en ella describió, con su estilo elegante y didáctico, los detalles del injerto óseo por deslizamiento, técnica que trece años más tarde Phemister reprodujo como propia.

La historia de la especialidad en nuestro Hospital está además ligada a la del Hospital Rawson: al cierre de este último, el Dr. Antonio Ego Grossi fue nombrado Jefe de División hasta 1989, sucedido por otro exresidente del Hospital Rawson, el Prof. Dr. Alberto O. Cáneva, quien además ocupaba uno de los seis cargos de Profesor Titular de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología. En la década de 1970, siendo Director el Dr. Luis Etchegoyen, se unificaron en la Sala 14, el 2 de mayo de 1971, los distintos departamentos de Ortopedia y Traumatología que funcionaban dentro de cuatro servicios de Cirugía General del Hospital: el Pabellón II (Sala 5 y 6, Jefe Néstor Turco), el Pabellón V (Sala 15, Jefe Diego Zavaleta), el Pabellón IX (Salas 20 y 21, Jefe Augusto Covaro) y el Pabellón Modelo (Jefe Roberto Garriz).

Desde la Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados, situada en el Pabellón II, llegó Eduardo Alfredo Zancolli con su equipo, integrado por Santiago Fazzini, Fredy Aponte Arrazola, Alberto Sanguineti, Juan Carlos Miller y Diego Fernández. De la Sala 20 partió en 1967 Modesto Estévez hacia nuestro Hospital, del que luego sería Jefe de Unidad y de División; desde la Sala XV partió en 1968 Jorge Romanelli hacia el Hospital Fernández, donde actualmente es Jefe de Unidad. Más tarde, en 1979, Juan Miller se trasladó desde la Sala 14 hacia nuestro Hospital, haciéndose cargo del Equipo de Cirugía de la Mano hasta noviembre de 2009. Los últimos Jefes de División fueron los Dres. Cáneva, Larralde y, en la actualidad, el Dr. J. Seveso.

Agradecimiento: Este capítulo ha sido redactado por la Dra. Mónica Fernández, a quien expresamos nuestro agradecimiento.

Capítulo 42

Otorrinolaringología

El primer servicio de Otorrinolaringología del país, la Sala IV, fue el de nuestro Hospital San Roque, cuyo Jefe entre 1886 y 1894 fue el Dr. Eduardo Obejero (1855-1928). Nacido en Buenos Aires y graduado como Doctor en Medicina en 1880, realizó poco después un largo viaje por Europa, donde estudió Oftalmología con Landolt y Louis de Wecker, y Otorrinolaringología con Charles Fauvel (1830-1895), pionero de la especialidad en Francia. A su retorno trabajó en el Hospital San Roque y luego en el Hospital de Clínicas; el 30 de abril de 1894 fue nombrado Profesor Titular de la Cátedra de Otología, Rinología y Laringología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, completando veinticinco años de labor hasta su jubilación en 1919; en 1914 fue nombrado Académico de la Academia Nacional de Medicina. Obejero tuvo numerosos alumnos, algunos de los cuales fundaron la Sociedad Argentina de ORL el 7 de junio de 1909, a instancias del Prof. Eliseo Segura; la primera reunión científica tuvo lugar dos semanas después en la casa del propio Obejero, su primer presidente. La primera Comisión Directiva quedó constituida por el Dr. Eduardo Obejero como Presidente, el Dr. Eliseo Segura como Vicepresidente y el Dr. Juan de la Cruz Correa como Secretario; en esa ocasión Obejero presentó el primer trabajo científico de la Sociedad, "Osteítis Silítica de la Base del Cráneo". Fue presidente de la entidad en 1909, 1912 y 1919, antes de trasladarse al Hospital de Clínicas hasta su jubilación.

Figura 42.1: Dr. Eduardo Obejero, fundador del primer servicio de Otorrinolaringología del país.

Figura 42.2: Consultorio de oídos, nariz y garganta del Hospital, 1910.

En nuestro Hospital lo sucedieron como Jefes de la Sala IV el Dr. Eliseo Segura, hasta 1918, y el Dr. Antonio Zambrini, entre 1919 y 1951. El Dr. Elías J. Aráuz, graduado en 1905, fue practicante en el Hospital San Roque y Jefe de Sala ORL en el Hospital Pirovano, iniciando la dinastía ORL Aráuz. El Dr. Antonio Zambrini, nacido en Formosa y graduado en 1909, fue alumno de Obejero y de Álvaro Newton en Buenos Aires y de J. Joseph en Alemania; Jefe de Clínica en el Hospital San Roque desde 1914 y luego Profesor Adjunto, Profesor Suplente, Profesor Extraordinario y Jefe de Servicio ORL de los Hospitales Ramos Mejía y Militar Central, creó escuela en nuestro Hospital, sede luego de la Segunda Cátedra, y fue además Director del Hospital. En 1929 era el Jefe de la Sala IV; entre sus alumnos se destacaron Jorge Zubizarreta, José Antonio Carrascosa, Eduardo Casterán, Manuel Cetrá y Atilio Viale del Carril. En 1941 presentó un audiómetro de su invención, junto con G. Ferrari Hardoy y J. Passarón.

Entre 1952 y 1955 lo sucedió el Dr. Antonio Carrascosa, y entre 1956 y 1966 el Dr. Carlos Marcandino; entre 1966 y 1974 fue Jefe del Servicio el Dr. Atilio Viale del Carril, designado luego Titular de la Segunda Cátedra de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la UBA. Desde 1974 hasta 1999, el Dr. Julio Zubizarreta ocupó la jefatura. En el servicio se desarrolló una técnica innovadora para otoesclerosis que se utiliza en todo el mundo. En la actualidad el Jefe del Servicio es el Dr. Amílcar Fiameni.

Un aporte de gran relevancia para la ORL argentina fue la realización, el 4 de diciembre de 1997, del primer implante coclear en el Hospital Ramos Mejía, hito que permitió ampliar el acceso a esta tecnología dentro del sistema de salud pública. Desde entonces, el Hospital ha continuado realizando implantes cocleares, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de numerosas personas con discapacidades auditivas en la Argentina.

Agradecimiento: Al Dr. Amílcar Fiameni, Jefe del Servicio, por su colaboración en la redacción de este capítulo.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 43

Pediatría

Para reseñar la historia de nuestro Servicio de Pediatría conviene repasar el contexto de su creación. Bajo la primera presidencia de Julio A. Roca (1880-1886), en el marco de un intenso proceso de medicalización, comenzaron a perfilarse nuevas especialidades médicas, configurándose e institucionalizándose la Pediatría como rama propia de la medicina. A fines del siglo XIX y comienzos del XX el Estado instauró un conjunto de medidas destinadas a la infancia y la maternidad, vinculadas a la propuesta higienista y a la elevada mortalidad infantil de la época.

En abril de 1875 se inauguró el Hospital de Niños "San Luis Gonzaga", siendo sus primeros médicos Ignacio Pirovano y H. Ramauge, y su primer practicante José M. Ramos Mejía. Coincidiendo con la inauguración de nuestro Hospital en 1883, se nombró al primer profesor de Pediatría de la UBA, el Dr. Manuel Blancas. En 1886 se inició la atención de Pediatría en nuestro Hospital, siendo el primer Jefe de Servicio el Dr. Facundo Larguía. En las décadas siguientes se destacaron Gregorio Aráoz Alfaro y Juan Carlos Navarro, quienes consolidaron la especialidad y constituyeron en 1911 la Sociedad Argentina de Pediatría; nuestro Hospital se convirtió en el primer hospital asociado a la UBA, contribuyendo a la formación de profesionales que dieron prestigio mundial a la medicina argentina en las primeras décadas del siglo XX. Hacia 1920 eran cuatro los centros de atención pediátrica de la ciudad: el Hospital Gutiérrez, el Hospital de los Expósitos (1905), el Hospital de Clínicas y el nuestro, ya reconocido como Hospital Ramos Mejía.

En 1929 la Sala II de Clínica Pediátrica estaba a cargo del Prof. Dr. Juan Carlos Navarro, Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría entre 1921 y 1923, Profesor Adjunto de la Facultad de Medicina y miembro de la Academia Nacional de Medicina, quien publicó junto al Dr. Florencio Bazán, en 1927, el volumen "El lactante. Alimentación y nutrición", guía muy valiosa en su

Figura 43.1: Placa en homenaje al Prof. Juan Carlos Navarro, en el patio del Hospital (1937).

época. Una placa lo recuerda en la plaza central del Hospital desde 1937.

El siglo pasado trajo avances significativos: la irrupción de los antibióticos, el desarrollo de las vacunas, los progresos en nutrición infantil y la apertura hacia nuevas subespecialidades. El servicio contó con profesionales como Raúl Cibils Aguirre, gran propulsor de la vacuna antidiftérica y autor de libros clásicos como "Tuberculosis en niños" y "Lúes Innata" (1930-1939); en los años cuarenta inició su actividad el Dr. Rodolfo Kreutzer, quien luego desarrollaría la cardiología infantil en el Hospital Gutiérrez.

Figura 43.2: Galería y corredor de niños del Hospital, 1910.

Hasta la década de 1950 el cuidado de los niños internados estaba a cargo de nodrizas o religiosas, y las madres solo podían visitarlos dos horas al día; fue el Dr. Florencio Escardó quien instauró la internación conjunta en la Sala 17 del Hospital Gutiérrez, modalidad que se expandió y que sigue vigente hoy. En los años cincuenta y sesenta nuestro servicio adhirió a la reformulación de la atención integral del niño mediante programas organizados según sus necesidades.

La Residencia de Pediatría surgió a fines de los años cincuenta, cristalizando un proyecto del Dr. Carlos Gianantonio; nuestro servicio se sumó a la formación de pediatras y, tras un paréntesis, con la llegada del Dr. Pizzia como Jefe de Unidad se retomó la formación de residentes, misión que continúa de forma ininterrumpida y que hoy es sede de la Carrera de Especialista de la UBA. En la década de 1980 se inició el grupo dedicado a la atención de adolescentes, precursor del actual Consultorio de Adolescencia.

Figura 43.3: Sala de niños del Hospital, 1910.

El Servicio funcionó originalmente en un pabellón sobre la calle Venezuela, demolido durante la intendencia de Cacciatore para dar lugar a un estacionamiento, trasladándose entonces al actual pabellón de quirófano central. Hasta comienzos de los años noventa la sala de internación funcionaba donde hoy se encuentran el Servicio de Salud Mental y el Vacunatorio, mudándose luego a su emplazamiento actual con el cierre de la Sala de Geriatría; en ese mismo período comenzó el servicio de guardia de Neonatología, hasta entonces a cargo de los propios pediatras.

En la primera década de este siglo, Pediatría consolidó su presencia en la atención ambulatoria, siendo el único hospital con horario de atención de 8 a 20 horas, y lidera la estadística de Pediatría entre los hospitales generales de agudos, detrás de los monovalentes. Bajo la gestión del Dr. Hugo Pandullo como Jefe de Servicio se sumaron las subespecialidades de Neumonología, Neurología, Genética, Oftalmología, Cardiología, Hebeatría, Psicología, Psiquiatría Infantil, Ginecología Infantojuvenil, Nutrición, Dermatología, Ecografía y Neurodesarrollo.

En la actualidad el servicio dispone de veinticuatro camas de internación y guardia pediátrica con tres pediatras por día, además de shock-room, sumándose un pediatra adicional durante la temporada de enfermedades respiratorias. Tras la pandemia de COVID-19 se anexaron cuatro consultorios, y en 2023 el grupo de trabajo de adolescencia se categorizó como Sección, con cuatro subespecialistas.

Agradecimiento: A la Dra. Fátima Díaz, con la colaboración de los Dres. Hugo Pandullo, A. Ciardullo y M. Risso, por la redacción de este capítulo.

Capítulo 44

Promoción y Protección de la Salud

La vacunación tiene en la Argentina una larga historia. La primera vacuna, la antivariólica desarrollada por Edward Jenner en 1796, llegó a Buenos Aires de la mano del padre Saturnino Segurola, primer adalid de la vacunación en el país; tras la Revolución de Mayo, el Cirujano Mayor Cosme Argerich impulsó la vacunación masiva de las tropas, considerada la primera política pública de vacunación nacional. En 1886 se aprobó la Ley de Vacuna Obligatoria, que dispuso campañas gratuitas contra la viruela —enfermedad erradicada del mundo recién en 1980— con puntos de vacunación en escuelas, instituciones públicas y hospitales de Buenos Aires; es muy probable que el Hospital San Roque (actual Ramos Mejía) haya tenido un papel clave en esas acciones. De hecho, entre las funciones del practicante figuraba, en las primeras décadas del siglo XX, un tiempo dedicado a vacunar con la antivariólica en las casas del barrio, tras lo cual ascendía a practicante de laboratorio. El éxito de estas campañas fortaleció la infraestructura de los vacunatorios hacia 1930, que con el tiempo se expandieron administrando nuevas vacunas; en años recientes, las campañas contra el COVID-19 y el control del dengue han honrado esa tradición del Hospital.

Durante las primeras décadas del siglo XX, la transición del higienismo al sanitarismo jerarquizó, junto a la vacunación, otras prácticas preventivas dirigidas a las personas sanas dentro de un enfoque de atención primaria. Así surgieron en los hospitales las Divisiones de Promoción y Protección de la Salud (PyP), cuya misión es coordinar los programas preventivos destinados a la comunidad en condiciones de equidad, eficacia y sustentabilidad. Entre sus áreas se cuenta el control de salud, que cuida la salud de los profesionales del Hospital, capacita a los equipos, realiza vigilancia epidemiológica intrahospitalaria y administra las vacunas obligatorias del Calendario Nacional de Vacunación, con la imprescindible colaboración del equipo de enfermería. En nuestro Hospital, la División de Promoción y Protección de la Salud se integra en el Departamento del Área Programática, a cargo, desde 2025, del Dr. Marcelo Ghioldi.

Medicina del Deporte

A principios de los años sesenta se creó un servicio de Medicina del Deporte, a cargo del Dr. Blanco, de Cardiología, que funcionaba en un sótano sin sala de espera, donde los pacientes aguardaban sentados en las escaleras; allí se realizaban los aptos físicos obligatorios, como los exigidos a los boxeadores profesionales. A mediados de los años noventa el servicio se institucionalizó como Unidad, dependiente del Área Programática, y emprendió un estudio sobre la evolución del peso, la talla y la alimentación de los niños de la Ciudad de Buenos Aires desde 1900, publicado en 2002 como el libro "Un siglo de Salud Escolar en la Ciudad de Buenos Aires". Su colaboración con el Teatro Colón —única en el mundo entre un hospital público y una institución de semejante prestigio— permitió realizar en 1993 la primera antropometría de la historia en bailarines de élite, con el método de fraccionamiento de masas corporales del Dr. William Ross, quien visitó el Hospital en 2003; la experiencia dio lugar al libro "La Salud en Danza". Tras evaluar a más de 1700 alumnos de escuelas públicas y 350 de danza, y extenderse a otras instituciones, el servicio se constituyó en un centro de referencia nacional en Salud en Danza, único de su tipo en el ámbito del Gobierno de la Ciudad.

Cesación tabáquica

En 1998, la Dra. Marta Angueira, cardióloga, comenzó a formar grupos de pacientes tabaquistas para acompañarlos en su cesación. El trabajo se institucionalizó luego como grupo de Prevención y Control del Tabaquismo, con la meta de "Hospitales libres de humo", impulsando encuestas de opinión, charlas de concientización y estudios sobre la concentración de humo y nicotina en distintos ambientes de la Ciudad. El grupo participó activamente en las campañas legislativas que culminaron, en diciembre de 2005, con la sanción de la Ley N.º 1799 de Control del Tabaco de la Ciudad de Buenos Aires; en 2008 el Hospital Ramos Mejía se declaró oficialmente libre de humo y, en 2010, la Ley N.º 3718 convirtió a la ciudad en un espacio 100 % libre de humo.

Agradecimiento: a los profesionales de la División de Promoción y Protección de la Salud que colaboraron en la redacción de este capítulo.

Capítulo 45

Psiquiatría y Salud Mental

La historia del Servicio de Salud Mental del Hospital está estrechamente ligada a los avatares políticos y sociales del país, así como a los movimientos teóricos de la especialidad y su influencia en la Universidad de Buenos Aires. Puede organizarse en tres momentos: uno neuropsiquiátrico, uno social y uno moderno.

En 1876 Lucio Meléndez, vinculado al cuerpo docente de la Facultad de Medicina, fue designado director del Hospicio de las Mercedes; el crecimiento de la población internada generó quejas por falta de espacio, por lo que cincuenta pacientes fueron trasladados al Hospital San Roque. La psiquiatría de nuestro Hospital nació unida a la neurología: la Cátedra de Enfermedades Nerviosas, creada en 1887 y ganada por concurso por el Dr. José María Ramos Mejía —cuya historia se reseña en el capítulo de Neurología—, desarrolló sus actividades en el Servicio a su cargo en el Hospital San Roque, con una enseñanza esencialmente práctica, a la cabecera del enfermo. Herederas de la escuela francesa, Neurología y Psiquiatría se asociaban entonces estrechamente, casi sin diferenciarse.

En la obra escrita de Ramos Mejía, su faceta de escritor y psiquiatra terminó sobrepasando a la de neurólogo, y fue la expresión más brillante del positivismo argentino. José Ingenieros se desempeñó como jefe de trabajos prácticos de la cátedra; sus libros más sociológicos —"Las fuerzas morales", "El hombre mediocre", "Sociología Argentina", "Los tiempos nuevos"— fueron lectura obligada de varias generaciones de argentinos y mostraban ya diferencias con el pensamiento de Ramos Mejía.

Figura 45.1: Prof. Dr. José Ingenieros (1877-1925).

Ingenieros (1877-1925), tras finalizar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires, fundó en 1892 el periódico "La Reforma" y al año siguiente ingresó a la Facultad de Medicina, donde se recibió de farmacéutico en 1897 y de médico en 1900 con su tesis "Simulación en la lucha por la vida". En 1903 la Academia Nacional de Medicina lo premió por "Simulación de la locura". Fue nombrado jefe de la Clínica de Enfermedades Nerviosas de la Facultad de Medicina, y en 1904 ganó la suplencia de la cátedra de Psicología Experimental en la Facultad de Filosofía y Letras; ese mismo año fue nombrado médico agregado de las salas 5 y 6 de Enfermedades Nerviosas del Hospital San Roque, inauguradas y dirigidas por Ramos Mejía, junto a quien adquirió saber práctico y teórico sobre la clínica de la histeria, escribiendo en ese contexto "Los accidentes histéricos y las sugestiones terapéuticas". Años después incorporaría los aportes de Sigmund Freud como referente en relación a la histeria, propiciando las primeras lecturas freudianas en la Argentina.

En 1949, siendo decano de la Facultad de Medicina el Dr. José Arce, se separaron las cátedras de Psiquiatría y Neurología, quedando el Dr. José T. Borda a cargo de Psiquiatría y el Dr. Raúl Materón a cargo de Neurología. La separación de los servicios de Neurología y Psiquiatría dentro de nuestro Hospital ocurrió en 1967, con la creación del sistema de residencias médicas en la Argentina; según una leyenda no comprobada, se presentó al concurso de Jefe de Servicio de Psiquiatría el Dr. Mauricio Goldemberg, creador del "Plan Goldemberg", que postulaba la creación de Servicios de Psicopatología en hospitales generales y centros periféricos de Salud Mental —siendo el primero el Centro de Salud Mental Ameghino (1948), dependiente de nuestro Hospital. El concurso fue finalmente ganado por la Dra. Blanca Montevechio, quien logró una importante relación con psicólogos de la Facultad de Psicología de la UBA, que concurrían inicialmente como alumnos y luego pasaban a integrar el plantel. El Dr. Dante Graña se ocupaba de los pacientes con alcoholismo, contando el Servicio con diez camas para su internación, además de acompañar a Montevechio en la gestión; el Dr. Eduardo Brair realizaba terapias breves y el Dr. Héctor

Cracoff acciones comunitarias en los domicilios de la zona. El servicio se caracterizó por dividir la atención según grupos etarios y por recibir a los pacientes mediante un equipo de admisión integrado por trabajadoras sociales.

El Servicio fue disuelto en 1978, dejándose cesante a la Dra. Montevechio junto a otros cuatro profesionales, mientras el resto se trasladaba al Centro de Salud Ameghino. Durante este período, en el Servicio de Clínica Médica, un médico comenzó a interesarse en lo que entonces se llamaba enfermedades psicosomáticas, sin relación con el servicio de Montevechio. Tras la disolución, el Dr. Ezra Intebi, ya psiquiatra, formó con un grupo de psicólogos un equipo que, además de atender las enfermedades psicosomáticas, comenzó a ocuparse de las interconsultas generadas en los distintos servicios del Hospital, impulsando ateneos y la creación de una cátedra de Psiquiatría en la UBA a cargo del Dr. Roberto Losso.

Gracias a la intervención del entonces Secretario de Salud Mental de la Ciudad, Dr. Soriano, y de la Asociación de Médicos Municipales —a través del Dr. Juan Borria—, el equipo fue reconocido como Sección de Psicopatología a cargo del Dr. Ezra Intebi, registrando desde entonces un constante aumento de prestaciones. A la jubilación de Intebi le sucedió la Dra. Silvia Fernández, quien continuó en el cargo hasta su propia jubilación, momento en que se hizo cargo de la Sección de Salud Mental la actual gestión del Dr. Adolfo Panelo.

Agradecimiento: Al Dr. Adolfo Panelo, por su colaboración en la redacción de este capítulo.

BORRADOR — NO DISTRIBUIR

Capítulo 46

Reumatología

El 11 de abril de 1989, tras la jubilación del Dr. Alberto Gesino, reumatólogo, se designó por concurso al Dr. Eduardo Mario Kerzberg, becario en el área de Colagenopatías, como médico asistente en Reumatología del Hospital. A partir de esa fecha se organizó la actividad asistencial, docente y de investigación de la especialidad, y el 18 de mayo de 1990 se creó el Grupo de Trabajo de Reumatología y Colagenopatías, bajo la coordinación del Dr. Kerzberg.

La actividad asistencial se organizó inicialmente mediante dos consultorios semanales de dos horas, los días martes y jueves, en el actual consultorio 122 del primer piso de consultorios externos, además de interconsultas con los distintos servicios del Hospital; la mayoría de los pacientes reumáticos se internaba en las salas de Clínica Médica, ya que el servicio nunca contó con sala de internación propia. En la actualidad dispone de doce consultorios externos que atienden de lunes a viernes en horario matutino y vespertino, recibiendo pacientes de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano, el resto del país y países limítrofes. Se organizaron Clínicas de Artritis Reumatoidea, Lupus Eritematoso Sistémico, Esclerosis Sistémica, Artritis Psoriática, Enfermedades Cristálicas, Artritis Temprana y Vasculitis, todas dirigidas por profesionales formados en el propio centro.

En el plano docente, en 1989 se inició el Curso Anual Teórico-Práctico de Reumatología y Enfermedades del Tejido Conectivo, dirigido en sus comienzos junto al Dr. Efraín Huberman, Jefe de Clínica Médica, y sostenido durante más de treinta años, interrumpido solo en 2020 por la pandemia. A partir de 1991 se cubrieron los primeros cargos para médicos concurrentes y becarios; en 1994 el Dr. Víctor Hoyos Ibáñez se convirtió en el primer médico reumatólogo formado en el servicio. El 30 de noviembre de 1995 la Facultad de Medicina de la UBA aprobó la apertura de la Unidad Académica de la Carrera de Médicos Especialistas en Reumatología en el Hospital, iniciándose la primera cursada el 1 de julio de 1996 con nueve alumnos. En 1997 se realizaron en la Facultad de Medicina las “Primeras Jornadas de Problemas Prácticos en Reumatología”, organizadas por el servicio, dando inicio a una tradición de eventos científicos anuales con invitados nacionales

e internacionales. En 1998 se instaló el primer densitómetro óseo de un hospital público municipal, a cargo del servicio. Desde 1999 la Municipalidad otorgó al servicio una vacante anual de residencia, cubierta inicialmente por la Dra. Adriana Yochler, quien se convertiría en la primera Jefa de Residentes de la especialidad; actualmente se cuenta con dos vacantes dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En 2000 la Municipalidad designó al servicio Centro de Referencia en Osteoporosis y organizador del programa de prevención de osteoporosis y fracturas de cadera, designación que se amplió en 2001 a nivel nacional. En 2004 la Facultad de Medicina aprobó la creación del centro de osteoporosis y enfermedades osteoarticulares, designando al Prof. Eduardo Mario Kerzberg como director; ese mismo año la Dra. Elisa Gazze se convirtió en la primera reumatóloga en formación del servicio en realizar una rotación en el extranjero, en la Universidad de California. En 2006 la Facultad de Medicina creó el centro de farmacología clínica e investigaciones clínico-farmacológicas, designando nuevamente al Prof. Kerzberg como director. A lo largo de sus primeras tres décadas y media, el proceso de formación de posgrado ha generado más de ciento cinco reumatólogos argentinos, provenientes de todas las regiones del país, además de profesionales de Bolivia, Ecuador, Brasil y Colombia.

La investigación se inició en 1989 a través de becas del CONICET y se ha mantenido desde entonces, con proyectos propios y en colaboración con otros centros que han generado cientos de publicaciones y presentaciones en congresos. En 1998 se creó la Unidad de Investigación Clínica en Reumatología, reformando un viejo depósito de la planta baja de Clínica Médica; desde el año 2000 se desarrollan proyectos de investigación clínica de nuevos fármacos, y en 2004 se organizó el Curso de Monitoreo e Investigaciones Clínicas y Farmacológicas en la Facultad de Medicina. Hoy el servicio de Reumatología del Hospital Ramos Mejía es, en su especialidad, el más grande del país en cantidad de médicos, tecnología instalada e investigación: más de tres décadas de trabajo y dedicación han permitido construir, partiendo de la nada, una escuela de Reumatología argentina y un centro de referencia que sigue guiando a pacientes y médicos.

Agradecimiento: A los Dres. Eduardo Kerzberg y Gabriel Sequeira, por la redacción de este capítulo.

Capítulo 47

Servicio Social

El 2 de septiembre de 1931, Mary Surano —en ese entonces Visitadora Social— fue nombrada, por disposición del Dr. José Beruti, Director de la Clínica Obstétrica y Ginecológica "Eliseo Cantón" del Hospital, como la primera profesional en esta área. Posteriormente, la actividad de las profesionales que se desempeñaban en los dispensarios y en el Servicio de Cardiología fue centralizada por el Dr. Rómulo Repeto, a cargo de la Dirección de Cardiología; al asumir éste como Director del Hospital, designó al Dr. Daiello como Jefe de las profesionales, quien asignó los espacios de trabajo en las distintas salas. Al jubilarse Daiello, Marta Salvioli, proveniente del Hospital Álvarez, asumió como Jefa de Servicio Social, renunciando al año siguiente.

En 1962 las profesionales acordaron la designación de la Visitadora Social María Luisa Fernández Fariña como primera Jefa de Servicio Social, cargo que ocupó hasta 1978, período en que la División dependía directamente de la Dirección del Hospital. Le sucedió Elsa Marcos de Schiaritti hasta 1982, y a su jubilación asumió la Visitadora Social Haydée Margarita Rivera de Bertani hasta 1994, período en que la dependencia orgánica del Servicio Social pasó al Departamento Técnico. En 1987 se sancionó la Ley de Ejercicio de la Profesión del Servicio Social o Trabajo Social en la Ciudad de Buenos Aires, que regula la actividad hasta la actualidad. La Lic. María Mercedes Morbidoni de Quintana accedió luego a la jefatura por concurso de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud; a principios de 1996 se amplió el organigrama de la División con la creación de las Jefaturas de Sección Internación y de Sección Consultorio Externo, cubiertas en 1997 por concurso por la Lic. Hilda Inés Horn y la Lic. Marta Beatriz Sverdín, respectivamente. Por distintos períodos integraron el Servicio Social las licenciadas y licenciados A. Borghiani, G. García Rocca, S. Maranggio, O. Cuvez Báez, M. E. Pavía, I. Sujeros, G. Steiner, L. Scalora, H. Rodríguez, M. Martínez, S. Bottini, S. Lobos, P. Albertano, P. Gordillo y N. Civiello.

A la jubilación de la Lic. Morbidoni de Quintana asumió como Jefa de la División la Lic. María Angélica Capellino. Actualmente la División Servicio Social continúa dependiendo del Departamento Técnico, a cargo de la Profesora Dra. Claudia Negri; integran el plantel

profesional la Lic. Marta Celia Fernández (Jefa de Sección Consultorio Externo), la Lic. Graciela Patricia Dejistani (Jefa de Sección Internación) y las trabajadoras sociales Lic. Daniela Altavilla, Lic. Florencia Cohen Arazi, Lic. Natalia David, Lic. Cecilia Domínguez, Lic. Andrea Gianninoto, Lic. Fabiana Jiménez, Lic. Andrea Merlino, Lic. Luana Pontelli, Lic. Lorena Puente, Lic. Estefanía Romero, Lic. Romina Saraceni y Lic. Daniela Teveles.

El objetivo general de la División Servicio Social se centra en intervenir en las problemáticas sociales complejas desde una mirada integral, en aquellas situaciones que inciden e impactan en el proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado de las personas usuarias del sistema público de salud, abordando los procesos de trabajo desde una perspectiva globalizadora, interdisciplinaria e intersectorial, con el objetivo de restituir los derechos vulnerados. En el área de internación, el trabajo se organiza en dos grandes grupos: Materno-Infantil (Pediatría, Obstetricia y Neonatología) y Adultos Jóvenes y Adultos Mayores (Clínica Médica y servicios de especialidad), acompañando a las personas y a su red socio-afectiva durante la internación. En el área de consultorio externo, el trabajo se centra en la escucha activa, orientación, asesoramiento, derivación y acompañamiento de las problemáticas presentadas, organizándose diariamente entre atención espontánea y programada. Ambas áreas confluyen además en actividades promocionales, grupales y colectivas, intra y extramurales, y la División participa en los distintos comités hospitalarios y en actividades de formación de pre y posgrado.

Agradecimiento: A las Licenciadas María Angélica Capellino, Graciela Patricia Dejistani y Marta Celia Fernández, por su colaboración en la redacción de este capítulo.

BORRADOR NO DEFINITIVO

Capítulo 48

Terapia Intensiva

La aparición de las Unidades de Terapia Intensiva estuvo ligada a la segunda pandemia del siglo XX: la de poliomielitis. Buenos Aires fue la segunda ciudad del mundo con más de 6000 niños infectados, y se hizo necesario crear un lugar para atenderlos. El Dr. Aquiles Roncoroni regresó entonces de los Estados Unidos, adonde había viajado en 1952 para trabajar en el laboratorio del Dr. Comroe, en la Universidad de Filadelfia (Pensilvania), por entonces el más importante del mundo en fisiología respiratoria. El Ministerio de Salud le encargó armar treinta y nueve pulmones de acero ("iron lung") y reconvertir el antiguo dispensario de tuberculosis en el Centro de Rehabilitación Respiratoria "María Ferrer", en el barrio de Barracas, entrando por la antigua calle Patagones —hoy Finochietto—, a la vuelta del Hospital Casa Cuna. Roncoroni fue su primer director. Allí nació la Terapia Intensiva en nuestro país.[60]

Pasada la pandemia de poliomielitis, pronto se empezó a jerarquizar en los hospitales la necesidad de especialistas en el cuidado del paciente en situaciones de inestabilidad hemodinámica y emergencia, en los cuidados complejos postoperatorios y en el manejo del paciente en respirador o en diálisis. En 1973, la Asociación Argentina de Cirugía invitó a los Dres. Lorenzano y Rubianes a dar una conferencia —que luego generó un manuscrito— sobre la "Organización y Funcionamiento de las Unidades de Terapia Intensiva" (UTI) en nuestro país. Allí figuran dos referencias de terapias modelo: la del Instituto de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas "José de San Martín" y la evolución de la Sala 7 de nuestro Hospital hacia la Sala de Recuperación de Quirófanos, a partir de la situación sanitaria del país en 1957 por la epidemia de poliomielitis. El trabajo estudiaba nueve modelos de UTI en cuanto a su distribución arquitectónica, y mostraba el de nuestro Hospital para esa época.

En 1964 se organizó la Unidad de Recuperación Posquirúrgica del Hospital, creada por el Prof. Dr. Jorge Sánchez Zinny, Jefe del Departamento de Cirugía. Estuvo dirigida en un principio por el Dr. Gerardo Lorenzano, y pertenecía a ella la Dra. Ofelia Miseta, quien entrenó intensivamente a la Residencia de Cirugía. A raíz de los avances del conocimiento

médico, en 1968 se incorporó una Unidad Renal, ya que eran muy pocos los lugares donde se realizaban hemodiálisis y diálisis peritoneal para pacientes agudos; se contaba con dos riñones artificiales de placa diseñados por el Dr. Manuel Calvo. Entre el 1.º de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1976 se dializaron 163 pacientes por insuficiencia renal aguda, cuya causa más frecuente fue el aborto séptico (32,5 %). En el cuarto piso del pabellón quirúrgico se construyó un área de quirófanos centrales y una sala de Terapia Intensiva.

En 1974, la Unidad de Recuperación Posquirúrgica se convirtió en Unidad de Terapia Intensiva Polivalente. En 1979 se llamó al primer concurso de Jefatura de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que ganó el Dr. Roberto Padrón; la Unidad pasó a depender del Departamento de Medicina Interna y Cirugía de Urgencia. Los médicos de guardia eran, al principio, los residentes que rotaban por el área; en 1980 se nombraron médicos de planta con cuarenta horas semanales de prestación asistencial, que incluían una guardia semanal y domingos rotativos. En mayo de 1986, el Dr. Daniel Elisabe fue elegido Instructor de Residentes, incorporándose a la primera Residencia de UTI del entonces Gobierno de la Ciudad, que duró pocos años; con la llegada de los jóvenes se estimuló la participación en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.

El Dr. Miguel Kalaydjian asumió luego la jefatura, secundado por los Dres. Hourman y Maffioli y la Dra. Garibotti, entre otros. A principios del siglo XXI, bajo la jefatura del Dr. Juan Pablo Rossini, se reequipó el servicio y se lo incorporó a la Carrera de Médico Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva de la UBA. Desde el año 2015 asumió la Jefatura el Dr. Daniel Prieto, quien continúa en la actualidad. En 2016 se reinauguró la Residencia —incorporando a los jóvenes egresados— y se realizaron reformas edilicias que llevaron la dotación a diez camas, con equipamiento tecnológico de avanzada. En 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19, se efectuó una nueva reforma edilicia y se creó una Terapia Intensiva de seis camas de presión negativa con boxes, además de las diez camas operativas del servicio.

Agradecimiento: A los Dres. Alejandro Muñoz, Daniel Maffei, Pablo Rossini y Daniel Prieto, por la redacción de este capítulo.

Capítulo 49

Urología

Por haberse instalado en el Hospital San Roque el primer Servicio de Urología del país, resulta de interés mantener vivo el recuerdo de quienes se desempeñaron como Jefes hasta nuestros días. En aquella época, los pacientes con patología renal eran intervenidos en la Sala de Cirugía General, cuyo titular era el Profesor Dr. Julián Aguilar; la Urología surgió como especialidad recién en la última década del siglo XIX, ya que hasta entonces se mezclaba con la venereología en la atención de los pacientes urinarios. El Dr. Alberto Castaño se destacó en la urología argentina a través de cincuenta años de vida profesional, cimentando la cirugía de la próstata en el país. Al inaugurarse el Hospital San Roque en 1883 fue designado Jefe de la Sala 7 de enfermedades venereosifilíticas, donde también se recibían enfermos urinarios; a partir de 1892, con la creación de la Cátedra de Dermatosifilografía, quedó como Jefe del primer Servicio de Urología del país, en la Sala 10. Introdujo la prostatectomía por vía perineal —operación de Proust y Albarrán— realizándola por primera vez en 1900 en una serie de cuarenta intervenciones; desde 1904 practicó la prostatectomía suprapúbica, siendo durante años el único cirujano de Sudamérica que la utilizaba, técnica que dio a conocer en Chile en 1908. Representó a la ciencia argentina en diversos congresos internacionales, fue delegado del Gobierno argentino en la conferencia de París de 1912 y miembro adherente de la Sociedad Argentina de Urología desde su creación en 1923. Era partidario de "extirpar la próstata en block, es decir por lóbulos completos". Falleció en Buenos Aires el 6 de agosto de 1931, y en 1933 se colocó una placa recordatoria con su nombre en la Sala de Urología del Hospital.

Figura 49.1: Placa en homenaje al Dr. Alberto Castaño.

Le siguió el Dr. Gilberto Elizalde, destacado discípulo de Castaño, quien obtuvo el doctorado en 1906 con una tesis sobre el tratamiento quirúrgico de la hipertrofia de próstata y, tras un viaje de estudios a Europa, ingresó al Servicio de Enfermedades Genitourinarias

del Hospital San Roque en 1913, siendo designado Jefe de la Sala X de Urología el 22 de mayo de 1919 hasta su muerte el 12 de enero de 1944. Le sucedió el Dr. Alejandro Astraldi, designado Jefe de la Sala X en 1945, investigador y estudioso de carácter temperamental que contribuyó a la evolución de la especialidad en el país, hasta su fallecimiento el 25 de agosto de 1965. El Dr. Antonio Elizalde, primo de Gilberto Elizalde, fue designado Jefe Interino al jubilarse Astraldi en 1964, quien falleció el año siguiente, el 25 de agosto de 1965, hasta su propia jubilación en 1969.

El Dr. Miguel Luis Podestá, practicante agregado de Cirugía General y luego concurrente de la Sala de Urología, fue designado Médico Asistente rentado en enero de 1952 y se desempeñó como Jefe Interino en dos oportunidades: de enero de 1969 a agosto de 1970, y de agosto de 1975 hasta su jubilación en 1976. El Dr. Juan Bernardo Larroude, doctorado en 1934 y designado Médico Asistente por concurso en 1935, fue Jefe Interino desde septiembre de 1970 hasta su jubilación en 1975, sucedido por Podestá. El Dr. Baldomero Satorre, designado Médico Asistente en 1947, se desempeñó como Jefe de la Unidad Urología desde 1976 hasta marzo de 1980.

A partir de esa fecha asumió el Dr. Juan Carlos Irazu, instructor de los primeros residentes de Urología municipal en el Hospital Penna entre 1969 y 1971, designado Médico Asistente Titular por concurso del Hospital Ramos Mejía desde abril de 1973 y Jefe Titular de la Unidad Urología desde marzo de 1980; en enero de 1982 la Unidad pasó a ser División, asumiendo Irazu como Jefe de División Titular. Fue Profesor Regular Adjunto de Urología de la Facultad de Medicina, encargado docente de la unidad hospitalaria desde 1975 —año en que se instaló la Residencia en la División, en mayo de 1983—, autor de numerosos libros, Presidente de la Sociedad Argentina de Urología en 1990, miembro de la Sociedad Internacional de Urología y distinguido como "Urólogo Maestro" de la SAU en 2003; se jubiló el 10 de julio de 2006. El Dr. Juan Carlos Cipitria, médico de planta y miembro titular de la SAU, fue Jefe de División Interino entre 1993 y 1997, reemplazando a Irazu mientras este se desempeñaba como Jefe de Departamento Quirúrgico.

El siguiente Jefe fue el Dr. Sergio de Miceu, entre 2007 y 2023, quien introdujo en el servicio la cirugía laparoscópica, la cirugía percutánea y la endourología para el tratamiento de la litiasis urinaria, así como el consultorio de Neurourología; docente asociado de la UBA, de la Universidad del Salvador y de la Universidad Austral, fue coautor del "Manual de Instrumentación Quirúrgica en Urología" (1994, con Jorge Esquivel) y del "Manual de Urología" (junto al Prof. Juan Carlos Irazu y Néstor O. Katz, ediciones de 2000 y 2001).

En la actualidad, el Dr. Juan Ignacio Ramos Suppicich se desempeña como Jefe de División de Urología.

Agradecimiento: A los Dres. Juan Ignacio Ramos Suppicich y Julián Salas, por su colaboración en la redacción de este capítulo.

Capítulo 50

Premios Nobeles que trabajaron en nuestro Hospital

Dos figuras de la ciencia argentina distinguidas con el Premio Nobel pasaron, en distintos momentos de sus carreras, por las salas de nuestro Hospital, dejando una huella que el correr de las décadas no ha borrado.

Luis Federico Leloir (1906-1987)

Bioquímico, farmacéutico y médico formado en la Universidad de Buenos Aires, Luis Federico Leloir se desempeñó como practicante del Hospital Ramos Mejía desde 1929, años en los que también creó la Sociedad de Investigación Ramos Mejía. Vivía entonces cerca de su prima Victoria Ocampo, cuñada del Dr. Carlos Bonorino Udaondo, Jefe de la Sala XV del Hospital, junto a quien trabajó entre 1931 y 1933. Durante ese período presidió, durante dos años, la Revista de la Asociación de Médicos Practicantes. Más tarde se trasladó, junto a Udaondo, al Hospital de Clínicas, donde en 1933 conoció al Dr. Bernardo Houssay, quien dirigió su tesis sobre las glándulas suprarrenales.

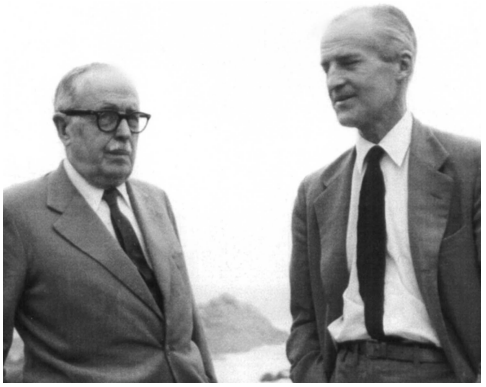


Figura 50.1: Bernardo Houssay (izq.) y Luis Federico Leloir. *Fuente: Repositorio Institucional CONICET Digital.*

En 1970 Leloir recibió el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar y su papel en la biosíntesis de los carbohidratos.

Bernardo A. Houssay (1887-1971)

Bernardo Alberto Houssay se graduó de farmacéutico a los diecisiete años y de médico a los veintitrés, en 1910. Fue practicante de nuestro Hospital hasta 1913, año en que pasó a desempeñarse como Jefe de Clínica en el Hospital Alvear. En 1919 creó el Instituto de Fisiología, desde el cual desarrolló la investigación que lo convertiría, en 1947, en el primer científico argentino en recibir un Premio Nobel —el de Medicina, por sus trabajos sobre la hipófisis y el metabolismo de la glucosa—. Cabe destacar que una nieta de Houssay se desempeña en la actualidad como médica de planta del Servicio de Nutrición de nuestro Hospital, cerrando de manera singular el círculo entre su legado científico y la vida cotidiana de la institución.

Los Bioterios del Hospital

A lo largo de su historia, distintos servicios del Hospital contaron con bioterios propios, destinados a la investigación con animales de laboratorio, hoy en su mayoría desaparecidos: el Bioterio de Cardiología, ubicado en el tercer piso del Pabellón Inchauspe, donde se alojaban conejos, cerdos y perros utilizados para la disección del Haz de His; el Bioterio de Cirugía, en el subsuelo de Anatomía Patológica, con cuarenta jaulas de ratas Wistar; el Bioterio de Dermatología; el Bioterio de la Maternidad, en el tercer piso; y el Bioterio de Parasitología. Estos espacios, hoy borrados de la planta física del Hospital, testimonian una época en que la investigación experimental con animales formaba parte habitual del trabajo cotidiano de varios servicios.

BORRADOR

Capítulo 51

Facultad de Ciencias Médicas UBA

El Hospital Ramos Mejía fue el primer Hospital Asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Por sus salas pasaron, entre muchos otros, un Rector de la Universidad de Buenos Aires —el clínico Dr. Waldorp— y Decanos de la Facultad de Medicina como el Dr. Eliseo Cantón, padre de la Obstetricia en la Argentina; Rafael Bullrich, médico clínico y Jefe de la Sala XII, hoy actual División A; y Carlos Bonorino Udaondo. Entre 2010 y 2014 se desempeñó como Secretario Académico de la Facultad de Medicina el médico clínico de la División C, Dr. Marcelo Torino. En la actualidad, el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas es el Prof. Dr. Luis Ignacio Brusco y la Vice-Decana la Prof. Dra. Claudia Negri —ambos pertenecientes a nuestro Hospital—, siendo esta última, además, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos asumieron la conducción de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA el 1.º de agosto de 2022, para el ciclo 2022-2026, renovando consecutivamente sus cargos de Decano y Vicedecana para el período 2026-2030. En paralelo a la gestión universitaria, la Dra. Negri expandió su rol institucional al ingresar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10 de diciembre de 2025, con un mandato que se extiende hasta el 9 de diciembre de 2029.

A lo largo de su historia, en el Hospital han funcionado y siguen funcionando Cátedras y Jefaturas de Cátedra correspondientes a las diversas carreras de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina, constituyendo un legado docente de gran valor y testimonio vital de la importancia que ha tenido la institución en la formación de generaciones de jóvenes en el conocimiento del arte y la técnica de las distintas ramas de las ciencias de la salud. Vaya el reconocimiento de este libro a los miles de docentes —en su mayoría anónimos en estas páginas— que se han entregado con pasión a la tarea docente durante más de ciento cincuenta años junto a la Universidad de Buenos Aires.

A la par de la docencia, la investigación ha ocupado siempre un lugar central en la vida del Hospital. Cabe destacar que el Ramos Mejía es, en la actualidad, la institución donde se lleva a cabo la mayor cantidad de protocolos de investigación de la Ciudad de Buenos Aires, lo que da cuenta de la solidez de su tradición científica y del compromiso de sus

servicios con la investigación clínica.

Universidad del Salvador

El Hospital es también, desde 1981, sede de las prácticas de los años superiores de la Carrera de Medicina de la Universidad del Salvador. Por sus salas pasaron como docentes de esta Facultad los Dres. Carlos Celso y Ángel Miguel Centeno, este último Vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador desde 1971 hasta su fallecimiento en 2006. El Dr. Carlos María Sanguinetti fue, asimismo, Titular de la Cátedra de Medicina Interna, en la que el Dr. Guillermo Márquez ostenta hoy el título de Profesor Emérito; en la actualidad el Dr. Alberto Guida es el Titular de dicha Cátedra. La Unidad Docente Hospitalaria de la Universidad del Salvador funcionó en nuestro Hospital hasta 1983.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 52

Asociaciones y Organizaciones Gremiales

A lo largo de su historia, el Hospital Ramos Mejía ha sido sede de la actividad de distintas organizaciones gremiales y profesionales que defendieron los derechos de quienes trabajan en sus salas, desde los médicos hasta el conjunto de los trabajadores de la salud.

Asociación de Médicos Municipales

Fundada el 20 de mayo de 1936, la Asociación de Médicos Municipales tuvo entre sus objetivos fundacionales la defensa de la salud pública, la estabilidad laboral, el escalafón profesional, condiciones dignas de trabajo y una remuneración acorde a las tareas realizadas. En las últimas décadas incorporó actividades culturales, deportivas y sociales para médicos activos y jubilados, así como la prevención y cobertura de riesgo legal por praxis médica. Cuenta hoy con más de 13.000 afiliados y posee personería jurídica. No existen registros de los presidentes de la Filial correspondientes a los períodos 1987-1989 y 1989-1993. Entre 1993 y 1997 presidió la Filial el Dr. Alberto Caniparoli, sucedido por el Dr. Juan José Borria entre 1997 y 2001, reelegido hasta 2005. Entre 2005 y 2009 asumió el Dr. Carlos Rojo, reelegido para los períodos 2009-2013 y 2013-2017; lo sucedió el Dr. Pablo Ghigliazza entre 2017 y 2021, reelegido al frente de la Filial para el período 2022-2026.

Constituye un motivo de particular orgullo para nuestro Hospital que la conducción central de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la Ciudad de Buenos Aires —la máxima representación gremial de los médicos municipales, que nuclea a más de 13.000 profesionales— se encuentre a cargo del Dr. Carlos Rojo, una figura surgida de la propia Filial del Ramos Mejía, que él mismo presidió entre 2005 y 2017. Electo Presidente de la Asociación de Médicos Municipales desde 2022, primero para el período 2022-2026, fue luego reelegido para conducir el Comité de Presidencia durante el período 2026-2030, ejerciendo así la titularidad de una de las entidades gremiales más importantes del ámbito de

la salud de la Ciudad.

Federación de Profesionales de la Salud No Médicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El 28 de julio de 1987 se constituyó la Federación de Profesionales de la Salud de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, como entidad gremial de segundo grado en representación de las distintas asociaciones no médicas que se nuclearon en ella: farmacéuticos, asistentes sociales, odontólogos, sociólogos, bioquímicos, fonoaudiólogos, nutricionistas dietistas, psicopedagogos, obstétricas, kinesiólogos y psicólogos, entre otras especialidades. El 10 de abril de 1990 se redactó el Reglamento del Sistema Solidario para la Defensa en Juicios de Responsabilidad Profesional. En julio de 1991 la Federación publicó por primera vez "El Profesional Municipal" como órgano informativo, retomando su difusión en julio de 1995. El Hospital cuenta con dos delegados ante la Federación y dos delegados del Hospital ante cada Asociación de Profesionales no médicos.

SUTECBA

En 1916 se creó la Unión de Obreros Empleados Municipales (UOEM), gremio que durante largo tiempo permaneció intervenido y sin elecciones de sus representantes; las primeras elecciones democráticas se realizaron recién con el advenimiento de la democracia, en 1987. En 1994 la organización pasó a denominarse SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires), el único gremio reconocido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para discutir paritarias y demás derechos de los trabajadores, y el que ha ganado todas las elecciones gremiales celebradas en el Hospital en defensa de los derechos laborales.

ATE

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se fundó el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de Buenos Aires, obteniendo personería jurídica en 1937; reúne a trabajadores del Estado nacional, provincial y municipal. En el Hospital comenzó su actividad gremial en 2004, con compañeros como Diocares, Manuel Andía y Jorge Torres, entre otros, logrando una afiliación masiva. El 21 de abril de 2005 se realizaron elecciones que confirmaron a Diocares como delegado general; tras su fallecimiento en 2018, Jorge Torres y Daniel Dib asumieron como delegados. ATE impulsó reclamos en defensa de la carrera profesional de enfermería —incluido el amparo por la Ley 6035— y, durante la pandemia, proveyó elementos adicionales de protección personal y promovió diversos amparos. Continúa hoy reclamando en beneficio de los trabajadores de la salud, contando en la actualidad con una Junta Normalizadora.

Agradecimiento: A los Dres. Pablo Ghigliazza y a la Lic. Graciela Gramsci por su colaboración en la redacción de las secciones sobre la Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud No Médicos; al Sr. Hugo Monzón por el relato sobre SUTECBA; y al Lic. Javier Izaguirre y al Sr. Jorge Rachid por el relato sobre ATE.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 53

Revistas y Órganos Científicos de Difusión: Jornadas Científicas

Entre mayo de 1929 y 1933, la Agrupación de Practicantes del Hospital Ramos Mejía —presidida por el Dr. A. O. Tachella— publicó mensualmente, en formato de diario, "El Ramos Mejía". Sus números, hoy archivados en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, recogían entrevistas a profesionales de los distintos servicios y a médicos extranjeros que visitaban el Hospital, sistemáticas de patologías, noticias docentes sobre las clases por darse, y también notas de tono más distendido. Sus páginas reflejan, entre otras cosas, los jefes de sala del Hospital en 1929, los conferencistas de ese año y el organigrama completo de los servicios hospitalarios de la época.

EL
HOSPITAL RAMOS MEJIA
DE NUESTRO DIRECTOR
PRESENTACIÓN
INVITACIÓN
SUMARIO

Figura 53.1: Primer número de "El Ramos Mejía" (mayo de 1929).

La propia Maternidad "Dr. Eliseo Cantón" tuvo, además, su propia revista de investigación y comunicación. Por indicación del Prof. Dr. Rafael Bullrich, y bajo la dirección del Dr. Blas Moia —responsable de la Sección Gastroenterología— y del Dr. Braun Menéndez —responsable de la Sección Cardiología—, comenzaron a publicarse en la década de 1930 los "Archivos Médicos del Hospital Ramos Mejía", que con el tiempo darían origen a la Revista Argentina de Cardiología.

En 1996 apareció el primer número de la Revista del Hospital en formato físico, publicación que se mantuvo hasta el año 2000. A partir de 2003 retomó su aparición de manera ininterrumpida, disponible para su descarga electrónica desde la página web del Hospital hasta el presente, habiendo alcanzado ya el

volumen XXV.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 54

El Arte y Nuestro Hospital

En el Hospital habitan muchas obras de arte, más allá de las de su propia arquitectura. Pinturas, esculturas y bustos distribuidos por sus patios, salas y aulas dan testimonio de una historia que se entrelaza con la de la medicina argentina y con la de algunos de sus artistas más notables.

Del lado izquierdo de la entrada de Urquiza 609 se encuentra el busto del Dr. José María Ramos Mejía, obra del pintor y escultor argentino José Fioravanti (Buenos Aires, 1896 – Buenos Aires, 1977). Fioravanti fue autor de numerosas esculturas célebres, entre ellas el Monumento a Nicolás Avellaneda, el de Roque Sáenz Peña, el de Simón Bolívar y el del Kilómetro 0 —todos en Buenos Aires—, los Lobos Marinos de Mar del Plata y el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, entre muchos otros. Su busto de Ramos Mejía preside, desde la entrada, la memoria del fundador y primer director del Hospital.

Figura 54.1: Busto del Dr. José María Ramos Mejía, en la entrada de Urquiza 609, obra del artista argentino José Fioravanti.

Los cuadros de Fantuzzi

Roberto Fantuzzi (Reggio Emilia, 1899 – Caracas, 1976) fue un pintor italiano formado en la Academia de Bellas Artes de Florencia, que en 1918 se trasladó al Río de la Plata. Allí se convirtió en un retratista muy solicitado, en especial por médicos que, junto a sus discípulos, encargaban cuadros colectivos para homenajear a los maestros de hospitales y cátedras. Su estilo neoclásico privilegiaba las escenas grupales, de composición equilibrada y rigurosa precisión anatómica; como debía pintar a todos

con guardapolvo blanco, para romper la monocromía solía incorporar a alguna persona vestida de civil o algún objeto oscuro que hiciera contraste. Más tarde regresó a Italia —donde pintó para hospitales y para la corte papal— y luego se estableció en Venezuela. Las obras que dejó en el Hospital Ramos Mejía constituyen un testimonio plástico de gran valor documental, social y evocativo.[59]

1. «Una lección de clínica médica»

Figura 54.2: "Una lección de clínica médica", de Roberto Fantuzzi, con el Prof. Rafael Augusto Bullrich.

Este cuadro se encuentra en la planta baja del pabellón de Clínica Médica, en el despacho del jefe de servicio. Representa una lección clínica del Prof. Rafael Augusto Bullrich, tal vez en el curso de una revista de sala: la tela muestra una cama de hospital ocupada por un paciente de notable delgadez, en cuya cabecera —a la derecha del espectador— un maestro explica el caso a un nutrido grupo de colaboradores.

2. «Operación cesárea» (1921)

Óleo inspirado en el Prof. Dr. Enrique Zárate (1870 – 1962), Profesor Titular de la Cátedra de Clínica Obstétrica del Hospital Ramos Mejía. La escena lo representa en la Maternidad "Eliseo Cantón", acompañado por colegas y discípulos, entre ellos Víctor Widacovich, Palacios Costa y Trongé.

Figura 54.3: "Operación cesárea" (1921), de Roberto Fantuzzi, inspirada en el Prof. Dr. Enrique Zárate en la Maternidad "Eliseo Cantón".

Enrique Zárate fue uno de los referentes de la obstetricia argentina. Como joven practicante, en 1892 participó junto al Dr. Alfredo Lagarde y a la Dra. Cecilia Grierson en la primera cesárea exitosa realizada en la Argentina. Años más tarde introduciría la llamada sinfisiotomía de Zárate, una técnica subcutánea, menos invasiva, y fue presidente fundador de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires. El cuadro se encuentra hoy en el Museo Central de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

3. «Cirugía abdominal» (1932)

Ubicado originalmente en el aula de ginecología del Hospital Ramos Mejía, este óleo muestra una intervención abdominal, con el cirujano principal asistido por colegas, una enfermera sosteniendo el aparato de anestesia por éter y numerosos médicos que observan el procedimiento. El cuadro fue identificado como un homenaje al Prof. Osvaldo Luis Bottaro (1881 – 1950), jefe del Servicio de Clínica Ginecológica y Cirugía Abdominal (véase el capítulo de Ginecología y Obstetricia).

Figura 54.4: "Cirugía abdominal" (1932), de Roberto Fantuzzi, homenaje al Prof. Osvaldo Luis Bottaro.

Bottaro se formó en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires y en 1924 asumió como jefe del servicio en el Hospital San Roque —hoy Ramos Mejía—, donde ejerció gran parte de su docencia universitaria y clínica. En 1943 sus discípulos editaron un Libro de Oro en su homenaje, que incluía colaboraciones de figuras destacadas como Bernardo Houssay. El óleo de Fantuzzi, firmado y fechado en 1932, habría sido realizado con motivo de los veinticinco años de su graduación, y constituye un registro fiel de la práctica quirúrgica y de la vida académica del Hospital.

4. «Una intervención quirúrgica»

Figura 54.5: "Una intervención quirúrgica" (detalle), de Roberto Fantuzzi, cuya figura central es el Prof. Carlos Robertson Lavalle.

Este cuadro se encuentra en el pabellón de cirugía. Su figura central es el Prof. Carlos Robertson Lavalle, y entre el grupo de observadores se cuentan algunas figuras de renombre, como Iván Goñi Moreno y Enrique Votta, jefe de clínica de la entonces Sala VI de cirugía.

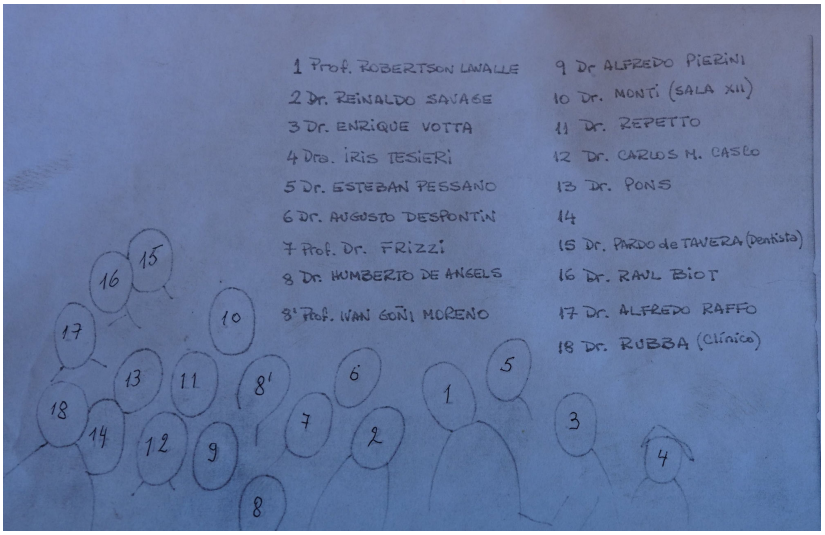


Figura 54.6: Reverso del cuadro con la descripción de los representados.

Capítulo 55

Política y Nuestro Hospital

Ya se ha señalado en otras partes de esta obra que diferentes miembros de nuestra comunidad médica hospitalaria participaron en la fundación del Partido Socialista, en especial el Dr. Juan B. Justo —que fue su presidente hasta su muerte, en 1928—, junto a Nicolás Repetto, Enrique Cronwell y José Ingenieros, entre otros. El Dr. Julio Cruciani, Jefe del Servicio de Alergia, también militó en el socialismo y escribió un libro sobre las relaciones entre la Biología y el Socialismo (véase el capítulo dedicado a la literatura).

Algunos años más tarde, un hecho luctuoso vinculó nuevamente al Hospital con la vida política del país: el intento de asesinato del senador Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación. En julio de 1935, el senador demócrata progresista, tras la firma del Pacto Roca-Runciman, denunció a empresas británicas por fraude y evasión impositiva —los frigoríficos Anglo, Armour y Swift— y aportó pruebas que comprometían seriamente a dos ministros del entonces presidente Agustín P. Justo: Federico Pinedo, de Hacienda, y Luis Duhau, de Agricultura. El informe revelaba el trato preferencial que recibían estas empresas, que prácticamente no pagaban impuestos y a las que nunca se inspeccionaba.

El 23 de julio de 1935, en pleno debate, un matón del Partido Conservador —el ex comisario Ramón Valdez Cora— atentó contra De la Torre. Junto al estrado de la presidencia, Valdez Cora sacó un revólver y abrió fuego hacia el grupo formado por el senador, que aún no se había incorporado, y sus amigos, que corrieron en su auxilio. Los proyectiles hirieron mortalmente al senador Enzo Bordabehere —amigo y compañero de bancada de De la Torre, senador nacional por la provincia de Santa Fe—, hirieron levemente en el pecho al diputado santafesino Manzini y alcanzaron en una mano al ministro Duhau, que cayó sobre su pupitre fracturándose varias costillas. Bordabehere fue trasladado a la Guardia de nuestro Hospital, donde falleció.

La vinculación de miembros del Hospital con la vida pública se prolonga hasta la actualidad: la Prof. Dra. Claudia Negri, perteneciente a nuestra institución, se desempeña hoy como legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Capítulo 56

La Literatura y Nuestro Hospital

Detallamos a continuación los principales referentes de nuestro Hospital que se destacaron, además de en su labor profesional, en la producción literaria de nuestro país.

José Ingenieros (1877 – 1925) se recibió de farmacéutico en 1897 y de médico en 1900, con su tesis "Simulación en la lucha por la vida"; para esa época ya era conocido en los círculos literarios. Desde 1897 dirigió, junto a Leopoldo Lugones, el diario "La Montaña" —periódico que se autodenominó "socialista revolucionario"—. Fue fundador del Partido Socialista, aunque nunca llegó a ser miembro orgánico. En 1903 la Academia Nacional de Medicina lo premió por "Simulación de la locura". Fue nombrado jefe de la Clínica de Enfermedades Nerviosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y, en 1904, ganó la suplencia de la cátedra de Psicología Experimental en la Facultad de Filosofía y Letras. Se convirtió en un destacado miembro de la Cátedra de Neurología a cargo de José María Ramos Mejía y del Servicio de Observación de Alienados de la Policía de la Capital, del cual llegó a ser director. Entre sus principales obras literarias se cuentan "El hombre mediocre", "Los tiempos nuevos", "Histeria y sugestión", "Sociología argentina", "Principios de psicología", "Los precursores: Sarmiento, Alberdi y Echeverría" y "Las fuerzas morales"; sus libros, de carácter más sociológico, fueron lectura obligada de varias generaciones de argentinos.

Juan Bautista Justo (1865 – 1928) fue médico, periodista, político, parlamentario y escritor argentino. Fundador del Partido Socialista —que presidió hasta su muerte—, del periódico "La Vanguardia" y de la cooperativa El Hogar Obrero, se desempeñó como diputado y senador nacional. Como escritor se dedicó al ensayo político y social; su obra principal es "Teoría y práctica de la historia", a la que se suman "El socialismo argentino", "Socialismo e imperialismo" y "La Internacional Socialista", entre otras.

Francisco Anselmo Sicardi (1856 – 1927) fue un médico y escritor argentino. Se recibió de Licenciado en Farmacia en 1880 y de Médico en 1883. En 1898 se creó la cátedra de Clínica Médica, de la que fue designado titular, y en 1911 fue nombrado académico de la Academia Nacional de Medicina; entre ese año y 1914 fue, además, consejero de la

Facultad de Medicina. Su trabajo como médico lo puso en contacto con los suburbios de Buenos Aires, experiencia que volcó en su obra "Libro extraño" —cinco tomos publicados entre 1894 y 1902—, una de las primeras manifestaciones de la corriente del naturalismo argentino. Otras de sus obras fueron "Pérdida", "Un anónimo más", "Horas de evolución", "La inquietud humana" y diversas piezas de teatro.

El Dr. Julio Cruciani (1898 – 1949) fue un destacado médico argentino que fundó y dirigió el Servicio de Enfermedades Alérgicas del Hospital Ramos Mejía, el primer servicio público del país en esa especialidad. Además de su labor como investigador científico, tuvo una activa militancia en el socialismo y plasmó su pensamiento político e ideológico en diversos ensayos, entre los que sobresalen "Biología y socialismo" (1936) y "Ciencia y revolución". En su homenaje, el pabellón de Alergia del Hospital lleva su nombre.

La escritora argentina Selva Almada, nacida el 5 de abril de 1973 en Villa Elisa (Entre Ríos), trabajó en el Hospital Ramos Mejía durante la década de 2000. Tras mudarse a Buenos Aires al comenzar el milenio —y desempeñarse previamente en el Hospital Durand—, la autora entrerriana ingresó como administrativa en el Ramos Mejía, donde permaneció varios años cumpliendo tareas en la farmacia y en el depósito de medicamentos y material descartable. Esta etapa laboral coincidió con sus inicios en la edición independiente, un período clave en el que dio vida a sus primeras obras, como el poemario "Mal de muñecas" (2003) y el libro de relatos "Niños" (2005), antes de dedicarse de lleno a su carrera literaria.

BORRADOR — NO EDITADO

Capítulo 57

El Tango y Nuestro Hospital

Detallamos a continuación la interrelación que hubo entre nuestro Hospital y distintos compositores, cantantes y directores de orquesta de tango, así como algunos eventos sociales célebres, como los Bailes del Internado.

Carlos Gardel, el cantante de tango más conocido del mundo y emblema del género en la Argentina y el Uruguay, protagonizó uno de los episodios más recordados de su relación con nuestro Hospital. En la madrugada del 10 al 11 de diciembre de 1915 —tendría entonces entre veinticinco y treinta y dos años— recibió un balazo en un confuso episodio. El hecho ocurrió en torno al Palais de Glace, el salón de la calle Posadas 1725 que por aquellos años competía con el Armenonville; en 1915 su amplio salón circular era un sitio de baile de moda entre los "patoteros" de entonces, jóvenes de la *high life* que descargaban su fuerza con agresiones al prójimo. Razzano, en cambio, prefería el Armenonville, más serio y tranquilo.

Figura 57.1: Carlos Gardel (derecha) visitando a un amigo convaleciente.

Unas versiones afirman que el incidente comenzó en el Palais de Glace; otras, que fue camino al Armenonville. También discrepan sobre qué desencadenó la gresca: si una cuestión de amoríos de Gardel, la mirada indiscreta de Razzano hacia una dama o un entredicho de Alippi con un integrante de la patota de muchachos cajetillas —apodado "El Gallego"— que, tras cruzarles el automóvil, disparó sobre Carlos Gardel. Trasladado a nuestro Hospital, se comprobó que la bala había quedado alojada en la base del pulmón izquierdo, a un centímetro del corazón; los médicos consideraron más peligroso extraer el proyectil que dejarlo.

Felipe Pigna, en su libro *Gardel*, relata que, cuando su madre, doña Berta Gardes, fue a verlo al nosocomio, Gardel dijo en lunfardo a Roberto Casaux: "¡Araca! ¡La javie...! Un

yobaca, ¿la manyás?", y a Berta todos le aseguraron que su hijo había recibido la patada de un caballo. El hecho apareció en la crónica policial de los diarios *La Prensa* y *La Razón* ("Agresión a Gardel"), donde se señaló como agresores a un tal Roberto Guevara —autor del disparo— y a Moreno Gallegos Serna, probables hombres del bajo mundo; a este último lo mencionaría Eduardo Arolas al dedicarle su tango "Suipacha". Las causas y los sucesos posteriores a la agresión permanecen confusos.[62]

Figura 57.2: Alberto Castillo (Dr. Alberto Salvador De Luca).

Otra relación célebre entre el tango y el Hospital es la del Dr. Alberto Salvador De Luca (1914 – 2002), universalmente consagrado en la cultura popular como Alberto Castillo, "el cantor de los cien barrios porteños". Se recibió de médico ginecólogo en la Universidad de La Plata y, mientras su carrera musical se disparaba en las décadas de 1930 y 1940 junto a la orquesta de Ricardo Tanturi, siguió ejerciendo la profesión: en el Hospital Ramos Mejía se desempeñó como médico ginecólogo y Jefe del Museo de la Maternidad "Dr. Eliseo Cantón". Durante años mantuvo una curiosa doble vida: por las tardes atendía rigurosamente, con su guardapolvo blanco, bajo su verdadero apellido (De Luca), y por las noches se transformaba en el arrollador y engominado Alberto Castillo que hacía delirar a las multitudes tangueras. Con el tiempo, la masiva fama se volvió incompatible con las consultas médicas, lo que lo obligó a volcarse por completo a los escenarios.

La mística tanguera del Hospital Ramos Mejía encuentra su lazo más íntimo en la figura de Enrique Santos Discépolo, nacido el 27 de marzo de 1901 en la calle Paso 111, a muy pocas cuadras de la Plaza Miserere y del propio hospital. Habiendo crecido al pulso de Balvanera, el célebre poeta, dramaturgo y compositor frecuentaba la institución debido a su estrecha amistad con varios de sus profesionales. De hecho, entre los mitos urbanos del Ramos Mejía, los médicos de épocas pasadas transmitían la entrañable anécdota de que "Discepolín" se inspiró en las vivencias, las guardias y el doloroso ambiente hospitalario para delinear algunos de los perfiles melancólicos, escépticos y marginales presentes en sus letras más famosas.

Los Bailes del Internado

En 1902, el estudiante Salvador Debenedetti, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, con tan solo dieciocho años, propuso que el 21 de septiembre se celebrara el "Día de los Estudiantes". Eligió esa fecha en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, ya que el 21 de septiembre de 1888 habían arribado a Buenos Aires los restos del educador argentino desde Asunción del Paraguay, donde había muerto el 11 de septiembre. Años más tarde, en enero de 1908, el Primer Congreso de Estudiantes Sudamericanos,

reunido en Montevideo, estableció esa fecha para celebrar su día. En un principio los desfiles no fueron exclusivos de Medicina; fueron los estudiantes quienes organizaron el primer baile en el Palais de Glace, el 24 de septiembre de 1914. A partir de 1915, la Federación Universitaria se ocupó de concentrar a los estudiantes en distintos puntos de encuentro: en el Tigre los de Derecho y Ciencias Económicas, en Bernal los de Farmacia, en los teatros Apolo, Victoria y Onrubia y en el restaurante Santini los de Arquitectura, y en la vía pública en general, por donde desfilaban las carrozas.

Figura 57.3: Primer Baile del Internado, 1915. *Colección César Gotta.*

El violinista Francisco Canaro ("Pirincho", 1888 – 1964) se erigió como director de la orquesta "Quinteto Francisco Canaro" a partir del primer "Baile de los Internados", a pedido de médicos y practicantes, y estrenó el tango milonga "Matasano" —en 1914, en el Palais de Glace— dedicado a los internos del Hospital Durand. Estos eventos sostenían una puja entre los practicantes, quienes, con un despliegue de disfraces que a veces incluían partes de cadáveres, hacían una gran cantidad de bromas estrambóticas y hasta aterradoras que horrorizaban a muchos de los asistentes. En ellos el tango jugaba un rol casi único, a punto tal que grandes compositores y músicos de entonces trabajaban en temas relacionados con todas las vertientes de la medicina para estrenarlos en esas noches de "farras".

El Dr. Luis Alposta, en su libro "Los bailes del Internado",[61] cuenta que el 21 de septiembre de 1915 el señor Loudet, presidente del Círculo Médico Argentino y del Centro de Estudiantes de Medicina, dispuso reunirse en un banquete "al estilo de los universitarios franceses". En esa oportunidad se designó por unanimidad a Ricardo Rojas para dar los discursos, y este leyó un extenso poema dedicado a la juventud que, un año antes, "al no ver brillar nada nuevo bajo el sol, decidió ponerle luces propias al baile del Internado, recurriendo al tango". El Internado —los practicantes de medicina— constituyó, desde el punto de vista humanitario, una gran ayuda para aquellos estudiantes que encontraron en los hospitales casa, comida y hasta un pequeño sueldo, como mínima compensación a sus esfuerzos y desvelos.

El Internado era un cargo obtenido mediante una escrupulosa selección. Los internos eran elegidos entre cientos de estudiantes que habían prestado servicios gratuitos durante mucho tiempo: tres meses en el consultorio de vacuna, un año como practicante externo de laboratorio, un año como practicante externo de sala y un año como practicante interno de sala. Solo al quinto año, y por estricto concurso que contemplaba la antigüedad antes citada y las notas de los exámenes, se accedía al puesto.

Los bailes siguientes (1915-1924) se realizaron en el complejo llamado Pabellón de las Rosas, un edificio de dos plantas rodeado de un amplio jardín, situado en Tagle entre la Av. Alvear (actual Av. del Libertador) y la Av. Centenario (actual Av. Figueroa Alcorta), lugar estrechamente ligado a la consolidación de la Guardia Vieja del tango (Osvaldo Fresedo, Vicente Greco, Roberto Firpo, Augusto Berto, Eduardo Arolas, Ricardo Luis Brignolo, Samuel Castriota, Francisco Canaro, David "Tito" Roccatagliata y Juan Maglio "Pacho"). Fueron en total once bailes entre 1914 y 1924, a los que puso fin un hecho de sangre ocurrido en el Hospital Piñero. El último de estos festejos se organizó el 21 de septiembre de 1924 en el Teatro Victoria, donde Fresedo estrenó su famoso tango "El once".

Tangos dedicados a Nuestro Hospital

«El Apronte»

"El Apronte", tango milonga, fue el segundo tango milonga del primer "Baile de los Internados" de Buenos Aires. Compuesto e interpretado en el Palais de Glace por Roberto Firpo (1884 – 1969) y su orquesta, está dedicado a los internados del Hospital San Roque. Fue grabado para Disco Nacional-Odeón el 7 de octubre de 1931.

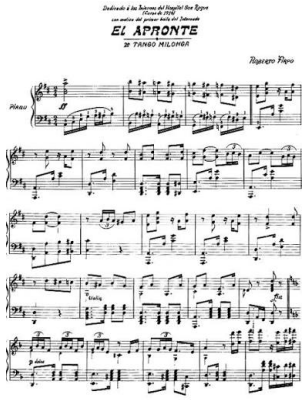



Figura 57.4: Partitura del tango "El Apronte".

«Hospital San Roque»

En 1917, el Quinteto Criollo "Garrote" —seudónimo de Vicente Greco— grabó el tango "Hospital San Roque" para el sello Atlanta, bajo el número 176. Vicente Greco (1886 – 1924) se instaló inicialmente en los bares y salones del popular barrio de La Boca, uno de los principales barrios de inmigrantes de Buenos Aires, y fue conocido con el seudónimo "Garrote". Fue también el primer músico tanguero contratado para inaugurar el salón Armenonville, en 1911, cabaré que se constituyó en uno de los principales centros de difusión del tango. Escribió su primer tango, "El morochito", en 1905; el famoso cantante Carlos Gardel era su amigo personal.

Figura 57.5: Disco del tango "Hospital San Roque", del Quinteto Criollo "Garrote" (sello Atlanta, 1917).

«El Internado»

"El Internado", de Francisco Canaro, estrenado según algunas fuentes en el segundo baile (1915) por Canaro y su orquesta, estuvo también dedicado a los internados del Hospital San Roque.

BORRADOR — NO DEFINITIVO

Capítulo 58

La Comisión de la Memoria y los Desaparecidos

Desde el año 2000 funciona en el Hospital la Comisión de la Memoria, reconocida por la Legislatura. Con la misión de mantener activa la memoria, se recuperaron los legajos de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. En el hall de entrada del Hospital se colocó una placa recordatoria por cada uno de los ocho trabajadores de la salud desaparecidos. Ellos son:

- Eleonora Cristina Álvarez, empleada administrativa.
- Jorge Donato Calvo, médico residente de Cirugía de segundo año.
- Teresa "Peti" Lajmanovich, concurrente en Hematología.
- Pablo Limber, delegado gremial y trabajador del Laboratorio Central, sector Parasitología.
- Alicia Noemí Zimman, alumna de la Unidad Hospitalaria.
- Norma Leiva, jefa de residentes de Anatomía Patológica.
- María José Marzoca, técnica de Laboratorio.
- Eduardo Miguel O'Neill, médico de Neurología y docente de la Facultad de Medicina.

A su memoria se suma el testimonio de Hilda Parisier, médica clínica y de medicina nuclear, que se desempeñaba en Clínica Médica. Fue desaparecida en 1976 y torturada en el Centro de Detención y Torturas "El Vesubio", y luego liberada. Declarada prescindente en 1978, falleció en 1983, a los 57 años.

Capítulo 59

Directores y Vice en la Historia

No existe en el Hospital un registro escrito de la nómina consecutiva de Directores y Subdirectores desde su fundación hasta la actualidad. A través de distintas fuentes cruzadas se ha intentado reconstruir los años de gestión y la identidad de cada uno de ellos; los editores de este libro advierten que, debido a la falta casi total de documentación escrita, es posible que se hayan deslizado errores involuntarios, que esperamos puedan corregirse en futuras ediciones. A pesar de estas limitaciones, se considera importante dejar constancia de la lista de quienes encabezaron la Dirección de nuestro querido Hospital a lo largo de su historia.

Lazareto San Roque (1869-1883)

Dr. Pedro A. Mattos; Dr. Salvador Doncel; Dr. Julián Fernández (hijo); Dr. Julián Aguilar; Dr. Telémaco Susini; Dr. Enrique Revilla.

Hospital San Roque (1883-1914)

Dr. José María Ramos Mejía (1883-1887); Eduardo Wilde (1887-1889); Juan B. Justo (1889-1890); Nicolás Repetto (1890-1892); Rafael A. Bullrich (1892-1895); Julio Méndez (1895-1898); Francisco Sicardi (1898-1901); Ricardo Nötling (1901-1904). Entre 1904 y 1914 no se cuenta con registros historiográficos comprobados de quienes estuvieron a cargo de la Dirección Médica del Hospital.

Hospital Ramos Mejía (1914 hasta nuestros días)

Pedro Chutro (1916-1918); Gregorio Aráoz Alfaro (1916-1918); Arturo Oñativia (1918-1922); Carlos Bonorino Udaondo (1922-1928); Delfor del Valle (h), interino en 1929; Carlos Robertson Lavalle (1929-1943).

A partir de 1956 se sucedieron en la Dirección, sin que se cuente siempre con las fechas exactas de cada gestión: Francisco Cobo, Juan Piñeiro, Félix Muñoz, Antonio Ibarguren y Eduardo Centeno. Continuaron luego José Luis Ayerza (1956), Emilio Bacigalupi (1960), Adrián Riquebourg (1965), Pedro Mésigos (1966), Vicente Mazzáfero (1972-1973), y Cudemo y Franklin Lucero (1973). En 1976 ejerció como Director Asistente el Dr. Galaburri, sucedido por el Dr. Fernández Mendiondo y luego por el Dr. Julio Granados. Le siguieron Helios Gugliotella (1986) y Andrés Arcángel Dubosc (1988).

En 1990 asumió como Subdirector a cargo de la Dirección el Dr. Abel Luis Agüero; en 1992, Marcelo Leónidas Castillo; en 1994, Carlos Igarzábal; en 1997, Abel Citadino; en 2000, el Dr. Olmedo; en 2002, el Dr. Alejandro Chikiar; y en 2004, el Dr. Ricardo Rezzónico. En 2009 asumió el Dr. Eduardo Seoane, junto a la Subdirectora Bou Pérez; le sucedió el Dr. Pascuchelli y luego el Dr. Carlos Mercau, junto al Subdirector Alejandro Muñoz, hasta 2012. En 2015 la Dra. Bou Pérez asumió como Subdirectora; en 2016 el Dr. Eduardo Seoane ocupó el cargo de Subdirector hasta marzo de 2017, momento en que asumió el Dr. Alejandro Muñoz hasta agosto de ese año. Desde 2017 la Dirección está a cargo del Dr. Hugo Pandullo, junto al Subdirector Juan Pablo Rossini, quien se acogió a la jubilación en junio de 2026; el Dr. Pandullo continúa al frente de la Dirección hasta la actualidad.

Comités que Funcionan en la Actualidad en el Hospital

En el Hospital funcionan diversos comités, creados para responder de manera más ejecutiva y rápida a demandas específicas, varios de ellos interdisciplinarios y en actividad desde hace más de treinta años. Entre ellos se cuentan el Comité de Docencia e Investigación (a cargo, en la actualidad, del Secretario Dr. Nicolás Alonso, cargo que en el pasado ocuparon los Dres. Carlos Igarzábal, Jorge González, Marcelo Torino y Leonardo Kogan); el Comité de Bioética Clínica (Secretaría: Lic. Daiana); el Comité de Investigación Clínica (Secretario: Lic. Leonardo Perelis); el Comité de Prevención de Violencia; el Comité de Control de Infecciones (Secretario: Dr. José Bruguera); el Comité de Heridas; el Comité de Tumores (Secretarias: Dra. Alicia Elli y Valeria Pacchioli); el Comité de Calidad (Secretaría: Dra. Marta Ascorti); el Comité de Residuos Patológicos (Secretarías: Lic. Hilda Fernández y Lic. Gabriela Razzitte); el Comité de Seguimiento de Pacientes Trasplantados; y varios comités dedicados a patologías oncológicas específicas, como los de mama, recto, urológico y neuroquirúrgico.

Bibliografía

1. Wilde, José Antonio. *Buenos Aires desde setenta años atrás.* Buenos Aires: Imprenta y Librería de Mayo de C. Casavalle, 1881.

2. Agüero, Abel Luis, e Isolabella, Marcos. "El cólera en la Argentina durante el siglo XIX". *Revista Argentina de Salud Pública*, 2018.

3. Fiquepron, Maximiliano. *Morir en las grandes pestes.* Buenos Aires: Siglo XXI, 2020.

4. Agüero, Abel Luis. "Origen del Hospital J. M. Ramos Mejía". *Revista del Hospital Ramos Mejía*, vol. III, n.º 2, 1996.

5. Ternavasio, Marcela. *Historia de la Argentina 1806–1852.* Buenos Aires: Siglo XXI, 2009.

6. Scenna, Miguel Ángel. *Cuando murió Buenos Aires. 1871.* Buenos Aires: Cántaro, 1974.

7. Doncel, Salvador. *La fiebre amarilla de 1871 observada en el Lazareto Municipal de San Roque.* Buenos Aires: Imprenta del Siglo, 1873.

8. Bonnahon, Angélica Aurea, y Tonelli, Laura Noemí. *Evolución y transformación del espacio hospitalario en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.* Tomo I. Buenos Aires: Dunken, 2013.

9. Visillac, Enrique F. *Pioneros de la salud: historia de los hospitales públicos de Ciudad de Buenos Aires.* Buenos Aires: Olmo, 2017.

10. Alonso, Nicolás. *Hospital Ramos Mejía: un recorrido histórico.* Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/salud/hospitales-y-establecimientos-de-salud/hospital-ramos-mejia/hospital-ramos-mejia-un-recorrido

11. Pergola, Federico. *Historia de la medicina argentina. Desde la época de la dominación hispánica hasta nuestros días.* Buenos Aires: Eudeba, 2014.

12. Oliva, Andrea A. "Asistencia pública y las primeras médicas: condiciones de atención, gestiones y prestaciones a fines del siglo XIX". *Revista Plaza Pública*, año 14, n.º 25, 2021, pp. 194–215.

13. *Revista del Hospital Ramos Mejía*. Buenos Aires: Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía, 1990.

14. Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. *Ordenanzas y Resoluciones sancionadas en el período de sesiones de 1914*. Buenos Aires: Talleres Gráficos Optimus, 1915. p. 89.

15. Penna, José, y Horacio Madero. *La administración sanitaria y asistencia pública de la Ciudad de Buenos Aires: estudio de los servicios de higiene y beneficencia pública, desde la época colonial hasta el presente*. Buenos Aires: Municipalidad de la Capital, Kraft, 1910.

16. Emery, J. D. C., y Young, P. "Oscar Celestino Croxatto (1911–1980) y su paso por nuestro Hospital". *Revista Fronteras en Medicina*, 2022, n.º 4, pp. 271–276.

17. Arlía, R., y Wikinski, J. "Homenaje al Dr. Juan Armando Nesi". *Revista Argentina de Anestesiología*, 1998, vol. 56, n.º 1, pp. 1–2.

18. Wikinski, J. "Homenaje al Dr. Juan Armando Nesi en su nonagésimo aniversario". *Revista Argentina de Anestesiología*, 1999, vol. 57, n.º 5, pp. 284–286.

19. González Varela, A. *Por el camino de la anestesia*. Buenos Aires: FAAA, 1.ª edición, 1996, pp. 393–396.

20. Lemus, J. D. *Áreas Programáticas. Conceptos de salud pública, epidemiología y atención primaria aplicados a la estrategia de distritos y sistemas locales de salud en las grandes ciudades.*

21. Centro Carlos Gardel. *Blog institucional.* Disponible en: https://centrocarlosgardel.blogspot.com

22. Demartini, A. J. *Historia de la Sociedad Argentina de Cardiología. Desde su fundación hasta el año 1969*. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Cardiología, 1987.

23. Elizari, M. V., y Aguinaga, L. "Argentina's most important contributions in the field of electrophysiology". *Heart Rhythm*, 2024, vol. 5, pp. 3–7.

24. Elizari, M. V. "Mauricio B. Rosenbaum and the Argentinian School of Electrocardiography". *Journal of Electrocardiology*, 2017, pp. 1–8.

25. Pecoraro, E. "Profesor Dr. Juan Carlos Milanese: su fallecimiento". *Revista del Hospital J. M. Ramos Mejía*, 2008, vol. 13, pp. 1–2.

26. Moratal Ibáñez, Laura. "Las instituciones hospitalarias a través de la historia". *Médicos y Medicinas en la Historia*, n.º 37. Disponible en: https://issuu.com/elguionediciones/docs/medicos_medicina-n_37

27. Universidad Pedagógica de Buenos Aires. "Educadores argentinos. Dr. José María Ramos Mejía: su biografía". Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/70951/jose-maria-ramos-mejia-1849-1914

28. Buzzi, Alfredo, y Gotta, Héctor. *Recuerdos fotográficos de nuestra medicina*. Tomo 2. Buenos Aires, 2013.

29. Academia Nacional de Medicina. Disponible en: https://anm.edu.ar/pdf/libros/Libro2FINAL.pdf

30. Veronelli, Juan C., y Veronelli Correch, Magalí. *Los orígenes institucionales de la Salud Pública en la Argentina*. Tomo 1. OPS, 2004.

31. Jardón, Magalí, y Toledo Ríos, Clara. "Los orígenes del Hospital San Roque: la labor de Ramos Mejía y José Ingenieros y el tratamiento de los accidentes histéricos". Disponible en: https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/45204

32. Acerbi Cremades, Norma. "Una mirada histórica". *Revista de Salud Pública*, ed. especial, pp. 68–71, nov. 2013.

33. "José María Ramos Mejía". *Descendientes de Francisco Ramos Mejía*. Disponible en: https://franciscoramosmejia.org.ar/web/RamosMejiaDescendientes.htm

34. "Origen del Hospital Ramos Mejía". *El arcón de la Historia Argentina*, junio de 2019. Disponible en: https://elarcondelahistoria.com/origen-del-hospital-ramos-mejia-1869/

35. Masquelet, M., y López Dusil, R. *Historias, relatos y leyendas de la Farmacia en la Argentina. Revista Fundación Pueblos*, Laboratorio Montserrat Éclair, s. f.

36. *Los orígenes del Hospital Ramos Mejía. ALMA Cultura & Medicina*, vol. 7, n.º 2, 2012. Editorial Alfredo Buzzi.

37. "La Farmacia Hospitalaria en Argentina". *Farmacia Hospitalaria*, Arán Ediciones, vol. 30, n.º 3, 2006, pp. 139–141.

38. Germino, N. E. "Hospital Ramos Mejía". *Periódico Primera Página*. Disponible en: http://primerapagina93.blogspot.com.ar/2014/03/hospital-ramos-mejia.html

39. Milanino, A. E.; Álvarez, G. C., y Agüero, A. L. "Cincuenta años de medicina en la Argentina (1950–2000). Análisis histórico y sus perspectivas futuras". *Revista del Hospital J. M. Ramos Mejía*, vol. XI, n.º 2, 2006.

40. Pinto, R. M.; Leon, C.; Mazzocco, N., y Scasserra, V. "Action of estradiol-17-beta at term and at onset of labor". *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, vol. 98, n.º 4, 1967, pp. 540–546.

41. Hidalgo, G.; Iparraguirre, B., y Kordich, L. "Contribución para la historia de la Hematología en Argentina y Sudamérica. Resumen de la creación y actividad de la Sala 18 de Enfermedades de la Sangre del Hospital Municipal Dr. J. M. Ramos Mejía, llamado más tarde Instituto Municipal de Hematología". *Hematología*, vol. 17, 2013, pp. 70–73.

42. Marrón-Peña, M. "Historia de la transfusión sanguínea". *Revista Mexicana de Anestesiología*, vol. 40, n.º 3, 2017, pp. 233–238.

43. García Ferrandis, X.; Palfreeman, L., y Leiva Pérez, A. de. "La transfusión de sangre en España: tecnologías médicas y retos sociales (1909–1943)". *Asclepio*, vol. 74, n.º 1, 2022, p. 580.

44. Sbarra, N. H. *Historia de la transfusión sanguínea.*

45. *Documento del Comité de Hematología, Oncología y Medicina Transfusional.* Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

46. Lemus, Jorge Daniel. *Historia y crónica de la Segunda Cátedra de Medicina Interna.* Premio Anual de la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, Asociación Médica Argentina.

47. Seoane, E. "Historia del Servicio de Neurocirugía". *Revista del Hospital Ramos Mejía*, vol. 13, 2008, pp. 1–15.

48. *Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes*, vol. 52, n.º 2, mayo-agosto de 2018, p. 68.

49. Aráoz Alfaro, G. *El libro de las madres. Manual práctico de higiene.* Cabaut, 1929.

50. *Archivos Argentinos de Pediatría*, año VII, noviembre de 1936, n.º 11.

51. Morquio, L. "La pediatría moderna en sus relaciones con la vida profesional". *Archivos Latinoamericanos de Pediatría*, año 2, 1906, n.º 11, pp. 397–416.

52. Terán, O. *Vida intelectual en Buenos Aires 1880–1910.* Fondo de Cultura Económica, 2000.

53. Zapiola, M. "Los niños entre la escuela, el taller y la calle. Buenos Aires 1884–1915". *Cuadernos de Pesquisa*, vol. 30, 2009, n.º 36, pp. 69–81.

54. Puga, T. "Reseña histórica de la pediatría latinoamericana". *Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría*, vol. 46, n.º 3, 2007, pp. 179–198.

55. Acerbi Cremades, N. "A dos siglos de la llegada a la Argentina de la vacuna contra la viruela. 1805–2005". *Revista de Salud Pública*, vol. 9, n.º 1, 2005, pp. 60–64.

56. *Todo es Historia*, n.º 117, febrero de 1977, p. 17.

57. Angelini, M. "Calendario Nacional de Vacunación: una política pública que distingue". Disponible en: https://www.garrahan.gov.ar

58. Di Liscia, M. S. *Marcados en la piel: vacunación y viruela en Argentina (1870–1910)*. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa.

59. Alonso, N. *Roberto Fantuzzi y sus obras en el Hospital Ramos Mejía*. Trabajo de investigación institucional, Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía".

60. Pacín, J. *Historia de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva*. Editorial Panamericana, Buenos Aires, junio de 2021.

61. Alposta, L. *Los bailes del Internado*. Buenos Aires.

62. Pigna, F. *Gardel*. Editorial Planeta, Buenos Aires, 2020.

63. Ibarguren, A. J. *Hospital Ramos Mejía. Reseña histórica y descriptiva del Hospital "San Roque"*. Buenos Aires, s. f.

64. Agüero, A., y Cabrera Fischer, E. I. *Manual de la Historia de la Medicina Argentina*. EdiAMA, 1.ª edición, Buenos Aires, 2014, 268 pp.

65. Alonso, N. "El Hospital Ramos Mejía". *Síntesis Comuna 3*. Disponible en: http://www.sintesiscomuna3.com.ar/amplia-nota.php?id_n=1020

66. Buzzi, A., y Pérgola, F. *Diccionario bio-bibliográfico de médicos argentinos*. Ediciones Médicas del Sur, 2010.

67. Piñero, A. G., y Trueba, C. M. *Balvanera y El Once*. Fundación Boston, 1996.

68. Niklison, J. "50 años de Cirugía Plástica". *Revista Argentina de Cirugía Plástica*, vol. 4, n.º 1, marzo de 1998.

69. Otaño Sahores, A. *Historia de la Ortopedia Argentina*. Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, 1.ª edición, Editorial Dunken, Buenos Aires, 2011, 96 pp.

70. Bonano, B. "Homenaje al Profesor Pedro H. Magnin". *Revista Argentina de Dermatología*, vol. 93, 2012, pp. 3–15.

71. Bartoloni, L. C.; Fraiman, H., y Allegri, R. F. "Evolución histórica de la Neurología Argentina". *Neurología Argentina*, vol. 4, 2012, pp. 67–78.

72. Cáneva, A. O., y Miller, J. C. *El Hospital Guillermo Rawson y su influencia en la Ortopedia y Traumatología Argentina*. Laboratorios Beta S.A., 1.ª edición, julio de 2012.

73. Foglia, V. "Discurso. Maestros de la Medicina". Sociedad Científica, 14 de junio de 1984.

74. Moreau, L. E. "Cien años de la Sociedad Argentina de Radiología". *Revista Argentina de Radiología*, vol. 81, 2017, pp. 181–183.

75. Rizzi, M. "Historia de los primeros cincuenta años de excelencia de la Sociedad Argentina de Otorrinolaringología en el centenario de su fundación". *Revista FASO*, vol. 18, 2011, pp. 68–80.

76. Mercau, C. "Hospital Ramos Mejía (1869)". *Revista de la Asociación Médica Argentina*, vol. 131, n.º 2, 2018.

77. Manigot, D. A. "Mauricio Rosenbaum (1921–2003)". *Medicina (Buenos Aires)*, vol. 64, 2004, p. 87.

78. Charreau, E. H. "Bernardo A. Houssay (1887–1971)". *Revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo*, vol. 53, 2016, pp. 1–4.

79. Asociación Médica Argentina. *Escuela Quirúrgica Finochietto.*

BORRADOR — NO DEFINITIVO